

AMATÖR PSİKANALİZİ

1926

Bu küçük yazının başlığı öyle ha deyince anlaşılacak gibi değil. Dolayısıyla açıklamam gerekiyor: Amatörlerle anlatılmak istenen hekim olmayanlardır, sorun da hekim olmayanların psikanatilik tedavi uygulamasında bulunmalarına izin verilip verilmemesi sorunudur. Bu sorun hem zamansal, hem yerel bir sınırlılık taşıyor. Zamansal sınırlılık taşıyor, çünkü kimin psikanaliz uygulamasında bulunacağını şimdiye kadar kendine dert edinen çıkmış değil. Evet, böyle bir sorun hiç mi hiç umursanmamış, ancak bir tek istekle birleşilmiştir, o da kimsenin böyle bir uygulamada bulunmaması. Bu istek içinde çeşitli nedenler öne sürülmüş ve bütün nedenlerin temelinde psikanalize karşı aynı nefret saklı yatmıştır. Bu bakımdan, yalnız hekimlerin psikanalize karşı takınılan yeni ve eskisinden daha dostça bir tutumun eseridir; bu tutum daha öncekinin sadece biraz değişik biçimi olduğu kuşkusundan yakasını kurtarabilirse tabii. Belli koşullarda psikanalitik tedaviye başvurulması gerekliliği teslim edilmekte, ancak bunu hasta üzerinde uy-

gulayacak kiřinin ille hekimlikten anlaması üzerinde direnmektedir.

Yerel sınırlılığa gelince, bu da sorunun bütün ülkelerce aynı önemde görülmeyişinden ileri geliyor. Almanya ve Amerika'da akademik bir tartışma konusundan başka bir şey değildir bu sorun, çünkü adı geçen ülkelerde her hasta canı istediğine gidip, canı istediği gibi tedavi ettirebilir kendini; adı geçen ülkelerde herkes "şarlatan hekim olarak" dilediği hastayı tedavi edebilir; yeter ki, davranışının sorumluluğunu yüklensin. Hasta tedaviden bir zarar görüp de tazminat isteğiyle yetkili makamlara başvurmamakça, yasalar işe el koymaz. Bu yazıyı kaleme alırken yaşadığım yer, ayrıca bu yazıyı kendisi için kaleme aldığım ülke Avusturya'da ise yasalar önleyici bir karakter taşır, hekim olmayanların hasta tedavi etmelerini yasaklar, tedavinin sonucunu bekleme gereksinmesini duymaz*.

Kısaca burada amatörlerin, yeni hekim olmayanların psikanaliz yöntemiyle hasta tedavilerine izin verilip verilmemesi sorunu pratik bir önem taşır. Ancak ortaya atılacak böyle bir sorunun, yasaların sözsel içeriği (lafzı) tarafından kesinlikle önceden çözümlendiği görülür: Nevrozlular hasta, amatörler hekimlikten anlamayan kimselerdir, psikanaliz ise nevrotik rahatsızlıklarda bir şifa yada bir düzelme sağlama yöntemidir; dolayısıyla bu tür bütün tedaviler hekimlerin yetkisi içerisinde, amatörlerin nevrozlular üzerinde psikanaliz tedavi uygulamasında bulunmasına izin yoktur, buna aykırı davranışlar ceza konusudur. Yasal durum işte bu kadar açık bir nitelik taşıdıktan sonra, amatör psikanalizi sorunu üzerine eğilmeyi pek göze alamıyor insan. Gelgelelim, ortada bazı karışık durumlar var ki yasalar bunlara pek aldırış etmemekte, dolayısıyla bunlar üzerinde durulması gerekmektedir. Belki bu konuya eğilen bir araştırmacı, nev-

Fransa'da durum başka türlü değildir.

rozluların başka hastalara benzemediğini, amatörlerle gerçekten beceriden yoksunluğunu ve ellerinde isteklerini haklı gösterecek nedenler bulunmadığını ortaya koyacaktır. Böyle bir şeyin gerçekliği tanıtlanabilirse, ilgili yasanın bir değiştirimden geçirilmeksizin amatör psikanalizi konusunda uygulanmasının haklı olarak istenebileceği anlaşılabacaktır.

I

Böyle bir isteğin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, psikanalitik bir tedavideki özellikleri tanımak gibi bir yükümlülüğü bulunmayan kişilere bağlıdır. Bize düşen ödev, henüz bu konuda bir bilgisi yok gözüyle baktığım bu tarafsızlara gerekli açıklamalarda bulunmaktır. Keşke elden gelse, onları böyle psikanatilik bir tedavinin dinleyicileri yapabilesek! Ne yazık ki, "psikanalitik tedavi uygulamasında" bir üçüncü kişinin varlığına yer yoktur. Öte yandan, psikanaliz tedavisindeki tek tek seanslar taşıdıkları önem ve değer bakımından hiç birini tutmaz, ragele bir seansa dinleyici olarak katılacak böyle yetkisiz bir kişi çokluk değerlendiremeyeceği bir izlenim edinecek, psikanalistle hasta arasında geçenleri anlamama gibi bir durumla karşı karşıya kalacak, o da olmadı sıkılacaktır. Dolayısıyla, ister istemez, bizim kendisine vereceğimiz ve elden geldiği kadar güvenilir bir hava içerisinde kaleme almaya çalışacağımız bilgilerle yetinmesi gerekecektir.

Diyelim bir hasta var da, ruh durumu dalgalanmalar geçilmekte, o da bunların bir türlü önünü alamamaktadır, ya da bir yılgınlık ve azimsizlik içerisinde bulunmakta, doğru dürüst hiç bir işe yaramayacağına inandığından kolu kanadı kırık durumda hisetmektedir kendini; ya da tutalım yabancılar arasında korkuyla karışık bir şaşkınlığı kapılmaktadır; günlerden bir gün her zamanki mesleğini

öyle eskisi gibi değil, ancak zar zor yürüttüğünü nedenini anlamaksızın farketmiş, yine bunun gibi ciddi bir karar vermekte, herhangi bir girişimde bulunmakta güçlük çektiğini görmüştür. Yine tatalım ki, günün birinde kaynağı bilinmeyen nahoş bir korku nöbeti geçirmiş, o vakitten beri kendini zorlamadan ne sokağa çıkabilmekte, ne trene binip bir yerden bir yere gidebilmektedir, ya da her iki şeyi yapmaktan çaresiz büsbütün el çekmiştir. Tatalım üzerine pek tuhaf bir hal gelmiş, düşünceleri ayrı baş çekmeye isteminin (irade) yöneticiliğini tanımamaya başlamıştır. Düşünceleri gerçekte kendisini hiç ilgilendirmeyen, ama ellerinden yakasını bir türlü kurtaramadığı sorunları izleyip durmaktadır boyuna. Ayrıca evlerin ön cephelerindeki pencereleri saymak gibi son derece gülünç eylemlerde bulunmaktan kendini alamamakta, mektup kutusuna mektup atmak, bir gaz ocağının musluğunu kapamak gibi sıradan işleri gördüğü vakit, biran sonra adı geçen işi gerçekten yapıp yapmadığı konusunda kuşkuya düşmektedir. Belki can sıkıcı insanı tedirgin edici şeylerdir bunlar; ancak, bir çocuğu bir araba altına iteklediği, tanımadığı bir kimseyi köprüden suya yuvarladığı gibi bir düşünce ansızın içinde belirir de bunu kafasından bir türlü kovamaz, ya da polisçe daha o gün ortaya çıkarılan bir cinayetin acaba faili ben değil miyim? diye kendi kendine sormadan edemezse, işte durum asıl o vakit katlanılmaz bir havaya bürünür. Evet, açıkça bir sorundur hastanın aklına gelen, bunu kendisi de bilmektedir, kimseye bir kötülükte bulunmamıştır, bulunmamıştır ama, aranan katil gerçekten kendisi olsa, içinde belirecek duygu suçluluk duygusu, bundan güçlü bir nitelik taşıyamaz.

Ya da diyelim hastamız bu kez bir kadını alalım ele bir başka konuda ve bir başka türlü ıstıraplar içinde kıvrınmaktadır. Hastamız piyanisttir; gelgeldim, piyano başına oturdu mu parmakları kasılıp kalmakta, kendisinden bekleneni yapmamaktadır. Kalkıp bir toplantıya gittiğini aklından geçirmesin, hemen tuvalete yollanma gereksinme-

sini duymamakta, bu da ona toplantı havasıyla bağdaşmaz bir durum görünmektedir. Dolayısıyla, toplantılara, balolara, tiyatrolara, konserlere uğramaktan vazgeçmiştir. En uygunsuz vakitte şiddetli başağnanna yakalanmakta ya da daha başka acı ve ıstıraplar içinde kıvranmaktadır. Tatalım yediği her yemeği de kusarak çıkarmaktadır dışarı ve bu hal sürüp giderse tehlikeli sonuçlar doğuracaktır. Ve nihayet yakınılacak bir başka nokta, sinirlenmeye olmamaktadır. Sinir nöbetlerinde baygınlıklar geçirmekte, çok vakit kaslarında tehlikeli hastalıkları anımsatan kramplar görülmektedir.

Daha başka kimi hastalar da vardır ki, duygusal yaşam organizmalarına bazı istekler yönettiği zaman kendilerinde bir bozukluk hissederek. Erkek olarak kadınlara karşı duydukları en sevisel içtepifere bedensel tepkilerin dışavurumunda hiç bir güçlkle karşılaşmazlar. Ya da şehvet duygulan onları götürüp nefret ettikleri yakalarından sıyrıp atmaya baktıkları kişilere bağlar. Veya aynı şehvet duygulan onları götürüp nefret ettikleri, yakalanndan sıyrıp atmaya baktıkları kişilere bağlar. Veya aynı şehvet duygulanının doyurulması, kendileri için iğrenç birtakım koşulları çıkarır önlerine. Kadın olarak cinsel yaşamın gereklerine ne vakit uymak isteseler, korku, tiksinti veya bilinmeyen tutuklulardan bir barajla yüz yüze gelirelr; diyelim sevginin kollarına bıraktılar kendilerini, doğa'nın böylesine kadınsı bir teslimiyet için belirlediği ödülse hazzı bir türlü tadamaz, bu nazdan yoksun kalırlar.

Bütün saydığımız kimseler kendilerini hasta görüp hekime başvurur, nihayet bu gibi nevroitik rahatsızlıklar ortadan kaldırmak hekimlerin işi diye bilinir. Ayrıca hekimlerin elinde adı geçen rahatsızlıkların yerleştirilebileceği kategoriler bulunmaktadır; rahatsızlıkların her birine kendi açılanndan bir teşhis kor, kimine nevrasteni, kimine psikaneni, kimine fobi, kimine saplantı nevrozu, kimine de isteri

derler. Arazların rastlandığı organları kalbi, mideyi bağırsağı, ürümsel organları muayene eder, hiç birinde bir bozukluk saptanamazlar. Hastalarına o zamana kadar sürdürdükleri yaşayış tarzını bir süre bırakıp dinlenmelerini öğütler, organizmayı güçlendirici kürler ve ilaçlar salık verir, bunlarla durumda ya geçici hafiflemeler sağlar ya da hiç bir basan elde edemezler. Derken hastalar sırf bu çeşit rahatsızlıkların tedavisiyle uğraşan hekimlerin varlığını işitir ve onlara gidip kendilerini psikanalizden geçirirler.

Bu konuşmada hazır bulunduğunu tasarladığım tarafsız dinleyicimiz, ben nevroitiklerin hastalık arazlarını sayıp dökerken sabırsızlık belirtileri gösterdi. Şimdi dikkatini vererek, merakla kulak kabartıyor ve kendi kendine şöyle söylüyor: "Eh, hekimin yardım elini uzatamadığı hasta üzerinde psikanalistin nasıl bir tedavi uyguladığını öğreneceğiz demek."

Hasta ile psikanalist arasında geçen karşılıklı bir konuşmadan başka bir şey değildir. Psikanalistin muayene için kullandığı bir aleti bile yoktur; ayrıca bir ilaç falan da yazmaz hastasına. Hatta bir yolunu bulup tedavi sürecinde hastayı içinde yaşadığı çevre ve koşullardan ayırmamaya bakar. Ancak psikanalitik tedavinin bir koşulu diye öne sürülemez bu her vakit böyle bir yol izlenemediği de karşılaşılan durumlardandır. Tedavide psikanalist günün belli bir saatinde hastayı muayenehanesine çağırır, onu konuşturur, anlattıklarını dinler, sonra kendisi konuşmaya başlar ve konuştuklarını hastaya dinletir.

Bu sözler üzerine tarafsız dinleyicimizin yüzünde açık bir ferahlık ve hafifleme ifadesi belirir gibi oluyor, ama öte yandan bir küçümseme belirgin kendini açığa vuruyor bu yüzde. Sanki kafasından şunları geçirir gibidir: Hepsi bu kadar mı? Danimarka Prensi Hamlet'in söylediği gibi lâf. Şüphesiz Mephisto*'nın ağzından çıkan ve hiçbir Almanın

* Alman ozanı Goethe'nin ünlü Faust dramının kişilerinden; drama şeytan rolünü oynar. (Ç.N.).

unutamayacağı şu mısrayı da anımsamadan duramıyordur. Kura sözlerle ne de güzel yapıtlar kurulabilir.

Ve tarafsız dinleyicimiz diyor ki: "Yani bu çeşit büyü yapılan; konuşuyor, konuşmakla hastanın dertlerini üfleyip atıyorsunuz üzerinden."

Yalan da değil hani, etkisi daha çabuk görülse bir büyü olarak pekala nitelenebilirdi bu. Çünkü büyüde çabukluk, daha yerinde bir söylenişle, bir an önce başarıya ulaşmak şarttır. Gelgelelim psikanalitik tedavi aylan, hatta yıllan gerektirir, bu kadar ağır işleyen bir büyü de olağan üstülük karakterini yitirir. Beri yandan sözü de hiç küçümsenemeyelim. Çünkü güçlü bir alettir söz, birbirimize duygulanırım açıklamada başvurduğumuz bir araçtır; başkalannı etkilemek istiyorsak, izlememiz gereken bir yoldur. Sözler dille gelmez rahatlıklar salar insanın içine, beri yandan korkunç yaralar, Herşeyin başında eylem vardı. Ona şüphe yok, söz sonradan geldi, eylemin yumuşayıp söze dönüşmesi bazı koşullar altında uygarlığın sağladığı bir basandır. Ama yine de söz işin başında bir büyü, majik (sinirsel) bir eylemdi, hâlâ da bu eski gücünü geniş ölçüde korumaktadır.

Bizim tarafsız dinleyicimiz konuşmasını sürdürüyor: "Tutalım ki, hasta psikanalitik tedaviyi anlama bakımından şimdi benim gibi hazırlıksızdır. Peki sözün ya da konuşmanın, kendisini rahatsızlığından kurtaracağını ileri sürdüğünüz o büyüsel etkiye sahip olduğuna nasıl inandırıcaksınız onu?"

Tabii bu kondua hazırlayıcı bilgiler sunulacaktır hastaya; bunu içinde izlenecek basit bir yol vardır. Hastadan, kendisini tedavi eden psikanalist karşısında tamamen açık yürekli davranması, aklına gelen hiç bir şeyi saklayıp söylemezlik yapmaması, ayrıca kimi düşünce ve anımsamaların dışavurumunu önleyen bütün engeller üzerinden aşip geçmesi istenir. Her insan birli ki, kendisinde öyle gönülden başkalanna açıklayamayacağı ya da açıklamaya

hiç mi hiç yanaşmayacağı kimi şeyler bulunmaktadır. Bunlar onun "mahremiyetleridir", Ayrıca psikolojik öztanı'da büyük bir olgunlaşma eseri diye bakılacak bir sezikle yine herkes bilir ki, insanın kendi kendisine bile itiraftan kaçındığı, kendi kendisinden saklayıp gizlemeye baktığı, dolayısıyla tüm karışıkoyumlara rağmen kendilerini açığa vurur gibi olduğu vakit yan yoldan geriye çevirdiği ve kafasından kovup uzaklaştırmaya çalıştığı birtakım şeyler vardır, ihtimal kendi kafasında uyanan bir düşünceyi kendisinden gizli tutmak zorunda kalmasının pek garip bir psikolojik soruna çıkış noktası oluşturduğuna farkedebilir insan; öyle her zaman sandığı gibi, bir birlik ve bütünlük içinde bulunmadığı izlenimine kapılabilir; adeta kendi kendisine karşı çıkan yabancı bir şey saklıdır organizmasında. Geniş anlamda kendi benliğiyle ruhsal yaşamı arasında bir karşıtlığın varlığına ilişkin belli belirsiz bir sezgi ruhunda başgösterir. Bu durumda bir kimse psikanalizin herşeyi söyleme gereğini benimsedi mi, böylesine alışılmamış koşullar altında sürdürülecek düşünsel alış verişin apayrı birtakım sonuçlara yol açacağını kolaylıkla tasarlayabilir.

"Anlıyorum", diyor bizim tarafsız dinleyici, "size göre, her nevrozluda kendisini sıkan bir şey vardır, bir sır bulunmaktadır içinde ve siz onu konuşturarak bu sırrı açığa vuruyor, sırrın baskısından hastayı kurtarıyor ve onu hafifletiyorsunuz. Nihayet bu, insanların gönül dünyalarını kesinlikle egemenliği altına almak için Katolik kilisesinin öteden beri başvurduğu günah çıkarma işleminden başka bir şey değil."

Buna hem evet, hem hayır diye cevap vermemiz gerekmektedir. Günah çıkarma işlemine psikanalizde yer verilir, orası doğru; bu işlem psikanalitik tedavi sürecinin adeta ilk adımını oluşturur. Ama psikanalitik tedavinin özü ve etkiyle günah çıkarma arasında dağlar kadar fark vardır, günah çıkarmada günah çıkartan günah çıkarana ne biliyorsa onu söyler, oysa psikanalitik tedavide bir nevrozlu bil-

diğinden daha fazlasını söylemek zorundadır. Ayrıca, günah çıkarmanın hastalık belirtilerini ortadan kaldırma gücünü gösterebildiği bir vakadan doğrusu habersiz bulunmaktayız.

Tarafsız dinleyicimiz: "O zaman sizi anlamamışım", diye cevaplıyor, "Nevrozlu bildiğinden fazlasını söylemek zorundadır sözyle ne kastediyorsunuz? Şurasını tespit edeyim ki, psikanalist olarak hastanız üzerinizde, günah çıkaran bir rahibin günah çıkartan üzerindeki etkisini aşan bir etki gücü gösterbilirsiniz; değil mi ki, hastanızla çok daha uzun süre, çok daha yoğun ve daha kişisel bir biçimde uğraşıyor, ileri bir ölçüye varan bu etki gücünüzden yararlanarak, hastanızı saynsal (marazi) düşüncelerden çekip alıyor, konuşmalarınla onun içindeki korkulan uzaklaştırıyorsunuz. Ancak, bu yoldan kusma, ishal, kramp gibi salt bedensel belirtilerin de kontrol altına alınabilmesi az acayip bir olay sayılmaz doğrusu. Ne var ki, ipnoz durumuna sokulan kimse üzerinde bu gibi etkilemelerin pekala mümkün olduğunu da bilmiyor değilim. Belki de tedavi çalışmalarınızda böyle ipnotik bir ilişkinin doğmasını sağlıyor, hastanızı telkinsel yoldan size bağlıyorsunuz; ama siz böyle bir şeyi amaçlamıyormuşsunuz, böyle bir şey kendiliğinden onaya çıkıyormuş, ne farkedir. Bu durumda da sizin tedavinin mucizevi sonuçlarına, ipnotik telkinin başarılarından ayn bir gözle bakılamaz. Oysa benim bildiğime göre, ipnotik tedavi, kendi ağzınızla belirttiğiniz gibi, aylar ve yıllar süren sizin psikanaliz tedavisinden çok daha hızlı bir tempoyla çalışır."

Bizim tarafsız dinleyicimiz başlangıçta sandığımız gibi ne o kadar bilgisiz ne de öyle apışıp kalan biridir. Eski bildiklerinin yardımıyla psikanalizi kavramaya çaba harcadığı, psikanalizi kendisi tarafından daha önce bilinen bir başka şeye bağlamak istediği açık seçik görülmektedir. Bu durumda söz konusu çabasının basan sağlamayacağını, psikanali-

zin bir sui generis* yöntem niteliği taşıdığını, kendine özgü yeni bir yol olduğunu ve ancak yeni bilgilerin ya da daha başka bir deyişle yani varsayımların yardımıyla kavranabileceğim tarafsız dinleyicimize anlatmak gibi çetin bir ödev bizi beklemekte, beri yandan, onun son sözlerine bir cevap vermemiz gerekmektedir.

Psikanalistin özellikle kişisel etkisi konusunda söyledikleriniz elbet pek dikkate alınmaya değer şeyler. Böyle bir etki gerçekten söz konusu olup, psikanalizde önemli rol oynar. Ancak, bu rol ipnotizmadakinin aynı değildir. İpnotizmayla psikanalizde durumların birbirinden enikonu değişikliğini size tanıtlayabileceği sanıyorum. Bunun için, sözünü ettiğiniz kişisel etkiden, yani "telkinsel" öğeden ipnotik telkindeki gibi hastalık belirtilerini yoket-/nekte yararlanmadığımızı belirtmek yetecektir. Ayrıca bu öğeye psikanalitik tedavinin belkemiği gözüyle bakılması gerektiğini ve bunun tedaviyi ileriye götürdüğünü sanmak yanılgıya düşmektir. Başlangıçta öyledir gerçi ve bu da bizi en geniş çapta karşı tedbirler almaya zorlar. Beri yandan, hastanın dikkatini hastalık arazlarından başka yana çelmenin ve bir hastalığı falan bulunmadığına onu sözle inandırmanın psikanaliz tekniğine ne denli uzak düştüğünü bir örnek üzerinizde açıklamak isterim. Diyelim hastamız bir suçluluk duygusuyla kıvranmakta, sanki kendini bir cinayet işlemiş hissetmektedir; bu durumda suçsuzluğunu üzerine basa basa belirtip, duyduğu vicdan azabını yüreğinden kaldırıp atmasını salık veremeyiz; çünkü zaten bu hastamızın deneyip başaramadığı bir iştir. Tersine, bizim yapacağımız, ondaki gibi böylesine güçlü ve sürekli duygunun mutlaka bir nedene dayanması gerektiğini ve bu nedeni de belki ele geçirebileceğimizi kendisine hatırlatmaktır.

Tarafsız dinleyicimiz: "Böyle onaylayıcı bir tutumla hastanızdaki suçluluk duygusunda bir yatışma sağlaya-

* Kendi özüne uygun (Ç.N.).

biliyorsanız, şaşarım doğrusu" diye cevaplıyor, "Ama önce şu sizin psikanalizle götüğünüz amaçların içyüzünü ve hastalarınızı tedavide nasıl bir yol izlediğinizi öğrensem daha iyi olacak sanırım."

II

Size anlaşılır bir şey söylemem gerekiyorsa, psikanalitik çevre dışında bilinmeyen ya da takdir görmeyen ruhbilimsel öğreticiden biraz bir şeyler açıklamaksızın bunu yapamayacağım muhakkak. Hastadan ne istediğimiz ve istediğimiz şeyi ne yoldan elde ettiğimiz, şimdi ele alacağımız ruhbilimsel kuramdan kolaylıkla çıkarılabilecektir. Bu kuramı tamamlanmış bir yapı gibi dogmatik biçimde sunacağım size. Ama sözünü edeceğim öğretin filozofik bir sistem gibi bir anda doğup çıktığını sanmayınız. Pek yavaş geliştirebildik bu öğretiyi, her küçük parçası için uzun boylu savaştık, çaba harcadık, gözlemlerle sürekli ilişki içerisinde kalarak aralıksız değiştirmelere başvurduk, sonunda götüğümüz amaçlara cevap verebilecek bir biçim kazanana kadar sürdürdük çabamızı. Birkaç yıl önce olsaydı, aynı öğretiyi daha başka deyimlerden bir giysi içerisinde sunardım. Hani bugünkü dışavurum biçimini kesin bir gözle görmek gerekeceği konusunda tabii bir güvence veremem size. Bilimin bir vahiy karakteri taşımadığı ortadadır; bir bilim ilk adımların atılmasından çok sonralarına kadar insan düşüncesinin işte öylesine yürekten özlediği bir belirlilik, değişmezlik ve şaşmazlık niteliğinden yoksun kalabilir. Ama bir bilim ne durumda ise, bize düşen, ona o durumuyla sahip çıkmaktır, bundan öte yapabileceğimiz bir şey yoktur. Şunu da unutmayınız ki, üzerinize eğildiğimiz bilim dalı henüz pek körpedir, yaşı yüzyılımızın yaşı kadardır ancak, ayrıca insandaki araştırın faaliyeti önüne çıkarılabilecek en çetin bir konuyla uğraşmaktadır; bunları düşündünüz mü,

size anlatacaklarım karşısında gerektiği gibi bir tutum takınmanız kolaylaşacaktır. Ancak ne zaman anlatımımı izleyemez duruma gelir ya da benden daha çok açıklamada bulunmamı isterseniz, sözümü kesebilir, bu konuda dilediğiniz gibi davranabilirsiniz.

"Madem öyle, siz konuşmaya başlamadan sözünüzü keseyim bari. Dediniz ki, bana yeni bir psikolojiden bahsedeceksiniz. Ama sanıyorum, psikoloji yeni bir bilim değildir. Şimdiye kadar hayli psikolog yetişmiş, psikolojiyle hayli uğraşmıştır. Okuldayken, bu alanda büyük başarılarla ulaşıldığını söylemişti öğretmenlerimiz."

Evet, böyle olduğunu yadsımak aklımın ucundan geçmez. Ancak, konu üzerine daha bir dikkatle eğilirseniz, adımı ettiğiniz büyük başarıların daha çok duyu fizyolojisini ilgilendirdiğini göreceksiniz. Ruhsal yaşam öğreticisi, çetin bir yadsıma engeliyle karşılaştığı için gelişip serpilememiştir. Okullarda öğretilen şekliyle bugün neyi kapsamaktadır bu bilim? Duyu fizyolojisi kapsamına giren değerli bilgileri saymazsak, ruhsal olaylarımızı ilgilendirip, dilsel gelenekle bütün aydınların ortak malı durumuna gelmiş bir yığın tasnif ve tanımlamalar. Ruhsal yaşam konusunda bir görüşe ulaşabilmek için besbelli bu kadarı yetmemektedir. Her filozofın, ozanın, tarihçinin ve yaşamöykücünün (biyograf) kendisine gerekli psikolojiyi bizzat kendisinin pişirip kotardığını, ruhsal olayların için ve amaçları bakımından kendi özel varsayımlarını ileri sürdüğünü, bütün bu psikoloji ve varsayımların da az çok sevimli bir karakter taşıdığını, ama hepsinin de güvenilirlikten yoksun bulunduğunu faretmediniz mi? Anlaşılan ortak bir temelin eksikliği duyulmaktadır bu konuda. Psikolojik alanda adeta bir saygı ve otorite havasının esmeyişi de yine aynı nedenle dayanmaktadır. Herkes canı istediği gibi "at koşturabiliyor" ruhbilimde. Ortaya fiziksel ya da yasal bir soru atılsa, bu "uzmanlık alanlarında" bilgisi olmayan kimse susar. Ama ruhbilimsel bir savı öne sürmeye görün, her-

keşten bu sava ilişkin yargı ve itirazlar yönetilmesine hazırlıklı bulunmanız gerekir. Galiba bu alanda "uzmanlık bilgileri" diye bir şey yok. Herkesin bir ruh yaşamı var, dolayısıyla herkes kendine bir psikolog gözüyle bakmakta; ancak, gerektiği gibi hakedilmiş bir unvana benzemiyor bu. Anlatıldığına göre bir yerde "dadılık" arayan bir kadına sormuşlar, çocukların dilinden anlıyor musun? demişler o da "Elbette" diye cevaplamış, "ben de bir vakit küçük bir çocuktum."

"Yani siz bütün psikologların gözünden kaçan ruh yaşamının ortak temelini, hastalar üzerindeki gözlemlerinizi sonucu mu ele geçirdiniz?"

Kanımca kaynağının şu yada bu oluşu bulgularımızı değerden düşürmez hiç. Sözel, doğuştan anomalilerin etiolojisini tastamam açıklama gücünü gösteremeseydi. dölütbilim (embriyoloji) kendisine karşı bir güven beslenmesini sağlayamazdı. Ama ben size düşünceleri ayrı baş çekmiş giden, dolayısıyla kendilerini hiç mi hiç ilgilendirmez sorunlar üzerinde kafa yorup duran kişilerin varlığından söz açtım. Şimdiye kadar okul psikolojisinin böyle bir anomaliyi aydınlığa kavuşturmak için en ufak bir katkıda bulunduğunu sanıyor musunuz? Ve nihayet biz hepimizin başına gelen bir olaydır, geceleyin düşüncelerimiz ayrı baş çeker ve öyle şeyler yaratıp ortaya kor ki, bunları anlayamayız; bunlar yadırgatır bizi ve sayısal (patolojik) ürünleri anımsatarak tasalara gömer, sayısal (patolojik) ürünleri anımsatarak tasalara gömer. Yani gördüğümüz düşleri söylemek istiyorum. Düşlerin bir anlam, bir değer taşıdığı, birşeyleri dile getirdiği inancına halk her vakit bağlı kalmıştır. Okul psikolojisi ise düşlerin taşıdığı anlamı bir türlü ortaya koyamamış, düşler karşısında nasıl bir tutum takınacağını bir türlü kestirememiştir; düşleri duyusal uyanlara ve beyindeki çeşitli bölgelerin birbirinden değişik uyku derinliğine indirgeme vb. gibi bu konuda başvurdurduğu açıklamalar, ruhbilimsel nitelikten yoksun

kalmıştır hep. Ancak düşü açıklayabilmekten uzak bir psikolojinin, normal ruhsal yaşamın anlaşılmasında da işe yaramıyacağını ve kendisine bir bilim adının asla yakıştınlamayacağını söyleyebiliriz.

"Bakıyorum, saldırıya geçtiniz, dolayısıyla nazik bir noktaya değindiniz. Ben de psikanalizde düşlere büyük önem verildiğini, düşlerin yorumlanıp, geri planlarında gerçekten olup bitmiş olaylara ilişkin anıların arandığını, ama düşleri yorumlamada izlenecek yolun psikanalistin keyfine kaldığını ve düşlerin nasıl yorumlanacağı, düşlerden sonuçlar çıkarmanın yerinde bir davranış görülüp görülmeceği konusundaki tartışmaların psikanalistlerin kendi aralarında da bir sona kavuşturulup, bir uzlaşma sağlanmadığını vb. işitmedim değil. Durum böyle olunca, psikanalizin okul psikolojisine göre elde ettiği üstünlüğü o kadar abartmanız uygun sayılmaz."

Gerçekten çok yerinde sözler söylediniz. Psikanalizin hem kuramı, hem de pratiği bakımından düş yorumunun eşsiz bir önem kazandığı doğru. Eğer üzerinizde saldırgan bir izlenim bırakıyorsam, bu sadece kendimi savunmak istediğim içindir. Ama bazı psikanalistlerin düş yorumu alanında yaptığı densizlikleri düşününce, cesaretimi yitirmek ve büyük yergi üstadımız Nestroy'un* şu karamsar sözlerine hak vermemek elimde değil: Her atılım ilk başta görüldüğünün ancak yan büyüklüğündedir. Ama soranm size, insanlar ellerine geçirdikleri bir şeyi ne zaman karmak-anışık, ne zaman eciş bücüş bir duruma sokmamıştır?

Biraz dikkat ve kendini eğitimle düş yorumundaki tehlikelerin çoğunluğundan sakınmak elbette mümkündür. Ancak, dikkatimizin başka konular tarafından böyle yelinmesiyle size anlatacaklanmı bir türlü anlatma fırsatı bulamayacağım kanısında değil misiniz?

* Neslroy, Johann (1801-1862); Avusturyalı oyuncu ve oyun yazar; yergi ve irani alanında çeşitli eserler yazdı. (Ç.N.)-

"Evet, sizi doğru anladımsa yeni rubbilimin temel varsayımından konuşacaktınız."

Açıklamalarıma bununla başlamak istemem. Niyetim, psikanalitik incelemelerde bulunurken ruhsal aygıtın yapısıyla ilgili olarak nasıl bir görüşle vardığımız size bildirmektir."

"Ruhsal aygıt diye neye diyorsunuz?" Sonra bu aygıt neden yapılmıştır, sorabilir miyim acaba?"

Ruhsal aygıtın içyüzünü az sonra öğreneceksiniz. Nasıl bir malzemeden yapıldığını ise lütfen sormayınız. Psikolojik bakımdan ilginç bir soru değil çünkü; bir dürbünün cidarlarının metalden mi, yoksa mukavvadan mı yapıldığı sorusu optik için ne kadar ilginçlikten yoksunsa, sizin sorunuz da psikoloji için tıpkı öyle. Biz malzeme açısını kısaca bir kenara bırakacak, mekansal açıdan duruma bakacağız. Sizin anlayacağınız, ruhsal faaliyetlerin gerçekleşmesine hizmet eden o bilinmedik aygıtı kafamızda gerçekten bir araç ki, bizim mekanizmalar adını verdiğimiz birden çok parçadan kurulmuştur. Bu mekanizmalardan her biri özel bir fonksiyon görür ve bütün mekanizmalar arasında değişmeyen mekansal bir ilişki vardır; yani "ön" ve "arka", "yüzeysel" ve "derin" gibi sözcüklerle anlatılan mekansal ilişki, bizim için başlangıçta yalnız fonksiyonların düzgün olarak birbirini izleyişinin anlatımı bakımından önem taşır. Bilmem hala beni izleyebiliyor musunuz?

"Pek değil. Belki ilerde daha iyi anlarım söylediklerinizi. Ama herşeye rağmen bu sizinkisinin doğabilimcilerde artık hiç rastlanmayan tuhaf bir ruh anatomisi niteliği taşıdığını ileri sürebilirim."

Başka ne bekliyordunuz ki; benimkisi de bilim dallarında karşılaşılan bir sürü benzerleri gibi yardımcı bir tasarımıdır. İlk tasarımlar her vakit enikonu İcaba bir durum göster-

mistir. Bu gibi durumlar için open to revision* söz
söylenebilir. Ben o popülerlik kazanmış Als ob'a (sanki)
yaslanmayı gereksiz buluyorum. Filozof Vaihinger'in**
"fiksiyon" diye niteleyeceği böyle bir tasarım değeri onunla
başarabileceğimiz işlerin azlığına ve çokluğuna bağlıdır.

Biz yine konuşmamızı sürdürelim: Bir kez harcıalem bil-
gilerin çerçevesi içerisinde düşünerek, insanda bir yandan
duyusal uyarılırla bedensel gereksinimler, öte yandan devi-
nimsel (motorik) eylemler arasına yerleşmiş bulunan ve
bunlar arasında aracılık rolü oynayan ruhsal bir örgütün
varlığını benimsiyor, bu örgüte de Ben adını veriyoruz. Bu
bir yenilik değildir hani, filozof olmayanlarımızın tümü
böyle bir varsayımı yadsımaz. Ancak bununla ruhsal aygıtın
eksiksiz bir tanımını yaptığımızı sanmıyoruz. Varlığını ka-
bul ettiğimiz bu Ben'den daha geniş kapsamlı, daha muaz-
zam ve daha karanlık bir başka ruhsal bölge var ki, buna da
Es demektedir. Bu iki örgüt arasındaki ilişki bizim en başta
üzerinde duracağımız bir konu olacak.

Ruhumuzdaki bu her iki mekanizma ya da bölgeyi anlat-
mak için basit zamirler seçmemize, öyle akustik bakımdan
kulak dolduran sözcüklere başvurmamamıza belki kusur
bulacaksınız. Ne var ki, psikanalizde harcıalem düşünüyü
bağlantı içerisinde kalmaktan hoşlanmakta, bu düşünün de-
yimlerini hor görüp aşağılamayarak onlara bilimsel bir kul-
lanırlık kazandırmayı yeğ tutmaktayız. Bunu bir yararlık
diye görmek doğru değildir, çünkü öğretilerimizi çok vakit
pek zeki, ama her vakit aydın olmayan hastalarımıza anlata-
bilmek için ister istemez böyle davranmak zorundayız.
Kişisellikten uzak Es, normal insanın bazı dışavurumlarına
doğrudan gidip bağlanmaktadır. "Birden bir ürperti yalayıp

* Rcv/yona açık (Ç.N.).

** Hans Vaihinger (1852-1933); Alman filozofu; idealist-pozitivist bir
fiksiyonalizm (illüzyonizm) öğretisini savundu. En ünlü eseri Die
Philosophie des Als-Ob'dur.

geçti içimi" denir. Sonra şöyle söylenir kimi vakit: "O anda ben'den daha güçlü bir şey vardı içimde." "Cetaït plus fort que moi"

Ruhbilimde ancak benzetmelerle tanımlamalar yapabilmekteyiz. Bu öyle yadırganacak bir şey sayılmamalıdır, bilimin başka alanlarında başka türlü davranılıyor değildir. Ancak biz bu benzetmeleri ikide bir değiştirme zorunluluğunu duyarız; çünkü bunların hiç biri yeteri kadar uzun süre dayanmaz bizde. Yani Ben'le Es arasındaki ilişkiyi bir aydınlığa kavuşturmam isteniyorsa, sizden lütfen Ben'i Es'in bir çeşit cephesi, bir ön planı, Es'in âdeta bir dış âdeta bir kabuk katmanı olarak tasarlamanızı rica edeceğim. Bu son benzetmeye sadık kalıp üzerinde yürüyebiliriz. Biliyoruz ki, kabuk katmanları kendilerine has özellikleri yüz yüze geldikleri dış ortamın değiştirici (modifiye edici) etkisine borçludur. Böylece Ben'i ruhsal aygıtın bir katmanı, dış dünyanın etkisiyle Es'in değiştirilmiş bir şekli diye kafamızda canlandırabiliriz. Psikanalizde mekansal tasarımları ne denli ciddiye aldığımızı siz de görüyorsunuz. Ben bizim için gerçekten de yüzeysel, Es ise daha derindeki katmanı oluşturur, tabii dıştan bakıldığı zaman böyledir bu. Ben realiteyle asıl katman Es arasında bulunur.

"Bütün bunları nerden bildiğiniz henüz soracak değilim. Ancak bana şimdilik bir Ben'le bir Es ayırımından ne yarar sağladığınızı, böyle bir ayırımı sizi ne gibi bir nedenin zorladığını açıklar mısınız?"

Sorunuz, konuşmamı gerektiği gibi sürdürmemi sağlıyor: Diyeceğim bilinmesi önemli ve değerli olan şey, Ben'le Es'in birden çok noktada birbirinden enikonu bir sapma gösterdiği; ruhsal olayların akışı bakımından Es'tekinden daha değişik kurallara geçerlidir Ben'de, Ben'in güttüğü amaçlar Es'inkilerden başkadır ve başka araçlarla bunların gerçekleştirilmesine çalışılır. Bu konuda çok söz söylenebilir hani, dolayısıyla yeni bir karşılaştırma ve bir örneklerle yetinmek istersiniz sanırım? Sözü gelişi son savaşta

ön cepheyle geri cephe arasındaki ayrımı düşününüz. Hani o zaman cephede bazı olayların geri hattakinden başka türlü olup bittiğini, cephede yasaklanması gereken bir çok şeylere geri hatlarda izin verildiğini gördük, şaşmadık buna. Bunun böyle olmasını belirleyen faktör, tabii düşmanın yakında bulunuşuydu; ruhsal yaşam içinse aynı faktör dış d yanın yakınlığıdır. Dışarda - yabancı - düşman sö-cükelri bir vakit özdeştiler. Şimdi de yukarıda sözünü ettiğim örneğe gelelim: Es'te çatışma diye bir şey yoktur; çelişkiler, karşıtlıklar hiç istiflerini bozmadan yan yana varlıklarını sürdürür, çok vakit uzlaşma ürünleriyle birbirlerine benzerlik sağlarlar. Oysa aynı durumlarda, Ben bir çatışma durumu yaşar, bu çatışmada bir karara varmak zorunda görür kendini, varılacak karar da belli bir eğilimin lehinde davranılıp ona karşıt eğilimden el çekilmesi biçiminde gerçekleşir. Ben bütünsellik, beraberlik ve bireşim (sentez) konusunda pek dikkate değer bir eğilimle karakterize bir örgüttür; oysa Es böyle bir karakterden yoksundur, adeta bir dağınıklık içerisindedir; Es'teki ayrı ayrı eğilimler, birbirlerinden bağımsız ve birbirlerini umarsamaksızın, güttükleri amaçları gerçekleştirmeye bakarlar.

"Peki, madem bu kadar önemli ruhsal bir geri hat var, o zaman bunun şimdiye kadar psikanalizde gözden kaçmasını nasıl açıklayabilirsiniz.?"

Böylece yine önceki sorulannızdan birine döndük. Ruhbilim bugüne kadar oldukça akla yakın, ama gerçekte bir sağlamlıktan yoksun bir varsayıma bağlanıp kalarak, Es bölgesine açılan kapıyı kendi eliyle kapamıştı. Bu varsayım da şuydu: Bütün ruhsal eylemlerimiz bizim için bilinçlidir, bilinçlilik ruhsal'ın karakteristik özelliğidir, eğer beynimizde bilinçsiz olaylar geçiyorsa, bunlar ruhsal eylem adına layık değildir ve ruhbilimi ilgilendirmez.

"Sanırım, bu da pek tabii bir şey."

Evet psikologlar da tıpkı sizin gibi düşünüyor, ama bu düşüncenin yanlışlığını, yani böyle bir görüşün hiç de ama-

ca hizmet etmeyen bir ayırım olduğunu tanıtmak güç tieğildir. En rahatından başvurulacak bir kendini gözlem, içimizde birtakım aklagelimlerin böşgösterebildiğini ve bunlar için daha önceden bilinçli bir hazırlık yapılmadığını ortaya koyacaknr. Ancak içinizde uyanan ve gerçekten de ruhsal karakter taşıması gereken ön hazırlık niteliğindeki düşünce oluşumlarını sonradan bir diriltim (rekonstruksiyon) eylemine başvurarak kendiniz için bilinçli bir duruma getirebilirsiniz.

"Belki o anda insanın dikkati bir başka tarafa çekilmişti de, söz konusu ön hazırlıkların farkına varamadı?"

Bahane bunların hepsi. Bu gibi kaçamak sözlerle içinizde ruhsal nitelikte, çokluk pek karışık olaylar geçebileceği ve bilincinizin bunlardan düpedüz habersiz kalabileceği sizin bunlara ilişkin hiç bir bilgi edinebeyeceğiniz gerçeğin yadsıyamazsınız. Yoksa ruhsal olmayan bir eylemi ruhsal bir eyleme dönüştürmek için "dikkatinizden" az ne diye tartışıyoruz bu konuda? ipnotizma deneyleri vardır, adı geçen deneyler bilinçsiz düşüncelerin varlığını bu konuya meraklı herkes için yadsınmaz biçimde göz önünde serer.

III

"Bir nevrotik rahatsızlığın doğuşunu nasıl tasarlamak gerektiği konusunda psikanalitik kurumlara dayanarak bir açıklama bekliyorum sizden."

Ben de böyle bir açıklamada bulunmaya çalışacağım. Ancak bunun için Ben'imizi ve Es'imizi yeni bir açı olan dinamik açıdan, yani bu ruhsal mekanizmann içlerinde ve birbirleri arasında faaliyet gösteren güçleri göz önünde tutarak ele almamız gerekiyor. Daha önce ruhsal aygıtı tanımlamakla yetinmiştik biliyorsunuz.

"Gene öyle akıl erdirilemeyecek gibi bir açıklama olmasında"

Sanmam. Çok geçmeden konuya bir ünsiyet kazancaksınız. Evet, bizim varsayımımıza göre, ruhsal aygıt faaliyetine iten güçler büyük fizik gereksinmelerin dışavurumu niteliğiyle organlarda üretilir. Şair filozofumuzun "Açlık ve Sevi" sözünün anımsayacaksınız. Hani enikonu saygıya değer bir güç çifti. Biz bu organik gereksinmeleri ruhsal faaliyetin uyarıcıları olmaları dolayısıyla içgüdü diye, birçok modern dillerin kendilerinde bulunmadığı için yazıklandığı bir sözcükle nitelemekteyiz. İşte bu içgüdüler Es'i doldurmaktadır; sözü uzatmadan, Es'teki bütün enerjinin bu içgüdülerden kaynağını aldığını söyleyebiliriz. Öte yandan, Ben'deki güçler de Es'teki güçlerden doğmuştur. Peki, nedir içgüdülerin amacı? Doyumdur, yani organik gereksinmelerin giderilebileceği durumları yaratmaktır. Organik gereksinme gerginliğindeki azalma, bilincimiz tarafından haz, bir artma ise hemen elem niteliğiyle algılanır. Bu dalgalanmalardan da haz ve elem duygularının oluşturduğu bir dizi ortaya çıkar ve ruhsal aygıt söz konusu diziye göre etkinliğini düzenler. Bu konuda bir **haz ilkesinin egemenliğinden** söz açmaktayız.

Es'in içgüdüsel istekleri bir doyuma kavuşmadı mı, birey için katlanılmaz durumlar ortaya çıkar. Bu gibi doyumsal durumların ancak dış dünyanın yardımıyla gerçekleşebileceğini yaşıntılar çok geçmeden ortaya kor. Böylece Es'in dış dünyaya dönük parçası, yani **Ben** çalışmaya başlar. Diyelim aracı yerinden hareket ettiren bütün itici güç Es tarafından karşılanıyorsa, Ben de direksiyon görevini yüklenir, yönetir aracı; böyle bir görevin yerine getirilemeyişi ise bilindiği üzere amaca varılmasını önler. Es'teki içgüdüler her ne pahasına olursa olsun hemen bir doyum sağlamaya bakar, bundan ötürü de ya hiç bir şey ele geçiremez ya da girişimlerinde enikonu zararlı çıkarlar. Dolayısıyla adı geçen başarısızlığı önlemek, Eslere reel dış dünyanın gerekleri arasında aracılık yapmak ödevini Ben

üzerine alır. iki ayrı yönde faaliyette bulunur. Ben. Bir yandan kendi duyu ganinin, yani bilinç sisteminin yardımıyla dış dünyayı gözetleyerek, rizikosuz bir doyum için en uygun anı kollar; öte yandan, Es'i etki altında bulundurur, ondaki "tutkular" dizginler, içgüdülerin doyumlarını ertelemesini, hattâ gerekirse amaçlarında bir değiştirme gitmesini ya da bir yerdeş doyum karşılığında bu amaçlardan el çekmesini sağlar. Ben, Es'ten gelen içtepileri bu yoldan denetim altında tutmakla, eskiden tek başına egemen olan haz ilkesinin yerine gerçeklik ilkesini geçirir; gerçeklik ilkesi de hani haz ilkesinin güttüğü en son amaçları güder, ama bunu yaparken reel dış dünyanın bireyin önüne çıkardığı koşulları dikkate alır.

ilerde ise, dış dünyaya **uyum**'dan ayrı olarak, doyumların kesinlikle ele geçirilmesinde bir başka yolun daha varlığını öğrenir. Değiştirici bir tutumla dış dünyaya müdahalelerde bulunarak, onda doyumların gerçekleşmesini sağlayacak koşulları bilinçli yoldan yaratmaya uğraşır. Derken bu faaliyet Ben'in en yüce fonksiyonuna dönüşür; tutkulannı dizginleyip realite karşısında boyun eğmenin mi, yoksa tutkulardan yana çıkıp dış dünyaya karşı kendini savunmanın mı daha yerinde olacağına ilişkin alınacak kararlar, yaşamsal bilgeliğin dışavurumlarıdır.

"iyi ama, sizi doğru anladım, Es'in kendisi Ben'den daha güçlü; bu durumda nasıl Ben'in egemenliğine nza gösterebilir?"

Evet, Ben gerektiği gibi örgütlenip bir fonksiyon gücüne kavuşur ve Es'in bütün parçalarına ulaşabilir de bunlar üzerinde etkisini gösterebilirse, duruma diyecek yoktur. Nihayet Ben ile Es arasında doğal bir düşmanlık söz konusu değildir, her ikisi bir bütün oluşturur ve bireyin sağlıklı zamanında pratik bakımdan birbirinden ayrılmaz.

"Bütün bunlar iyi güzel, ama böyle ideal bir ortamda o bozguncu hastalık olayının nerede kendisine bir yer bulup yerleştirilebileceğini anlamıyorum."

sini yitirmiş, geriye ittiği nesneyle yeniden bir çatışma durumuna girmekten sakınmak için kendi faaliyetlerinden bazılarını gözden çıkarmak için kendi faaliyetlerinden bazılarını gözden çıkarmak zorunda kalmış, geriye itilmiş içtepilerin sürgünleri olan arazlara karşı çokluk başarısız savunuyu eylemleriyle bitkin düşmüştür; öte yandan ise bir Es bulunmaktadır, buradaki tek tek içgüdüler bağımsız duruma geçmiş bireyin tüm çıkarların umursamaksızın kendi amaçları peşinde koşmakta, bundan böyle sadece Es'in derin katmanlarında egemen ilkel psikoloji yasalardan başka bir şey tanımamaktadır. Bütün durumu şöyle topluca gözden geçirirsek, bir nevrozun doğuşu için şu yalın formülü saptayabiliriz: Ben, Es'teki bazı parçaları uygunsuz biçimde bastırma denemesine girişmiş, deneme başarısızlığa uğramış, Es de davranışından ötürü Ben'den öc almıştır. Buna göre nevroz Ben ile Es arasındaki bir çatışmanın sonucudur; Ben, derinlemesine bir incelemenin ortaya koyacağı gibi, reel dış dünya karşısındaki uysallığına sıkı sıkıya sarılıp bundan vazgeçmek istemediği için söz konusu çatışmaya sürüklenmiştir. Karşıtlık dış dünyayla Es arasındadır, Ben öz varlığına sadık kalarak dış dünyayı tuttuğu için, Es'le böyle bir çatışma durumuna sürüklenmiştir. Ama lütfen dikkat buyurunuz! Böyle bir çatışmanın varlığı değildir hastalığı yaratan, çünkü realiteyle Es arasındaki bu gibi karşıtlardan ister istemez kaçınılamaz ve benin sürekli ödevlerinden bir bunlar arasında aracılık yapmaktır; hastalığı doğuran, Ben'in çatışma durumunu ortadan kaldırmak için yetersiz bir çareye, yani geriye itim'e başvurmasıdır, ama bunun da nedeni, çatışmayı giderme gibi bir ödev karşısında kaldığı zaman, Ben'in henüz gelişmemiş ve güçsüz durumda bulunuşudur. Zaten bu yüzden değil midir ki, kesin önem taşıyan bütün geriye itimlere ilk çocuklukta başvurulduğu görülmektedir.

"Bu ne garip bir durum! Öğüdünüze uyarak eleştiri yolunu tutmuyorum; çünkü amacınız, nevrozların doğuşu

konusunda psikanalizin ne düşündüğünü, dolayısıyla nevrozlarla savaşmada ne gibi bir yöntem izlediğini bana anlatmak sadece. Sorulacak çok soru var, bunlardan bir kaçını da ilerde tarafınıza yönelteceğim. Ama en başta içimde uyanan bir hevesle uyup, düşüncelerinizi daha bir genişletecek ve bundan bir kuram çıkarmaya yelteneceğim. Siz konuşmanızda dış dünya-Ben-Es ilişkisini geliştirip, Ben'in dış dünyaya bağımlılık içinde Es'e karşı sürdürdüğü savaşı nevrozların doğuş koşulu diye ortaya koydunuz. Peki, böyle bir çatışma sonucu Ben'in kendini Es'in akıntısına kaptırıp, dış dünyayı önemsemekten vazgeçmesi gibi bir diğer durumun da başgöstereceği akla gelemez mi? Peki, o zaman ne olacaktır? Benim gibi hekimlikten uzak birinin bir akıl ve ruh hastalığının doğusuna ilişkin kanısına göre, Ben'in böyle bir karan hastalığın koşulunu yaratabilir.; çünkü gerçek'ten böylesine bir yüz çeviriş, akıl ve ruh hastalıklarının başlıca nedeni gibi gözükmektedir."

Evet, bunu ben de düşünmedim değil; hatta her ne kadar doğruluğunun tanıtlanması pek çapraşık bir takım durumların irdelenmesini gerektiriyorsa da, böyle bir görüşü yerinde bulmaktayım. Nevrozlarla psikozlar galiba içten akra-ba birbirine, ama yine de çok önemli bir noktada birbirlerinden ayrılıyor. Söz konusu nokta da, Ben'in böyle bir çatışmada taraf tutuşu olabilir sanıyorum. Gerek nevrozlarda, gerek psikozlarda Es, o kör amansızlık özelliğini elden bırakmamaktadır.

"Peki, devam edin konuşmanıza, Sizin psikanalitik kuram nevroitik hastalıkların tedavisi için neler öneriyor bakalım?"

Tedavide güttüğümüz amacı bundan böyle kolaylıkla belirleyebiliriz. Bu amaç, Ben'i yeniden diriltip kendisini çevreleyen sınırlamaların pençesinden kurtarmak, ona eskilerde kalmış geriye itimler dolayısıyla çaresiz elden çıkardığı

sini yitirmiş, geriye ittiği nesneyle yeniden bir çatışma durumuna girmekten sakınmak için kendi faaliyetlerinden bazılarını gözden çıkarmak için kendi faaliyetlerinden bazılarını gözden çıkarmak zorunda kalmış, geriye itilmiş içtepilerin sürgünleri olan arazlara karşı çokluk başarısız savununu eylemleriyle bitkin düşmüştür; öte yandan ise bir Es bulunmaktadır, buradaki tek tek içgüdüler bağımsız duruma geçmiş bireyin tüm çıkarların umursamaksızın kendi amaçları peşinde koşmakta, bundan böyle sadece Es'in derin katmanlarında egemen ilkel psikoloji yasalardan başka bir şey tanımamaktadır. Bütün durumu şöyle topluca gözden geçirirsek, bir nevrozun doğuşu için şu yalın formülü saptayabiliriz: Ben, Es'teki bazı parçaları uygunsuz biçimde bastırma denemesine girişmiş, deneme başarısızlığa uğramış, Es de davranışından ötürü Ben'den öc almıştır. Buna göre nevroz Ben ile Es arasındaki bir çatışmanın sonucudur, Ben, derinlemesine bir incelemenin ortaya koyacağı gibi, reel dış dünya karşısındaki uysallığına sıkı sıkıya sarılıp budan vazgeçmek istemediği için söz konusu çatışmaya sürüklenmiştir. Karşıtlık dış dünyayla Es arasındadır, Ben öz varlığına sadık kalarak dış dünyayı tuttuğu için, Es'le böyle bir çatışma durumuna sürüklenmiştir. Ama lütfen dikkat buyurunuz! Böyle bir çatışmanın varlığı değildir hastalığı yaratan, çünkü realiteyle Es arasındaki bu gibi karşıtlardan ister istemez kaçınılamaz ve ben'in sürekli ödevlerinden bir bunlar arasında aracılık yapmaktır, hastalığı doğuran, Ben'in çatışma durumunu ortadan kaldırmak için yetersiz bir çareye, yani geriye itim'e başvurusudur, ama bunun da nedeni, çatışmayı giderme gibi bir ödev karşısında kaldığı zaman, Ben'in henüz gelişmemiş ve güçsüz durumda bulunusudur. Zaten bu yüzden değil midir ki, kesin önem taşıyan bütün geriye itimlere ilk çocuklukta başvurulduğu görülmektedir.

"Bu ne garip bir durum! Öğüdünüze uyarak eleştiri yolunu tutmuyorum; çünkü amacınız, nevrozların doğuşu

konusunda psikanalizin ne düşündüğünü, dolayısıyla nevrozlarla savaşmada ne gibi bir yöntem izlediğini bana anlatmak sadece. Sorulacak çok soru var, bunlardan bir kaçını da ilerde tarafınıza yönelteceğim. Ama en başta içimde uyanan bir hevesle uyup, düşüncelerinizi daha bir genişletecek ve bundan bir kuram çıkarmaya yelteneceğim. Siz konuşmanızda dış dünya-Ben-Es ilişkisini geliştirip, Ben'in dış dünyaya bağımlılık içinde Es'e karşı sürdürdüğü savaşı nevrozların doğuş koşulu diye ortaya koydunuz. Peki, böyle bir çatışma sonucu Ben'in kendini Es'in akıntısına kaptırıp, dış dünyayı önemsemekten vazgeçmesi gibi bir diğer durumun da başgöstereceği akla gelemez mi? Peki, o zaman ne olacaktır? Benim gibi hekimlikten uzak birinin bir akıl ve ruh hastalığının doğusuna ilişkin kanısına göre, Ben'in böyle bir karan hastalığın koşulunu yaratabilir.; çünkü gerçek'ten böylesine bir yüz çeviriş, akıl ve ruh hastalıklarının başlıca nedeni gibi gözükmetedir."

Evet, bunu ben de düşünmedim değil; hatta her ne kadar doğruluğunun tanıtlanması pek çapraşık bir takım durumların irdelenmesini gerektiriyorsa da, böyle bir görüşü yerinde bulmaktayım. Nevrozlarla psikozlar galiba içten akraba birbirine, ama yine de çok önemli bir noktada birbirlerinden ayrılıyor. Söz konusu nokta da, Ben'in böyle bir çatışmada taraf tutuşu olabilir sanıyorum. Gerek nevrozlarda, gerek psikozlarda Es, o kör amansızlık özelliğini elden bırakmamaktadır.

"Peki, devam edin konuşmanıza, Sizin psikanalitik kuram nevrozik hastalıkların tedavisi için neler öneriyor bakalım?"

Tedavide güttüğümüz amacı bundan böyle kolaylıkla belirleyebiliriz. Bu amaç, Ben'i yeniden diriltip kendisini çevreleyen sınırlamalann pençesinden kurtarmak, ona eskilerde kalmış geriye itimler dolayısıyla çaresiz elden çıkardığı

sorunlar bütün ayrıntılarıyla ele alınıyormuş. Eğer durum bö; eyse hani sizin psikolojik irdelemelerinizden böyle olması gerektiği gibi bir tanıt ele geçirilmiş demektir. Öyle ya, sır saklayacak lan na kesinlikle güvenilemeyen, karakterlerinin sağlamlığına ilişkin ortada bir güvence bulunmayan başka kişilerin ellerine bu denli tehlikeli özgürlükleri nasıl teslim edersiniz?"

Doğru bir hekim cinsel alanda bazı ayrıcalıklarla donatılmıştır, üremsel organlan (tenasül organlan) da muayene edip, gözden geçirebilir. Gerçi Ortadoğu'da bu halk hekimlerden esirgenmiştir; ayrıca bazı ülkücü devrimciler kimi kastettiğimi biliyorsunuz hekimlerdeki bu ayrıcalıklara karşı savaşımıştır. Ama siz önce psikanalizde durum böyle midir, değil midir, böyleyse neden böyledir, bunu öğrenmek istiyordunuz, sanınm? Evet, böyledir. Ancak, böyle de olması gerekmektedir; çünkü, bir kez psikanaliz genellikle tam bir açıkyüreklilik ilkesi üzerine kurulmuştur. Sözel geliş psikanalitik tedavide hastanın maddi durumu da içtenlikle uzun uzadıya anlatı konusu yapılabilir ve hasta kendi raki-binden ya da vergi memuru bile olmasa bir başkasından saklı tutup söylemeyeceği şeyleri hekime açıklar. Hastanın omuzlanına yüklenen bu açıkyüreklilik yükümlülüğünün beri yandan psikanalisti de ağır bir manevi sorumluluk altına soktuğunu yadsımayacak, tersine hararetle belirteceğim. Böyle olmasının ikinci nedeni de, nevrotik hastalıklann etiyolojisinde cinsel yaşama ilişkin nedenlerin son derece önemli, alabildiğine büyük, hatta belki karakteristik bir rol oynamasıdır. Psikanalitik tedavi de kendi konusuna, yani hastanın sunduğu malzemeye uymayıp ne yapacaktır? Psikanalist asla hastayı kandırıp cinsel alana sürüklemey, şimdi tedavi sürecinde cinsel yaşamımızın mahremiyetleri el alınacaktır diye önceden bir şey söylemez kendisine. Açıklamalanna canı istediği yerden başlamasına müsaade eder hastanın, hiç sabırsızlanmadan hastanın kendisinin cinsel konulara değinmesini bekler. Ben öğrencilerime hep \$11

uyarmada bulunmuşumdur: Hasımlarımız cinsel faktörün hiç bir rol oynamadığı vakalarla da karşılaşacağımızı ileri sürmüşlerdir ; onun için, psikanaliz tedavisinde bu faktöre kendiniz değinmekten sakının da ileri sürdükleri gibi bir vakayı ele geçirme şansından kendimizi yoksun bırakmayalım. Gelin görün ki, içimizden hiç biri şimdiye kadar böyle bir vakayla karşılaşmak mutluluğuna erişmiş değil.

Bizim cinselliğe verdiğimiz önemin itiraf edilmiş ya da edilmemiş kadarıyla bazı kimselerde psikanaliz düşmanlığının en güçlü nedenini oluşturduğunu bilmiyor değilim tabii. Ama bu dizi yanıltabilir mi? Nihayet bize tüm uygarlık yaşamımızın ne denli nevrotik bir karakter taşıdığını, çünkü sözde normallerin de nevrozlulardan çok daha başka türlü davranmadığını gösterir, o kadar. Almanyada'ki bilgin çevrelerinde psikanalizin resmen yargılandığı günlerde bugün eni konu sakın durum hekimlerden biri çıkıp, kendisinin de hastaları konuşturduğunu açıkladı, dolayısıyla özel bir hekimsel otoritenin varlığını zorunlu buldu. Hastaları konuşturuyorsa, herhalde teşhis amacıyla ve psikanalistlerin lavlarının doğruluğunu sınamak için yapıyordu bunu. Aynı Konuşmacı: "Ama" diye ekledi, "hastalar cinsel konulardan söz açmaya başlar başlamaz, ağızlarını kapıyorum hemen." Psikanaliz aleyhinde öne sürülen bu gibi tanıtlardan ne beklersiniz? Bilginler topluluğa konuşmacı hesabına yeril» dibine geçecekken ona alkış tuttu, bravolarla karşıladı konuşmasını. Şimdi bu konuşmacının mantık denen şeyi umursamayışını açıklayarak bir neden varsa, insanların ortak Önyargılara sahip bulunduğu bilincinin sağladığı o yengi havası esen güvendir. Bundan birkaç yıl sonra öğrencilerimden birkaçı, insan toplumunu, sözde psikanalizin kendisine yüklemek istediği cinsellik boyunduruğundan kurtarmak gereksinmesine karşı duramazdı. Bunlardan biri, cinsel'in hiç de cinsellik anlamına gelmediğini, tersine bundan başka bir nitelik taşıdığını, soyut, gizemsel (mistik) bir nesne olduğunu açıkladı; hatta bir başka öğrencim daha da

ileri gitti, cinsel yaşama insanın kendisini güden iktidar ve egemenlik içgüdüsünü doyuma ulaştırmaya çalışırken başvurulan bir etkinlik alanı diye bakmak gerektiğini ileri sürdü. İkisi de bol bol alkışlandılar, hiç değilse ilk zamanlar bu alkış esirgenmedi kendilerinden.

"Bakın, bu noktada sizi tarafınızı korkmadan tutabilirim sanıyorum: Cinselliğin canlı yaratıkların doğal ve ilksel bir gereksinmesi değil de bir başka şeyin dışavurumu görülmesi gerektiğini ileri sürmek bana pek atak bir sav gibi görünüyor. Yalnız hayvanları örnek almak yeteri kadar aydınlık getirecektir bu konuya."

Zararı yok. Ne denli saçma olursa olsun, toplumun kendi gönül rızasıyla içmeyeceği hiç bir ilaç karışımı yoktur yeter ki, ilacın cinselliğin o korkulan üstün gücüne karşı bir panzehir niteliği taşıdığı açıklansın.

Ayrıca şunu da belirtiyim ki, nevrozların etiyolojisi insel faktörün pek o kadar büyük bir rol oynadığı tezine karşı sizin bizzat açığa vurduğunuz yadsıma, yüklendiğiniz tarafsız bir gözlemci ödeviyle pek uzlaşmaz görünüyor. Böyle bir antipatinin adil bir yargıya varmanızı köstekleyeceğinden korkmuyor musunuz?

"Bunu söylemenize üzıldüm doğrusu. Bana karşı güveniniz sarsılmışsa benziyor. Peki ama, ne diye o zaman başka birini tarafsız gözlemci seçmediniz?"

Bu başkası da sizden değişik şekilde düşünmezdi, onun için. Ama diyelim daha işin başında, cinsel yaşamın önemini takdire eğilimli bir kimsedir bu gözlemci; o vakit bütün dünya şöyle bağırdı: Bu seçtiğiniz kimse tarafsız değilim ki, sizin taraftarlarınızdan biri... Yo hayır, görüşlerinizi etkileyebilme umudundan asla vazgeçmiş değilim. Ancak şimdi ele aldığımız konu, demin üzerinde durduğumuzdan bir başka nitelik taşıyor. Ruhbilimsel konuşmalarda bana inanmışsınız, inanmamışsınız, benim

için farketmezdi nihayet; salt ruhbilimsel sorunların ele alındığı izlenimini sizde uyandırmak yeterdi benim için. ama şimdi cinsellik sorununda, sözlerime itirazda başvurduğumuz en güçlü nedenin daha başta psikanalize karşı içinizde yaşayan ve sizin gibi birçok kimselerce de psikanalize karşı beslenen düşmanlıktan başka bir şey olmadığını anlamınızı isterdim.

"Size bu konuda öylesine sarsılmaz güven sağlayan tecrübeler yok ben de, ne yapayım."

Güzel, şimdi anlatımımı sürdürebilirim. Cinsel yaşam sadece haz verici bir şey değil, aynı zamanda bilimsel bir sorundur. Bu soruna ilişkin öğrendiğimiz bir sürü yeni şeyler, açıklayacağımız bir sürü acayip durumlar olmuştur: Psikanalizin çocukluğun ilk yıllarına kadar uzanması gerektiği çünkü kesin önem taşıyan geriye itimlere Ben'in henüz gereken güçle donatımdan yoksun ilk çocukluk yıllarında başvurulduğu. Ama çocuklukta bir cinsel yaşamdan söz açılabilir mi? Cinsel yaşam ancak buluşla başlamaz mı? Tersine, bizim bulgulamamıza göre, cinsel içtepkiler daha doğuştan beri yaşama eşlik eder ve özellikle bu içtepkiler yüzünden çocuksal Ben, kendini savunma için geriye itimlere el atar. Küçük çocuğun cinselliğin gücüne bu diretişiyle daha önce kendisinden söz açtığım bilgin konuşmacının, ayrıca kendileri bu konuda kuramlar ortaya atan benim kendi öğrencilerimin aynı davranışa başvurmaları arasında dikkate değer bir uygunluk var, öyle değil mi? Peki, nedendir bu? Uygarlığımızın bütünüyle cinsellikten fedakarlıklar üzerine kurulduğu gibi pek genel bir cevap verilebilir soruya; ancak, bu konuda söyleyeceğimiz çok daha başka şeyler bulunmaktadır.

Çocuk cinselliği, ele geçirildiği için utanılması gereken bulgulardan sayılır. Öyle görülüyor ki, bazı çocuk hekimleri bunu hep böyle bilmiş, ayrıca bazı çocuk bakıcıları da bu konuda onlardan aşağı kalmamıştır. Kendilerine çocuk psi-

kolojisi denen uyanık kimseler de bu durum karşısında suçlamalı bir edayla çocukluğun melekleştirilmesi'nden söz açmışlardır. Yani tanıtılar yerine hep duygusal savlar öne sürülmüştür. Bizim politik çevrelerde bu tür olaylar her gün rastlanan şeylerdir: Tutuş muhalefetten biri ayağa kalkar, ordu içerisinde, idari mekanizmada hukuk işlerinde vb. bir bozuk düzenin varlığı savını atar ortaya. Bunun üzerine bir başkası çıkar, en çok iktidardan biridir bu, ileri sürülen aksaklık iddialarının devletin ordunun, hanedan soyunun onurunu ayaklar altına aldığı, hatta milli duygulan rencide ettiği cevabını verir, yani yapılan eleştirilerin hiç de gerçeğe uymadığını açıklar. Söz konusu duygular öyle incinmeye gelmez çünkü.

Çocuğun cinsel yaşamı bir erişkinin cinsel yaşamından tabii farklıdır. Cinsel fonksiyon başından başlayıp bizim bildiğimiz son aşamasına ulaşana kadar karışık, bir gelişim yolunu geride bırakır. Çok sayıdaki parça içgüdülerin birleşmesiyle onaya çıkar; tam bir örgütlenme durumuna erişebilmek için çeşitli evrelerden geçip, sonunda üreme hizmetine girer. Tek tek içgüdü parçalarının hepsi de cinselliğin son durumunda bütünüyle yararlanılmaya elverişli değildir; bir kısmı amaçlanndan saptılır. Bu kadar uzun boylu bir gelişim ise her vakit kusursuz gerçekleştirilemez, arada birtakım gelişim tututlukları, önceki gelişim basamaklarında kısmi takılıp kalmalar (fiksasyon) çıkabilir ortaya; böylesi durumların ilerde cinsel fonksiyonun karşısına engel kılığında dikildiği görülür; cinsel eğilim, bizim deyimi-mizle libido engellere karşılaştıkça sık sık geriye çekilip, bu takılıp kalma noktalarına döner. Çocuk cinselliğiyle bu cinselliğin olgun duruma erişinceye kadar katıksız bir tiksintiye tanımlanagelen, ama nasıl doğduğu bir türlü açıklanmayan cinsel sapıklıkları anlamamızı sağlayacak bir anahtarı da elimize tutuşturur. Bu alan tümüyle enikonu ilginçtir, ama sizinle bu konuda daha çok konuşmam, konuşmalarımızda

güttüğümüz amaçlar bakımından pek bir anlam taşımayacaktır. Bu alanda yöneltili (oryantasyonu) yitirmemek için pek tabii anatomik ve fizyolojik bilgiler gereklidir; ne yazık ki bunların hepsi de üp fakültelerinde edinilememektedir. Beri yandan uygarlık tarihi ve mitolojiden anlamak da yine zorunludur.

"Siz bu kadar anlattınız ama, ben yine de çocuk cinselliği konusunda bir görüşe varamadım."

O zaman üzerinde biraz daha durmam gerekiyor; zaten kendimi öyle kolay kolay koparıp alamayacağım bir konu bu. Bakın! Çocuğun cinsel yaşamında bana en dikkate değer görünen şey, bu cinselliğin pek uzun boylu gelişim sürecini ilk beş yaş içerisinde geride bırakmasıdır; beş yaşından buluğa kadar uyuklama evresi denen evre uzanır bu evrede normal olarak, cinsellik hiç bir ilerleme kaybetmez; tersine cinsel eğilimlerin güçlerinde azalmalar görülür, çocuğun cinsellik konusunda daha önce bildiklerinin çoğu elden çıkarılır ya da unutmaya konu yapılır. Cinsel yaşamda açan ilk çiçeklerin solup sararmasını izleyen bu dönemde objeler karşısında, utanç, tiksinti, ahlak gibi benseel tutumlar oluşup ortaya çıkar. Bunların ödevi, bireyin ilerki buluş fırtınası karşısında ayakta kalmasını sağlamak ve yeni uyanan cinsel isteklere izlemeleri gereken yolları göstermektir. Cinsel yaşamın iki zamanlılığı denen durumla nevrozik hastalıkların doğuşu arasında yalnız insana özgü görünmektedir, belki de insandaki nevroza yakalanma ayncalğının bir ön koşuludur. Başka alanlardaki bilinçli yaşamın arka planı gibi cinsel yaşamın geçmişi de psikanalizden önce ele alınmamış, üzerinde durulmadan geçilmiştir. Sözü edilen iki durum arasında sıkı bir ilişkinin varlığını haklı olarak tahmin edeceksiniz.

Cinselliğin bu erken dönemdeki muhtevalar, değişmeler ve görülen işler üzerinde sizin beklemeyeceğiniz pek çok şey anlatabilir. Sözel gelişim oğlanlarda pek sık rastla-

nan korkulardan birinin babalan tarafından yenilip yutulmak olduğunu işitmek elbet şaşırtacaktır sizi. Ayrıca bu korkuyu cinsel yaşamın dışavurumları arasına katmanı da yine hayretle karşılayacaksınız, öyle değil mi? Ama okul yıllarından belki aklınızda kalmış bir efsaneyi anımsatmak isterim size; hani Tann Kronos* kendi çocuklarını yeyip yutar. Bu mitolojik efsaneyi ilk işittiğiniz zaman size ne tuhaf gelmiştir, kimbilir. Ama öyle sanıyorum, hepimiz okul çağında pek üzerinde kafa yormadan geçtik bunu. Bugün kurt gibi insan yiyen bircanavarın rol oynadığı kimi masalları da anımsayabilir, kurda babanın kılık değiştirmiş sureti diye bakabiliriz. Bu fırsattan yararlanarak size şunu kesinlikle söyleyeyim ki, mitoloji ve masal dünyası ancak ve ancak çocuk cinselliğini bilmekle anlaşılabilir. Bu bize psikanalitik araştırmaların sağladığı bir yan kazançtır.

Oğlan çocuklarının, babalan tarafından penislerin zorla kopanıp alınarak bir penisten yoksun bırakılma korkusu içinde yaşadığını, bu iğdiş korkusunun da onların karakter gelişimleriyle cinsel yaşamlarının ilerde izleyeceği doğrultu üzerinde hepsinden güçlü bir etki yaptığını işitmek, sizi önce söylediklerimden daha az şaşırtmayacaktır sanırım.

* Kykloplar'ı ve Hekatonchir'leri yeraltı ülkesi Tartaros'a attığı için kocasına içerleyen Gaia, en küçük oğlu Kronos'u kandırıp kocası Uranos'la savaşmaya razı eder ve bu amaçla oğlunun eline keskin ağızlı bir orak tutuşturur. Uranos geceleyin karısı Gaia ile cinsel birleşmede bulunmak isterken, oğlu Kronos gelir, elindeki orakla babası Uranos'un erkeklik organını keser ve dünya egemenliğini onun elinden alır. Kendisinin babasına yaptığını, oğullarının kendisine yapmasından korkan Kronos, Rheia'dan olan çocukları Hestia'yı, Demeter'i, Hera'yı, Hades'i ve Poseidon'u birer birer yutar. Ancak Rheia bir aldatmacaya başvurur, en küçük oğlu Zeus'un yerine bekleklere sarılmış bir taşı Kronos'a yutturur; daha sonra Zeus'u perilere verip Kıbrıs'ta Dikte dağının bir mağarasında baktırır. Zeus büyüyünce babasıyla savaşa tutuşur ve onu bir zaman yuttuğu kardeşlerini tekrar kusup çıkarmaya ve dünya üzerindeki egemenliğinden vazgeçmeye zorlar. (Ç.N.).

Yine burada da psikanalizin bulgularına inanmanız için mitoloji sizi cesaretlendirilecektir. Çocuklarını yutan aynı Tanrı Kronos babası Uranos'u da iğdiş etmiş, yaptığıının cezasını karısının hileye başvurarak elinden kurtardığı oğlu Zeus tarafından iğdiş edilerek ödemiştir. Psikanalizin çocuklardaki erken cinsellik konusunda açığa vurduğu bütün bilgilerin psikanalistlerdeki başı boş hayal gücünden doğduğu kabule eğilimliyseniz, hiç değilse şurasını itiraf etmelisiniz ki, bu hayal gücü mitler ve masallarda bir çökeltisini gördüğümüz ilkel insanlığın hayal ürünleri gibi ürünle yaratıp ortaya koymuştur. Bu konuda daha sempatik ve belki daha isabetli bir gördüş de şudur:\Uygurlığın ilk çağlarında genellikle egemenliğini sürdüren arkaik nedenleri bugün bile hala çocukların ruh yaşamında saptamaktayız. Çocuk kendi ruh gelişiminde soyyaşamsal tarihi kısa yoldan tekrarlar ki bunun gerçekliğini dölütbilim (embriyoloji) bedensel gelişim bakımından çoktan ortaya koymuştur^

lirkek çocuk cinselliğinin bir başka karakteristik özelliğide, kızlardaki üremsel (genital) organın bu cinsellik döneminde henüz bir rol oynamayışı, bu dönemde ürümsel organın kız çocukları tarafından henüz keşfedilmeden kalışıdır. İlk cinsellikle bütün ağırlık , oğlanların erkeklik organı üzerinde toplanmakta bütün ilgi çocuklar tarafından böyle bir organın varlığı ya da yokluğu üzerine yöneltilmektedir. Küçük kızlardaki cinsel yaşam konusunda oğlanların cinsel yaşamına göre daha az bilgimiz vardır. Ama bu yüzden bir utanç duygusuna kapılmamız yersizdir, nihayet erişkin kadınların cinsel yaşamı da ruhbilim için bir dark continent* oluşturur. Ama öğrendiğimiz bir şey var ki, o da kızların oğlanlannkine eşdeğer bir üremsel (genital) organdan yoksunluğun ezikliğini kolay kolay üzerlerinden silkip atamayışı, dolayısıyla bir aşağılık duygusuna kapılışı

* Karanlık bölge (Ç.N.).

içlerinde yaşattıkları penis kıskançlığının kadınsal bir dizi karakteristik tepkilere kaynaklık edişidir.

Ayrıca çocuğa özgü bir durum da, küçük ve büyük aptest gibi her iki çıkartı (ekskrementasyon) eyleminin cinsel hazla donatılmış olmasıdır. Ancak, sonraları, çocuğun eğitimi ikisi arasında kesin bir ayırım sağlar, ama ilerde günlük yaşamın nükteleri bu ayrımı yine ortadan kaldırır. Bu pek iştah açıcı bir durum görünmeyebilir bize; ne var ki, bildiğimiz gibi, tiksinti duygusunun çocuğun ruhuna yerleşmesi için aradan epey bir vaktin geçmesi gerekmektedir. Hani genellikle çocuklarda meleksi bir safiyet bulunduğu tezini savunanlar bile bunu yadsımaz.

1. Gelgelelim çocuğun cinsel isteklerini her vakit kendisine akrabalık bakımından en yakın kişiler, yani ilk planda anne-baba, daha sonra kardeşler üzerine yöneltmesi kadar cinsellik konusunda dikkatimizi çekmeye layık bir başka gerçek yoktur. Bu çiftcinsellik yatkınlığı karşıt davranışlara elverişli bir zemin hazırlamadığı süre, oğlan için ilk seviyesi anne, kız için babadır. Oğlan tarafından baba, kız tarafından anne bozguncu rakip gözüyle görülür ve kendilerine, seyrek olmayarak aşın düşmanlık beslenir. Beni yanlış anlamayınız lütfen! Söylemek istediğim, çocuğun kendisine daha çok yöneldiği anne ya da babasından beklediği yakınlık, biz yetişkinlerin anne-baba ve çocuk ilişkisinin özü diye baktığımız bir yakınlık değildir. Hayır! Psikanaliz, çocuğun bu yakınlıklar ötesinde, tabii kendi düşünüyene yeteneğinin elverdiği kadar, bizim şehvi doyumdan anladığımız herşeyi ele geçirme amacı güttüğünü açık seçik göstermektedir. Çocuğun cinsel birleşmenin içyüzünü asla sezemeyeceği ortadadır, bu birleşmeyi kendi yaşantılarından ve duyumlarından gelen tasarımlarla donatır, genellikle bir bebek doğurmak ya da bir bebek dünyaya getirmek ereğinde doruğuna ulaşır istekleri. Ancak buna ne yoldan ulaşacağı konusunda henüz bir fikri yoktur.

Bebek doğurma isteğini kendi bilmezlikleri içerisinde oğlanlar da duyarlar. Çocuklardaki bütün bu ruhsal ürünü o ünlü Yunan efsanesine* dayanarak Ödipus kompleksi diye nitelemekteyiz. Genellikle bu kompleksin erken cinsellik döneminin kapanmasıyla geride bırakılması, adamakıllı bir yıkım ve değişim işleminden geçirilmesi gerekmekte, bu değişimin sonuçlarına ise ilerki ruhsal yaşamda büyük işler düşmektedir. Gelgeldim, söz konusu işlem gerektiği kadar köklü biçimde gerçekleştirilmez; derken buluş dönemi gelip çatar ve komplekste yeniden canlanmalara yol açabilir, ki bu da bazan tehlikeli durumlarla bireyi karşı karşıya bırakır.

Hâlâ susmanıza şaşıyorum doğrusu. Bu hiç de bana hak verdiğiniz anlamına çekilemez sanıyorum. Eğer psikalaniz, çocuktaki ilk seviyesinin teknik bir deyimle yasak-sevisel bir karakter taşıdığını ileri sürüyorsa, yine insanlığın en kutsal duygularını incitiyor demektir elbet; dolayısıyla, bu davranışa uygun düşen inançsızlık, itiraz ve suçlamayla karşılaşmayı göze alması gerekmektedir. Ve doğrusu adı geçen davranışlara da bol bol hedef olmaktadır. Ödipus kompleksini bütün insanlara özgü yazgısal bir durum diye öne sürmesi kadar psikanaliz itibarına çağdaşlarının nezdinde gölge düşüren başka bir şey olmamıştır. Yunan efsanesinin de anlattığı elbet bizim ileri sürdüğümüzden başka

* Yunan mitolojisindeki bir anlatıma göre karısı Iokaste'den çocuğu olmayan Teb kralı Laios, Pelops'un oğlunu kaçırmış, bunun cezası da kâhinlerin ağzından kendisine bildirilmiştir: Kral Laios'un Iokaste'den bir oğlu olacak, bu oğlan babası Laios'u öldürecek ve annesi Iokaste'yle evlenecektir. Günün birinde kehânet gerçekleşir, Laios'un bir oğlu olur, çocuk ilerde başına geleceklerden korkan Laios tarafından saraydan uzaklaştırılarak dağlık bir yere bırakılır. Bir çoban oğlanı bulur ve götürüp Kral Polybos'a verir, Polybos'u öz babası ve Merope'yi de öz annesi sanan ödipus yetişkin bir insan olur, soyunu sopunu merak ettiğinden bir gün evden gizlice uzaklaşır ve kâhinlere gelerek durumu sorar, öz babasını öldürüp öz annesiyle evleneceğini onlardan öğrenir. Kehânetin gerçekleşmesi korkusundan eve dönmeye cesaret edemez. Bir ara yolda giderken karşıdan bir araba gelir. Arabadakilerle ödipus arasında bir kav-

bir şey değildir; gelgelelim, bilgin ya da bilgin değil, bugün insanlarımız çoğunluğu, yasaksevi ihtimaline karşı doğa'nın insan içerisinde doğuştan bir tiksintiyi koruyucu tedbir olarak yerleştirdiğine inanmayı yeğ tutmaktadır.

İlkin tarihi yardıma çağırırsak iyi ederiz bu konuda. C. Julius Casar Mısır'a ayak bastığı zaman, orada genç kraliçe Kleopatra'yla karşılaştı, çok geçmeden Casar'ın yaşamında büyük bir yer tutan Kleopatra o zaman kendisinden küçük kardeşi Phetelamaus'la evli bulunuyordu. Mısır hanedanlığında öyle yadırganacak bir şey değildi bu; Yunan asıllı Ptolemaer'lerin bütün yaptıkları, kendilerinden öncekilerin, eski Firavunların birkaç yıldır uydukları bir töreyi sürdürmekten başka bir şey değildi. Ama bu, günümüzde de pek sert tepki görmeyen bir kardeşler arası yasakseviydi sadece. Dolayısıyla, eski çağlardaki durumlar üzerinde kendisinden bilgi almak için en baş tanışımıza, yani motolojiye kulak verelim yine. Mitolojiden öğrendiğimize göre, yalnız Yunanlıların değil, bütün ulusların mitleri babayla kız, hatta anneyle oğul arasındaki sevi ilişkileriyle dolup taşmaktadır. Gerek evrenbilim (kozmoloji), gerek kral hanedanlarına ilişkin soy ağaçları (şecere) yağa çıkar, kavgada Odipus arabadakileri öldürür, yalnız bir lek kişi sağ kalır, öldürülenler arasında ödipus'un tanımadığı öz babası Laios da bulunmaktadır. Böylece kehânetin bir bölümü gerçekleşir. O sıralarda Sphinks adında bir canavar Teb kenti önünde belirmişti; oradan gelip geçenlere bir bilmece sorar ve bilmeyenleri öldürür. Bu canavardan kendini kurtarmak isteyen Kral Krcon, Sphinks'i öldürene Laios'un dul karısı Iokaste'yi eş olarak vereceğini vaadeder. Derken ödipus Sphinks'in bulunduğu yere gelir, aynı bilmece kendisine de sorulur: "Sabahleyin dört, öğleyin üç, akşamleyin iki ayak üzerinde hareket eden yaratık nedir?" ödipus: "İnsan" diye cevap vererek bilmeceyi çözer. Sphinks bunun üzerine kendini denize atar, ödipus da tanımadığı öz annesi Iokaste'yle evlenir. Ancak günün birinde gerçeği öğrenerek büyük bir yasa kapılır ve kendi eliyle gözlerini oyarak kendini cezalandırır. Eşi ve annesi Iokaste de kendini asarak intihar eder. (Ç.N.).

sakevi temeli üzerine kurulmuştur. Bütün bu şiirsel yaratıklara ne amaçla başvurulmuştur dersiniz? Tanrılarla kraları canı diye damgalamak, insan soyunun nefretini üzerlerine yöneltmek için mi? Herhalde daha çok yasaksevisel istekler atalarından kalıtımla geçen en eski bir miras niteliği taşıdığı için, asla bütünüyle insanların ruhlarından sökülüp atı lamamı ştır, normal insanoğullarının çoğunluğu bu isteklerden el çektiğinde, Tanrılarla onların soyundan gelenlere hâlâ bu istekleri gerçekleştirme özgürlüğünün tanınması yine aynı nedene dayanıyor olacak. Tarih ve mitolojinin bu öğretileriyle tam bir uyum içerisinde yasaksevinin bireyin çocukluğunda bugün varlığını ve etkinliğini sürdürdüğünü görmekteyiz.

"Çocuk cinselliği konusundaki bütün bu bilgiler benden nerdeyse saklayacak olmanıza doğrusu gücensem yeridir. Özellikle insanlığın ilk çağlarıyla ilişkisi bakımından bu anlattıklarınız ilginç göründü bana."

Bunlar bizi amacımızdan çok uzaklaştırır diye korkmuştum da. Ama bakarsınız yaran da dokunabilir.

"Ancak söyler misiniz, çocuk cinselliğine ilişkin psikanalitik kurum bakımından ne gibi bir kesinlik öne sürülebilir? Bu konudaki inancınız acaba sadece mitoloji ve tarihle aradaki uygunluklara mı dayanıyor?"

Hayır, asla! Dolaysız yapılan gözlemlerden kaynağını alınıyor bu inanç. Nasıl oldu, anlatayım bakın: Çocuk cinselliğinin muhtevasını ilkin yetişkinlerin, yani yirmi ila kırk yaşları arasındaki kişilerin psikanalizinden çıkardık. Daha sonraları çocukların kendileri üzerinde psikanaliz denemelerine giriştik; arada geçen zaman içinde uğradıkları bütün biçim değişikliklerine ve üzerlerinin birtakım katmanlarla örtülmesine rağmen, yetişkin analizinde çocuk cinselliği konusunda bulguladığımız gerçeklerin küçüklerin analizinde de doğrulandığını görmek azımsanacak bir zafer değildi.

"Nasıl? Küçük çocukları analizden mi geçirdiniz? Altı yaşından küçük çocukları ha? Hiç mümkün mü böyle bir

analiz? Bu, çocuklar bakımından pek netameli bir şey değildir midir?"

Pekâlâ mümkün. Dört ilâ beş yaş arasındaki bir çocuğun ruhunda neler de neler geçiyor, inanmak zor hani. Bu yaştaki çocuklar pek hararetle bir düşüncel faaliyet içerisinde bulunur, cinselliğin bu erken dönemi onlar için aynı zamanda düşünsel bir çiçeklerime çağıdır. Benim edindiğim izlenime göre, uyuklama dönemine ayak atar atmaz düşünsel gelişim bakımından da engelleniyor, aptallaşılıyor çocuklar. Çoğu bundan böyle dış görünümündeki çekiciliklerini de yitiriyor. Erken yaştaki psikanalizin doğurabilecekleri zarara gelince: size şunu söyleyebilirim ki, nerdeyse yirmi yıl önce ilk kez psikanaliz uygulamasına konu edinen çocuk o günden bu yana sağlıklı ve çalışma yetenekli genç bir adam olmuş, ağır ruhsal travmalara rağmen buluş dönemini pürüzsüz atlatmanın üstesinden gelmiştir. Erken analizin sözde öbür kurbanları'nın akıbeti umarım bundan kötü olmayacaktır. Bazı gereksinmelere cevap veren bu çocuk analizleri, gelecekte şimdikinden daha büyük bir önem kazanır bakarsınız. Nihayet kuramsal açıdan taşıdıkları önem hiç de su götürcek gibi değildir. Bu analizler, yetişkinlerin analizinde kesinlikle cevaplandırılmamış birtakım sorulara ilişkin açık seçik bilgiler sunar bize, dolayısıyla psikanalisti vahim sonuçlar doğurabilecek yanılgılara düşmekten korur. Çünkü nevrozları hazırlayan nedenler, çocuk psikanalizinde suç üstü yakalanır, görülmeden geçilecek gibi değildir bunlar. Ancak, çocuğun yaran bakımından psikahalitik etkilemenin pedagojik tedbirlerle birleştirilmesi gerekmektedir. Henüz geliştirilip olgunlaştırılmayı gözleyen bir tekniktir psikanaliz. Ne var ki, çocuklanmızından pek çoğunun gelişmelerinde açıkça nevroitik bir evreden geçtiklerinin gözlenmesi bu konuda pratik bir gereksinmenin uyanmasına yol açmıştır. Daha keskin gözlerle duruma bakmasını öğrendiğimizden bu yana, çocuksal nevrozun bir ayrıca durum değil, bir kural niteliği taşıdığını, çocuksal yatkınlıkla to-

lumsal uygarlık arasındaki yolda âdeta ister istemez eçilecek bir durağın varlığını söylememiz gerekiyor. Vakaların çoğunluğunda erken yıllardaki bu nevrotik evre kendiliğinden aşılmaktadır. Ancak nevrozlar ortalama sağlıklı kimselerde de birtakım izler bırakmıyor mu? Beri yandan çocukluk sonrasında nevroza yakalananların hepsinde, zamanında asla pek belirgin seyretmesi gerekmeyen çocuksal ber nevrotik rahatsızlıkla bağlantının varlığını görüyoruz. Sanırım bugün dahiliyeciler de, buna düpedüz benzer bir görüşten kalkarak, her insanın çocukluğunda bir yol tüberküloz geçirdiğini ileri sürmektedir. Arada bir fark varsa, nevrozlarda bir aşidan söz açılmayacağı, sadece bir yatkınlığın söz konusu edilebileceğidir.

Şimdi de sizin kesinliğe ilişkin sorunuza döneceğim, Şunu birkez daha belirteyim ki, çocuklar üzerinde dolaysız psikanalitik gözlemler sonucu yetişkinlerin kendi çocuklukların ilişkin açıklamalarını doğru yorumladığımız kanısı bütün genelliğiyle yerleşti içimize. Ayrıca, bir dizi vakada bir başa bulgumuzun doğrulandığını görme fırsatını ele geçirdik. Psikanaliz denemelerinin sağladığı malzemeye dayanarak, hastaların bilinçli anımsamalarında izine rastlamadığımız bazı dış olayların, çocukluktaki bazı önemli yaşantıların yeniden diriltiliminde (reprodüksiyon) çalışmış, kimi mutlu rastlantılar ve anne-babalarla çocuk bakıcılarına başvurarak yaptığımız soruşturmalar bizim bu konudaki bulgulamamalarımızın gerçekliğini yadsınmaz biçimde tanıtladı. Tabii pek sık sağladığımız bir basan değildi bu, ama her ortaya çıkışında üzerimizde alabildiğine güçlü bir etki yaptı. Hani şurasını söyleyeyim ki, nesnel bir doğrulanmaya imkan versin ya da vermesin, bu çeşit unutulmuş çocukluk yaşantıların rekonstrükyiyonunun şifaya kavuşturucu bir etisi bulunmaktadır. Unutulmuş olaylar, önemlerini pek tabii çok erken bir zamanda, henüz güçsüz Ben'i travmatik bakımdan etkileyebilecekleri bir dönemde geçmelerine borçludur.

"Peki, psikanalizde bulgulanacak bu olayların içyüzünü açıklar mısınız?"

"Çeşitli olaylardır bunlar. En başta çocuktaki filizlenmeye duran cinsel yaşamı sürekli etki altında tutma gücüne sahip izlenimler, sözgelişi yetişkinler arasında bazı cinsel birleşme eylemlerinin gözlemlenmesi ya da çocuğun bir yetişkinle ya da bir başka çocukla arasında geçen ve hiçde seyrek rastlanmayan cinsel olayların yaşantıları, ayrıca çocuğun kulak misafiri olup işittiği zaman ya da ancak daha sonraları kavradığı ve kendisini, esrarengiz yada natemeli bazı konularda aydınlığa kavuşturuyor sandığı bir takım konuşmalar, bundan başka onun diğer kişiler karşı gösterdiği önemli derecede sevecen ya da düşmanca dışavurum ve davranışlardır. Kendi unuttuğu cinsel faaliyetle bu faaliyete yetişkinlerin işe karışarak bir son verişlerini çocuğa anımsatmak ayrı bir önem taşır psikanalizde.

"Bu açıklamanız çoktan sormak istediğim bir soruyu tarafınıza yöneltmem için bir neden oluşturuyor. Sizin deyişinizle psikanalizden önce görülmeden geçilmiş bu erken dönemdeki çocuksal cinsel faaliyet'in içyüzü nedir?"

Bu cinsel faaliyette düzenli kendini gösteren ve başlıca önem taşıyan bir özelliğin ne garipse daha önceleri de farkına varılmıştır, daha doğrusu öyle garipliği falan da yok bunun, söz konusu özellik görmezlikten gelinecek gibi değildi, o kadar. Çocuktaki cinsel içtepilerin ilk planda gelen dışavurum biçimi, biçimi, üreme organlarını daha doğrusu bunlardan erkeklik organının uyararak kendi kendinize doyum sağlamaktır. Çocuklarda alabildiğine yaygın gözlemlenen bu kötü huy yetişkinlerce hep bilinmekte, buy huy ağır bir günah gözüyle bakılarak yakından izlenmekte, sıkı bir kontrol altına tutulmaktaydı. Çocuklarda rastlanan bu ahlaka aykırı eğilimlerin-çünkü çocuklar, dediklerine bakılırsa, haz sağladığı için kendi kendine doyum sağlama yoluna başvurmaktadır onların doğuştan saf ve şehvetten uzak yaratıklar olduğu kuramıyla nasıl bağdaşabileceğini

bana sormayınız Müsaade edin bu bilmeceyi karşı taraf bir çözüme ulaştırın. Bizi buradan çıkan daha önemli bir sorun beklemekte, o da şu: İlk çocukluktaki cinsel faaliyet karşısında nasıl bir tutum takınmalıyız? Bu faaliyeti bastırma yoluna gitmekle yüklenilecek sorumluluk ortada; öte yandan hiç bir sınırlamaya gitmeden çocukları bu faaliyetlerinde serbest bırakmak da pek göze alınacak gibi değil. Aşağı bir uygarlık aşamasındaki kavimlerde ve uygar ulusların alt tabakalarında çocuklardaki cinselliğe bir özgürlük tanınıyor gibidir. Çocuk cinselliği karşısındaki böyle bir davranışla çocuklar ilerde nevrotik hastalıklara yakalanmaktan enikonu esirgenmektedir gerçi; ama söz konusu davranış çocukları uygarlık uğraşlarına elverişlilik bakımından alabildiğine büyük kayıplarla karşı karşıya bırakmıyor mu acaba? Bu konuda yeni bir Scylla ile Charybdis* karşısında kaldığımızı gösteren bazı belirtiler yok değil.

Cinsel yaşamlarının araştırılmasıyla nevrozlularla uyancak cinsel ilginin bir şehvet düşkünlüğünün ortaya çıkmasına elverişli bir zemin yaratıp yaratmayacağını ise, sizin takdirinize bırakıyorum.

V

"Sanırım, niyetinizi anladım. Psikanaliz uygulamaları için ne gibi bilgilerin gerektiğini bana açıklamak böylece yalnız hekimlerin bu işe yetkili olup olmadıkları konusunda bir yargıya varmamı sağlamak istiyorsunuz. Bilmem ama, şimdiye kadarki konuşmalarda hekimlikle ilgili pek fazla bir

* Yunan efsanesine göre Scylla, Charybdis boğazına karşı bir mağarada yaşayan ve gelip geçen denizcileri yeyip yutan bir deniz canavarıdır. Scylla ile Charybdis arasında sözü Almanca'da bir deyim olarak kullanılmakta ve iki felâket ya da iki ateş arasında anlamına gelmektedir. (Ç-N.)

şey geçmedi, bol bol ruhbilimin sözü edildi, biraz yaşambilim ya da cinselbilim üzerinde duruldu. Ama belki henüz sonuna gelmedik işin?"

Elbette gelmedik, henüz arada birtakım boşluklar var dolduracak. Sizden bir ricada bulunabilir miyim? Şimdiye kadarki konuşmamıza göre, psikanalitik bir tedaviyi kafanızda nasıl tasarladığınızı bana anlatır mısınız? Hani öyle anlatın ki, sanki siz kendiniz bu tedaviyi yapıyormuşsunuz gibi olsun.

"Oh, ne güzel iş. Doğrusu tartışma konumuzu böyle bir deneyle kesin sonuca bağlamak gibi bir niyetim yok. Ama hatırınızı kırmayacak, istediğinizi yapacağım, sorumluluğu nasıl olsa size ait. Evet, turalım ki, hasta bana geldi de birtakım rahatsızlıklardan yakınıp sızlandı. Kendisine, dedikle-rimi yaparsa iyileceği ya da düzeleceği konusunda söz verdim. Bana rahatsızlığı üzerinde bildiği ne var, aklına ne geliyorsa hiç bir şey saklamadan tam bir açıkyüreklilikle söylemişini, dışavurumunu tatsız gördüğü şeyler bulunsa bile açıkyüreklilik ilkesinden sapmasını kendisinden istedim. Nasıl, psikanaliz bu kuralını iyi bellemiş miyim?"

Evet ancak bir şey daha istemeniz gerekiyor hastadan: Aklına gelen şey ona saçma ya da önemsiz bile görünse, yine bunu saklamayıp size bildirmesi.

"Peki, bunu da istiyorum kendisinden. Derken hasta anlatmaya başlıyor, ben de kulak verip onu dinliyorum. Hastanın konuştuklarından, onun ne gibi izlenimleri, yaşantıları ve içtepileri ruhunda geriye itim konusu yaptığını çıkarıyor, geriye itime başvurulmasını da söz konusu izlenim, yaşantı ve içtepilerle karşılaştığı zaman hastadaki Ben'in henüz bunlarla başedecek güçte olmadığına, üzerlerine yürüyecekken onlardan korkup kaçmasına bağlıyorum. Hasta ele geçirdiğim bulguları benden öğrenir öğren-

mez, bir zamanki durumları yeniden yaşıyor ve bu kez benim yardımımıla daha doğru bir yol izliyor. Derken Ben'inin ister istemez boyun eğdiği sınırlamalar ortadan kalkıyor, o da böylece sağlığına yeniden kavuşuyor. Nasıl tamam mı?"

Bravo, bravo. Öyle görüyorum ki, yine tarafıma bir suçlama yöneltecek, hekimlikten uzak bir kimseyi, eğitip psikanalist yaptığımı söylecekler. Bakıyorum, anlattıklarımı çok güzel özümlemişsiniz.

"Ben sadece sizden dinlediklerimi tekrarladım, o kadar insan nasıl ezber ettiği bir şeyi söyler, işte onun gibi. Çünkü böyle bir şeyi nasıl yapacağımı yoksa nerden tasarlayabilirim. Sonra anlamadığım bir nokta varsa, böyle bir çalışmanın pek çok aylara bakması, her gün bir saat gibi bir zamanı gerektirmesi. Hani normal bir insan genel olarak o kadar çok şey yaşayamaz; küçüklüğünde geriye itimi konusu yaptığı nesneye gelince, bu da her halde bütün hastalarda aynı şeydir."

Psikanalizin gerçek uygulamasında öğrenilecek daha pek çok şey vardır. Sözügelşi, hastanın açıklamalarından onun unuttuğu yaşantıları, onun bir vakit geriye ittiği içtepileri bulup çıkarmanın hiç de kolay olmadığını göreceksiniz. Hasta bakarsınız size bir şey söyler, söylediğine ilkin ne kendisi, ne de sizin için bir anlam taşır gidir. Önce sizin, hasta tarafından psikanalitik kurala uyularak yapılan açıklamaları pek ayn biçimde anlamaya bir kez karar vermeniz, hasta tarafından psikanalitik kurala uyularak yapılan açıklamaları pek ayrı biçimde anlamaya bir kez karar vermeniz gerekir, içindeki değerli maden muhtevası belirli bir takım işlemler sonucu ele geçirilen bir maden cevheri gibi tıpkı. Tonlarca cevheri işleyeceksiniz de aradığınız o kıymetli madenden belki biraz ele geçireceksiniz, o kadar. Bu da işte psikanalitik tedavi kürünün uzayıp gitmesinin başlıca nedenini oluşturuyor.

"Peki sizin bu benzetmenize göre konuşursak gerekli o kadar çok ham maddeyi nereden sağlayacaksınız?"

Hastanın açıklamalarının, hastadaki aklagelimlerin aranırlar'ın sadeci biçim değıştirmiş dışavurumları olduđunu, gizledikleri şeylerin, bulgulanması gereken âdeta bir takım imalar niteliğı taşıdığını benimseyerek. Tek kelimeyle ister anı, ister aklagelim, ister düş, hastanın sunduđu bu malzemeyi ilkin yorumlayacaksınız. Bu yorum da tabii, hastanın anlattıklarına kulak verirken, psikanalitik bilgileriniz sizin için belirleyeceğı umut ve önbekleyişler çerçevesi içinde yapılacaktır.

"Yorumlamak ha! İğrenç bir söz! Hiç sevmem işiteyim. Bu sözü sizden duymakla bütün güvenim uçup gitti. Diyelim herşey benim yorumuma bağı, peki yorumumun doğruluğına kim garanti edecek? Herşey bu konuda benim keyfime kalmış demektir, öyle değil mi?"

"Sakin olun, sakın olun, o kadar da değil. Ne diye kendi ruhunuzdaki olayları ayırıyor, başkalarının ruhsal olaylarındaki gibi bunların da bir yasallık içerisinde geçtiğini düşünmüyorsunuz? Çalışmalarınızda belli bir disiplin havasını egemen kılabildiniz de, psikanaliz konusunda gerekli bilgileri edindiniz mi, yapacağınız yorumlar kişisel etkinizden uzak kalacak ve isabetli yorumlar niteliğini kazanacaktır. Hasta karşısında üstlenilecek ödevin bir parçası bakımından psikanilistin kişiliğinin önemini yadsımak istiyor değilim. Bilinçdışındaki geriye itilmiş malzemeyi seslenebilmek için hassas kulaklar gerekir. Herkesin kulağının da aynı ölçüde hassaslıkla donatıldığını söyleyemeyiz. Ve herşeyden önce psikanalisti bir yükümlülük beklemektedir burada, önce kendisi üzerinde uygulayacağı enine boyuna bir analizle psikanalist, hastaların sunacakları malzemeye önyargılardan uzak bir tutumla yaklaşma yeteneğini elde eder. Elbet, astronomik gözlemlerde "kişisel denkleştirme"

diye nitelenebilecek bir durum varlığını sürdürür herşeye rağmen; bireysel faktör her vakit psikanalizde diğer bütün alanlarındakinden daha büyük rol oynayacaktır. Anormal bir insan mükemmel bir fizikçi olabilir, ama anormalik, psikanalitik uygulamalarda ruhsal yaşamın görüntülerinin bütün eciş bücüşlüklerden uzak biçimde ele geçirilmesini engeler. Hiç kimsenin anormalliği tanıtlanıp kendisine benimsitemeyeceğine göre, derinlik psikoloji siyle ilgili konularda genel bir uyuşma sağlamak pek güçtür; hatta bazı psikologlar bunun büsbütün imkansızlığını ileri sürer, her aptalın aptallığını bilgelik diye satmaya nihayet hakkı bulunduğu görüşünü savunurlar; itiraf edeyim ki, ben bu konuda biraz daha iyimserim. Ne de olsa tecübelerimiz, psikolojidir de enikonu uyuşumların sağlanabileceğini göstermektedir. Nihayet hangi araştırma alanı olursa olsun, hepsinde de ortadan kaldırılmasına çaba harcanması gereken bir güçlük çıkar karşımıza. Zaten psikanalizin yorum tekniğinde de kimi şeyler, sözgelişi sembollere başvurularak o kendine özgü dolaylı anlatıma ilişkin gerçekler başka bilgiler gibi öğrenilebilir.

"Artık zihnen de olsa psikanalitik bir tedavi denemesine girişmek konusunda içimde hiç heves kalmadı. Değil mi ama böyle bir tedavide kimbilir daha ne sürprizlerle karşılaşacaktır insan."

Söz konusu niyetten vazgeçmekle iyi edersiniz doğrusu. Bu işin ne geniş çapta bir eğitim ve pratiği gerektirdiğini görüyorsunuz. Diyelim doğru dürüst yorumların üstesinden gelebildiniz, o zaman da yeni bir ödev gözler sizi. Bekleyecek yorumunuzu bir basan umuduyla hastaya açıklamak için uygun anı kollayacaksınız.

"Peki her seferinde bir anın uygunluk ya da uygunsuzluğunu nenden anlayacaksınız?"

Bu, tecrübelerle pek olgunlaştırılıp mükemmelleştirilebilen bir incelik sorunudur. Sözel gelişimi psikanalitik tedavi sürecini kısaltmak amacıyla yorumlarınızı ele geçirir geçirmez hastaya bildirmeye kalkarsınız, ağır bir yanılgıya düşersiniz. Bunu yapmakla hastada karşıkoymusal dışavurumlara, yadsımalara ve kızgınlıklara yol açmaktan başka bir şey geçmez elinize; beri yandan hastanın geriye itilmiş nesneler üzerinde bir egemenlik kurmasını sağlayamadan kalırsınız. Bu konuda uyulması gereken kural, hastanın kendisinin geriye itilmiş nesneye yaklaşmasını, sizin yorum önerilerinizin kılavuzluğu altında hepsi birkaç adım atıp yanma ulaşacağı kadar hastanın bu nesnelere sokulmasını beklemektir.

"Öyle sanıyorum ki, benim hiç bir vakit öğrenebileceğim bir şey değil. Haydi diyelim, yorum konusunda bu kuralları uydum, sonra?"

O zaman belki ummadığımız bir bulgu size gelip, kendini buyur edecektir.

"Nasıl bir bulguymuş bu?"

Hastanıza ilişkin düşüncenizde yanıldığınız, onun yardım ve uysallığına gerçekte asla güvenmememiz gerektiği, ortak sürdürdüğünüz çalışmaya hastanızın hiç de sanıldığı gibi sağlığına kavuşmak istemediği.

"Yo, bu kadar da değil! Bana şimdiye dek anlattıklarınız içinde en kaçıkça görüneni bu sözler. Dolayısıyla inancımın bir tarafı yok. O kadar acı ve ıstıraplar içinde kıvranan, o kadar yürek paralayıcı bir dille şikayetlerini sıralayıp duran, tedavi konusunda o kadar büyük fedakârlıklara katlanan hasta gerçekte şifaya kavuşmak istemeyecek, öyle mi? Herhalde siz de bu sözleri ciddi söylemiş değilsiniz."

Kendinizi toparlayınız; sözlerim ciddi konuştuklarım gerçektir; gerçeğin tümü değil tabii, ama pek dikkate değer bir parçasıdır. Hasta iyileşmeyi hem ister, hem istemez. Hastanın Ben'i birlik ve bütünlüğünü yitirmiştir, dolayısıyla irasedesi de birlik ve bütünlükten yoksun bulunur. Başka türlü olsaydı, zaten nevroza yakalanmazdı.

"Aklı başında biri olaydım, adım Teli olmazdı."*

Geriye itimden kaynağını alan birtakım güçler hastanın Ben'i içerisine bir yolunu bulup gitmiştir; bundan böyle bu Ben içerisinde tutunur, varlığını sürdürür; geriye itilmiş nesneler üzerinde nasıl Ben egemenliğini elden çıkarmışsa, o kaynaktan gelen eğilimleri de denetim altında tutamaz, zaten normal olarak bunların hiç farkında değildir. Anlayacağınız nevrozlular başka hastalara benzemez, bizim hesaba katmaya alışmadığımız güçlükler çıkarır karşınıza. Toplumsal kurumlarımızın tümü de, ya fonksiyonunu yerine getiren ya aşırı güçte bir etkiyle bu fonksiyonu görme yeteneğinden yoksun bırakılan ve bizim iyi ya da kötü diye sınıflara ayırdığımız tutarlı ve normal bir Ben'e sahip kişilere göre düzenlenmiştir. Hukuktaki o sorumlu ya da sorumsuz alternatif de buradan ileri geliyor. Oysa bütün bu kesin yargılar nevrozlulara uymaz. Toplumsal gerekleri onların psikolojik

* Alman ozanı Schiller'in (1759-1805) VVilhelm Teli adlı oyununun (3. perde, 3.sahne); imparator adına İsviçre ve Uri'de yönetimi elinde bulunduran Gessler zalim bir kişidir. Sözde halkın imparatora sadakctlerini sınamak için meydana bir direk diktirerek tepesine bir şapka oturtmuş, direğin önünden gelip geçenlerin şapkaya selâm vermesini buyurmuştur. VVilhelm Teli şapkaya selâm vermeden geçmek ister, ancak nöbetçi tarafından yakalanır. O sırada karşıdan gelen Gessler VVilhelm Tell'e bu davranışının nedenini sorar, VVilhelm Teli de buna karşılık, davranışının kasdi olmadığını, bir düşüncesizlikten ileri geldiğini söyler, "Aklı başında biri olaydım, adım Teli olmazdı." diyerek bu sözlerini pekiştirir ve bağışlanmasını diler. VVilhelm Tell'in bu sözleri sonradan bir deyim niteliği kazanmıştır.

durumlarına uydurmanın güçlüğüne itiraf etmeliyiz. Bu durum son savaşta geniş ölçüde yaşanmıştır. Acaba askerlik görevinden kaçan nevrozlular kendilerine hasta süsü veren kimseler miydi, değil miydi? Bu gibilerine kendilerini hasta gösterenler gibi davranılıp, hastalıkları pek eza verici duruma sokulur sokulmaz iyileşmiş, ama sözde iyileşenler tekrar tutulup cepheye yollandı mı, o saat yine kaçıp hastalığa sığınmışlardı. Bu gibiler karşısında nasıl bir yol izleneceği bilinmemişti bir türlü. İşte aynı durum sivil yaşamdaki nevrozlular için de geçerlidir. Bunlar da sızlanıp yakınırlar, ama hastalıklarından da güçleri yettiği kadar yararlanmaya bakarlar. Hastalıklarını ellerinden almaya kalktınız mı, yavrusunu bir dişi arslan nasıl ata sözüne geçmiş bir haşmetle savunursa, öylece savunurlar bunu ve söz konusu çelişkiden ötürü kendilerine bir suçlama yöneltmenin hiç bir anlamı yoktur.

"Peki ama o zaman, bu problemi insanları hiç tedaviye yanaşmamak, onları kendi kaderiyle baş başa bırakmak daha yerinde değil mi? Öyle sanıyorum ki, sizin değinmelerinizden anlaşıldığına göre, bu kadar çok çaba harcayarak söz konusu hastaları teker teker tedavi etmek zahmete değmez doğrusu."

Önerinize evet diyemeyeceğim. Yaşamın ortaya çıkacağı çetin durumlara karşı diretmek yerine bunları benimsemek elbet daha doğru yoldur. Tedaviye çalıştığımız nevrozlulardan bazıları, kendilerini psikanalitik yoldan tedavi için o kadar çaba harcamaya lâyık kimseler değildir belki; ancak, nevrozlular arasında pek değerli kişiler de vardır. Amacımız, böylesine kusurlu ruhsal bir donatıyla elden geldiğince az kişinin uygarlık yaşamı karşısına çıkmasına çalışmak olmalıdır; bunun için de çok tecrübe edinmemiz, çok şeyi kavramasını öğrenmemiz gerekmektedir. Tek tek hastaların kişisel değerlerini bütünüyle bir yana bırakırsak her analiz bizim için yapıcı bir karakter taşır, yeni aydınlanmalara ulaşmamız bakımından bize yararlar sağlar.

"Ama hastanın Ben'inde hastalığı elden çıkarmamak gibi bir istek olmuşsa, bunun birtakım nedenleri ve kaynakları, kısaca kendini haklı çıkaracak bir dayanağı bulunmalı. Geldim, bir insan niçin hasta kalmak istesin, bundan ne gibi bir kazanç umabilir? Anlaşılabilecek gibi değil."

Yo yo, öyle anlaşılmayacak bir yanı yok bunun. Savaş nevrozlarını düşününüz, bir askerlik görevi yapmak zorunda değildir, bunlar, çünkü hastadırlar. Sivil yaşamda hastalığa, meslek yaşamı ve başkalarıyla rekabetteki yetersizliği bağışlatma, aile onamında ise aile bireylerinin özgeçerlik ve sevgilerini sağlamak ya da isteklerini onlara zorla kabul ettirmek için bir çare diye başvurulabilir.

Bütün saydıklarım enikonu yüzeysel şeylerdir ve "hastalık kazancı" deyişi altında özetlenecek bir durumdur. Ancak dikkate değer bir nokta varsa, hastanın, hastadaki Ben'in bütün bu nedensel halkalarını iç içe girerek yaptığı zincirden ve bunların mantıksal sonuçları olan davranışlardan düpedüz habersiz bulunmasıdır. Hastanın Ben'inin bunlardan bilgi sahibi olması sağlanarak, ondaki söz konusu eğilimlerin etkisi giderilmeye çalışılır. Ancak hastalığa sarılıp onu bırakılmamasında, kendileriyle o kadar kolay başa çıkılamayan daha derinlerde saklı başka nedenler de bir rol oynar. Ne varki, psikanalizin ruhsalbilimsel kuramı içerisinde bir gezintiye çıkmadan bu sonuncu nedenler kavranılamaz.

"Siz anlatmanıza bakın, birazcık daha fazla kurumsal bilgi sunmuşsunuz, bundan böyle ne farkeder?"

Daha önce sizi Ben ile Es arasındaki ilişkiyi açıklarken, ruhsal aygıt konusundaki öğretilerden önemli bir parçayı sükutla geçiştirdim. Diyeceğim, psikanalitik araştırmalar sonucu, Ben'in kendisinde Üstben adını verdiğimiz özel bir mekanizmanın zamanla farklılaşıp gelişerek onaya çıktığını kabul zorunda kalmıştık. Üstben, Ben mekanizması içerisine girer, ondaki yüksek psikolojik örgütü Ben ile paylaşır, ama es'le arasında pek içten bir ilişkiyi de

sürdürür; gerçekte ilk obje gibi davranabilir, ona karşı çokluk pek katı bir tutum takınabilir. Es ile olduğu gibi Üstben ile de bir dirlik düzenlik içerisinde yaşamak Ben için önemlidir. Ben ile Üstben arasında başgösterecek uyumsuzluklar ruhsal yaşam için büyük bir önem taşır. Üstben'in bizim vicdan dediğimiz nesnenin temsilcisi olduğunu sanırım sezdimiz. Üstben'in normal gelişimi, yani yeterince kişiselikten uzak bir karakter kazanması ruhsağılığı bakımından pek gereklidir. İşte bu da Ödipus kompleksleri doğru dürüst bir değişim geçirmemiş nevrozlularda rastlanmayan bir durumdur. Nevrozluların Üstben'i tıpkı bir çocuk karşısında sert babanın tutumu gibi Ben'e aykırı bir davranış içerisinde, bir nevrozlunun ahlaksal yönelimi, Ben'in Üstben tarafından cezalandırılması gibi ilkel bir biçimde açığa vurur kendini. Hastalık işte bu öz cezalandırmayı bir araç diye kullanılır, nevrozlu sanki benliğine bir suçluluk duygusu egemenmiş, bu duygu bir doyum imkanına kavuşmak üzere hastalığı bir ceza olarak gereksiniyormuş gibi davranmak zorundadır ister istemez.

"Söylediklerinizde gerçekten esrarengiz bir hava var. İşin en acayip tarafı, hastanın kendi vicdanındaki bu gücün de bilincine varamayıdır."

Evet, bütün saydığımız önemli ilişkileri ancak şimdi değerlendirmeye başlıyoruz. Bu yüzden, anlattıklarım biraz karanlık kapalı düştü. Müsaadenizle konuşmamı sürdüreyim. Biz psikanalistler, hastadaki iyileşme çabasına karşı koyan bütün gençlere hastanın "karşıkoymaları" adını vermekteyiz. Hastalık kazancı böyle bir karşıkoyma'a kaynaklıkta bulunur, "bilinçsiz suçluluk duygusu" ise Üstben'sel karşıkoymu temsil eder, bu duygu bizim kendisinden en çok korktuğumuz alabildiğine güçlü bir faktördür. Ama psikanalitik tedavide daha başka karşıkoymalarla da karşılaşırız. İlk çocukluk yıllarında Ben korkudan bir geriye itim'e başvurmuşsa, hâlâ bireyde varlığını sürdüren bu korku, Ben'in geriye itilmiş nesneye

yaklaşması istendiği zaman, bir karşıkoyum kılığında açığa vurur kendini. Nihayet, yıllar ve yıllar süresince belli bir yolu izledikten sonra, içgüdüsel bir olayın birden önünde beliren bir başka yolda yürümesinin kolay gerçekleştiremeyeceğini tasarlayabiliriz. Bu durumu, Es'in karşıkoyumu diye nitelemekteyiz. Bütün bu karşıko-yumlarla savaşmak psikanalitik tedavide bizim başlıca uğraşımızdır, bunun yanında yorumsal ödev âdeti ortadan silinip gider. Ancak bu savaşla ve karşıkoyumların alt edilmesiyle hastanın Ben'i de öylesine bir değişme geçirir, öylesine güçlenir ki, psikanalitik tedaviyi sona erdirdikten sonra hastanın gelecekteki davranışlarını hiç telaş etmeksizin izleyebiliriz. Öte yandan, ne diye bu kadar uzun süren bir psikanalitik tedaviye gereksinmey duyulduğunu da artık anlamışsınızdır sanırım. Geride bırakılan gelişim yolundaki uzunluğun ve malzemedeki zenginliğin bu konuda kesin önem taşımadığını söyleyebiliriz. Daha çok, önemli nokta yolun açıklığı ya da kapalılığıdır. Barış döneminde trenle birkaç saatte alınan yol, savaşta düşmanın direnişiyle karşılaşılınca bir ordu için ancak haftalar sonrası geride bırakılabilir. Bu tür savaşlar ruhsal yaşamda da zaman alır. Maalesef şurasını belirtmek isterim ki, psikanalitik tedavi kürünü enikonu kısaltma bakımından şimdiye dek girilen bütün çabalar başarısızlığa uğramıştır. Bu kısaltmanın en iyi yolu, adı geçen tedaviyi bütün gerekleriyle uygulamaktır.

"Hani içimdeki bir hevesle uysaydım da, sizin mesleğinizde bir şarlatan olarak ortaya çıkmak ve bir başkası üzerinde psikanalitik tedavi uygulamasına kalkışmak isteseydim, az önce karşıkoyum konusundaki açıklamalarınızla hizaya gelir, bundan vazgeçerdim. Peki, sizin de varlığını teslim ettiğiniz o kendine özgü kişisel etkide durum nasıl? Söz konusu karşıkoyumların üstesinden gelinecek gibi değil mi?"

Böyle bir soruyu tarafıma yöneltmeniz güzel. Bu kişisel etki bizim güçlü dinamik silahımızdır, bizim yeni bir çare

diye tedavi sürecine katıp, bu süreçte bir akış sağladığımız güçtür. Açıklamalarınızdaki düşünsel muhteva ise bunun üstesinden gelemez, çünkü çevrenin bütün önyargılarını paylaşan hasta bilimsel eleştirmenlerimiz gibi pekala bize inanmayabilir. Bir nevrozlu psikanaliste başvuruyorsa, ona inandığı içindir; psikanalistin şahsıyla ayrı bir duygusal bağlantı kurabildiğinden psikanaliste inanır. Nihayet çocuklar da kendilerine yakınlık duydukları kimselere inanırlar. Bu güçlü "telkinsel" etkiden de hangi amaç uğrunda yararlandığımız daha önce size söylemiştim. Arazların bastırılması değildir bu amaç ki bu da psikanalitik yöntemi öbür psikoterapi yöntemlerinden ayıran bir noktadır; söz konusu etkiye, varlığında belirecek karşıkoymulan hastanın Ben'inin yenmesini sağlamak üzere itici bir güç olarak başvururuz.

"Peki bunun üstesinden gelince, işler düzene girmiş sayılmaz mı?"

Evet öyle olması gerekirdi aslında. Gelgelelim, hiç beklenmedik bir güçlük açığa vurur kendini; psikanalist, hastanın kendisiyle ilişkisinin bambaşka bir nitelik taşıdığını sezerek, belki şaşkınlıkların en büyüğüne kapılır. Psikanalitik tedavi uygulamasında bulunan ilk hekim* bu ben değilim hani-böyle bir olayla yüz yüze gelerek ne yapacağını bilememiş, bu da onu yanlış yollara itmiştir. Yani açıkça söylemek gerekirse, söz konusu ilişki hekime karşı bir sevisel tutkunluk karakteri gösterir. Tuhaf, değil mi? Hele psikanalistin böyle bir tutkunluğa ön ayak olacak hiç bir eylemde bulunmadığını, tersine insancıl bir davranışla kendini hastadan uzak tuttuğunu, şahsını belli bir çekimserlik ağıyla kuşattığını dikkate alır, üstelik bu sevi ilişkisinin gerçekteki koşullarının olumluluk ya da olumsuzluğuna hiç bakmadığını, kişisel alımlılık, yaş, cinsiyet ve mesleğe ilişkin ayrıntıları umursamadığını öğrenirsiniz. Bu

* Josef Breuer anlatılmaktadır. (Ç.N.)

sevgi doğrudan doğruya zorlayıcı bir özellik taşır. Hani bu kendiliğinden ortaya çıkan sevisel tutkunlukla başka zamanlar karşılaşılıyor değildir. Biliyorsunuz, bunun tersi pek sık rastladığımız bir durumdur; ancak psikanalitik tedavi sürecinde aranması gereken bir nedeni yoktur. Hastanın psikanaliste ilişkisinden hasta için sadece belli bir ölçüde saygı, güven, şükran duygusunu ve insancıl bir sempatinin doğup çıkacağını düşünür, gelgelelim onun yerine bir hastalık belirtisi izlenimi uyandıran bu sevisel tutkunlukla yüz yüze geliverirsiniz.

"Bilmem ama, bana kalırsa, bu sizin psikanalitik amaçlarınız için uygun bir şey olsa gerek. Seven bir kimse uysallaşır nihayet ve sevdiği kimse için sevgisinden neler, neler yapmaz."

Doğru, işin başında psikanalitik tedavi için olumlu bir durumdur bu; ancak sonraları, sevisel tutkunluk bir derinlik kazanınca, bütün içyüzü açığa vurur kendini ve psikanalizin amacıyla ulaşmaz birtakım özellikler içerdiği görülür. Hasta sevisel tutkunluğundan ötürü hekimin sözünü dinlemekle kalmaz, birtakım istekler öne sürer, sevisel ve cinsel doyumlar arar, hekimin yalnız kendisiyle ilgilenmesini diler, kıskançlık duygularına kapılır; söz konusu sevgi, gittikçe daha açık seçik, ters yüzünü açığa vurur; amaçlarına ulaşamadı mı, düşmanlıklara ve öç alma duygularına dönüşme eğilimi gösterir. Aynı zamanda, bütün tutkunluklar gibi öbür ruhsal muhtevaları geriye iter, psikanalitik tedavi kürüne ve iyileşmeye karşı hastadaki ilginin sönüp gitmesine yol açar; kısacası, bütün bunlar karşısında söz konusu sevginin hastadaki nevrozun yerine geçtiği, uğraşıp didinmelerimizin bir hastalık biçimini kovarak yerine bir başkasını geçirmekle sonuçlandığı konusunda hiç bir kuşkumuz kalmaz.

"Doğrusu hazin bir hava esiyor söylediklerinizde. Peki, bu durumda ne yapılabilir? Psikanalitik tedaviye son vermekten başka çıkar yol yok; ancak, dediğiniz gibi böyle bir

sonuçla her vakada karşılaşıldığından, en doğrusu psikanaliz tedavisinden büsbütün el çekmektir."

İlkin ortadaki koşullardan yararlanarak, öğrenilecek kimi şeyleri öğrenmeye çalışalım. Ele geçireceğimiz bilgilerin, durumu kontrol altına almakta yardımı dokunabilir bize. Muhtevası ne olursa olsun, bir nevrozu hastalıklı bir sevisel tutkunluğa dönüştürebilmemiz, alabildiğine dikkate değer bir basan değil midir?

Her nevrozun temelinden kötüye kullanım konusu yapılmış sevi yaşamından bir parçanın saklı yattığına inancımızın, psikanalitik tedavi sürecindeki bu olayla sarsılmaz biçimde pekiştirilmiş olması gerekir sanırım. Şimdi bu yoldaki bilgiyle yine ayaklarımızı sağlam toprak üzerine basar, bu sevisel tutkunluğun kendisini analiz konusu yapmayı göze alabiliriz. Beri yandan, gözlemlerimiz sonucu bir başka gerçeği daha bulgularız: Psikanalitik tutkunluk bütün vakalarda benim anlatmaya çalıştığım gibi açık seçik ve keskin çizgilerle açığa vurmaz kendini. Peki ama, niçin? Çok geçmeden bunun nedenini görüp anlanz. Hastadaki tutkunluk o tam anlamıyla cinsel ve düşmanca taraflarını ne kadar dışavurmak isterse, hastanın içinde bu dışavurumlara karşı o ölçüde bir direniş kendini belli eder. Bu dışavurumlarla boğuşur hasta, gözlerimizin önünde onları geriye itmeye çalışır. İşte bu da bizim karşılaştığımız olayı kavramamızı sağlar. Hasta psikanaliste duyduğu sevisel tutkunlukta, daha önceleri bir kez yaşadığı ruhsal olayları tekrarlamaktadır, kendisinde hazır bekleyen ve nevrozunun doğuşuna sıkı sıkıya bağlı bulunan ruhsal tutum ve davranışlarını şimdi psikanalist üzerine aktarmıştır. Ve yine hasta bir zamanki savunusu tepkilerini gözlerimizin önünde tekrarlar, o unuttuğu yaşam döneminde kalmış başından geçen bütün olayları yeniden yaşamak için güçlü bir istek duyar. Yani bizim önümüze çıkardığı şey, mahrem yaşam öyküsünün çekirdeğidir; **bu çekirdeği anımsamaz da, onun yaşanılan an içinde elle tutulur gözle**

görölür biçimde somut yoldan reproduksiyonuna (yeniden diriltim) gider. Böylelikle aktarım sevgisinin bilmecesi çözölür ve biz de psikanaliz tedavisini özellikle pek netameli görünen bu yeni durumdan yararlanarak sürdürme olanağını ele geçiririz.

"Doğrusu bu buluşa diyecek yok. Peki, gerçekte âşık olmadığına, sadece eski bir olayı yeniden yaşadığına hastanın kendisi o kadar kolay inanabilir mi?"

Artık herşey bunun hastaya benimsetilmesine bakar, bunun sağlanabilmesi için de "aktarım" olayını ele almada tam bir becerinin varlığı zorunludur. Psikanaliz tekniğinin gereklerinin burada en yüksek bir noktaya ulaştığını görüyorsunuz. Aktarım konusunda en vahim hatalar işlenebilir ya da en büyük basanlar sağlanabilir. Aktarımı bastırıp ya da üzerinde durmayıp güçlüklerden yakayı sıyırmayı denemek saçmadır; çünkü o ana dek bütün yapılanlar bir psikanaliz tedavisi adına layık olmaktan uzaktır. Bir aktarım nevrozunun tatsız durumları kendilerini açığa vurur vurmaz, hastalara tutup yol vermenin öyle savunulacak yanı yoktur, üstelik bir korkaklıktan başka bir şey değildir bu. Hani cinleri davet edersiniz de, cinler görünür görünmez tabanları kaldırırsınız, onun gibi bir şey işte. Gerçi kimi zaman başka türlü gelmez elden; zincirinden boşanmasına yol açılmış aktarımın kontrol altına alınamadığı dolayısıyla psikanalisük tedavinin yanda kesilmesine gerek duyulduğu vakalarla karşılaşılabilir; ancak herşeye rağmen davet edilmiş cinlere kimin olanca gücünü kullanarak savaşması gerekmektedir. Aktarımın amaçlanma boyun eğmek, hastanın sevecenlik ve cinsel doyum isteklerini yerine getirmek, yalnız ahlaksal bakımdan haklı olarak yapılmayacak bir şey değil, aynı zamanda psikanalizle güdülen amaca ulaşmada teknik çare açısından düpedüz yetersiz bir davranıştır Kendi içinde daha önceden hazırlanmış bilinçsiz bir kişiyi düzeltimden geçirmeksizin tekrarlaması sağlanarak bir nevrozlu şifaya kavuşturulamaz. Hastayla

uzlaşmalara girişildiği psikanalaz tedavisinin ilerici seyrinde de çalışma ortaklığına karşılık kendisine parçasal doyumlar sunulduğu takdirde, hasta sigorta memurunu yola getirmeye uğraşan din adamının gülünç durumuna düşmekten sakınmalıdır; sonunda sigorta memura yola gelmeden kayabilir, din adamı ise, sigortalanmış, çekip gidebilir çünkü Aktanmsal durumdan yakıyı sıyrmanın tek yolu olayı geriye doğru izleyip, geçmişte hastanın söz konusu olayı gerçekten yaşadığı ya da istekleri yerine getiren hayal gücünün etkinliğiyle yaratıp ortaya koyduğu zamanan dayandırmaktır. Bu da psikanalistten enikonu beceri, sabır, sükûnet ve özgeçerlik isteyen bir iştir.

"Peki nevrozlu açığa vurduğu aktarım sevgisinin modelini ne zaman yaşamıştır sizce?"

Çocukluğunda ve genel olarak anne ya da babasıyla ilişkisinde. Daha önce bu ilk duygusal bağlantılara ister istemez ne büyük bir önem vermek zorunda kaldığımızı anımsayacaksınız. Diyeceğim, halkanın uçları burada birbirine kavuşuyor.

"Bitti mi sözünüz? Sizden o kadar çok şey dinledim ki, kafam biraz karışır gibi oldu. bana bir şey daha açıklayınız: Şu psikanaliz tedavisini uygulamada gerekli bilgiler nasıl ve nereden öğrenilebilir.?"

Günümüzde psikanaliz öğrenimi yapılan iki enstitüsü var. Birincisi **Berlin**'de olup, oradaki psikanaliz derneğinden Dr. Max Eitingon tarafından kurulmuştur. İkincisi **Viyana Psikanaliz Derneği**'nce yönetilmekte, küçümsenmeyecek fedakarlıklara katlanan demek üyelerinin maddi olanaklarıyla ayakta tutulmaktadır. Resmi makamların işe ilgisi, şimdilik bu yoldaki körpe girişimlerin karşısına güçlükler çıkarmaktan öteye gitmiyor. Bir üçüncü öğretim enstitüsü ise **Londra Psikanaliz Derneği** tarafından Dr. E. Jones'in yönetiminde açılmak üzeredir. Bu enstitülerde psikanalist adaylarının kendileri psikanalizden geçirilmekte, önemli bütün konularda verilen derslerle ku-

rum sal bilgiler edinmeleri sađlanıp, yaşı ve tecrübeli psikanalistlerin denetimi altında hafif vakalarda ilk psikanaliz tedavi uygulamalarını gerçekleştirmelerine izin verilmektedir. Böyle bir eğitim ve öğrenim için aşağı yukarı iki yıl gibi bir süre belirlenmiştir. Tabii bu sürenin bitiminde de henüz acemilik kaybolup, üstatlık payesinde erişilmez. Geri kalan eksik bilgilerin pratik çalışmalar ve genç üyelerin yaşı üyelerle buluşup görüştükleri psikanaliz derneklerinde yapılan fikir alış verişıyle elde edilmesi gerekir. Psikanalitik faaliyet için hazırlanma hiç de o kadar kolay ve basit değildir; iş zor, sorumluluk ise büyüktür, ama her kim böyle bir eğitim ve öğrenim görmüş, kendisi psikanalizden geçmiş bilinçdişı psikolojisi konusunda bugün öğretilbildiğı kadar bilgi edinmiş cinsellikten anlar duruma gelmiş, o çetin psikanaliz tekniğini bellemiş, yorum sanatını kavramış, karşıkoymularla savaşp onları alt edecek ve aktarım olayının içinden yüzünün aklıyla çıkabilecek bir yetenek kazanmıştır, o kimseye psikanaliz alanında amatör gözüyle bakılmaz artık. Böyle bir kimse nevrotik bozuklukların tedavisini üzerine alacak güce kavuşmuştur, zamanla bu tedaviden beklenen bütün başarılı sonuçları ortaya koyabilecek demektir.

VI

"Psikanaliz ne olduğunu ve başarılı bir psikanaliz uygulaması için ne gibi bilgilerin gerektiğini bana anlatmak amacıyla büyük çaba harcadınız. Güzel, sizi dinlemek bir şey kaybettirmez bana. Ama bilmiyorum, vereceğim yargı üzerinde açıklamalarınızdan nasıl bir etki bekliyorsunuz. Ben ortada pek olağanüstü lülüğü bulunmayan bir durum görüyorum. Nevrozlar özel bir hastalık çeşidi, psikanaliz de onların tedavisinde uygulanan özel bir yöntem kendine özgü hekimsel bir tedavi yoludur. Beri yandan, tıpta belli bir uzmanlık dalını seçen bir hekimin elindeki diplomayla onayla-

nan bir öğrenimle yetinmemesi genel kuraldır. Hele söz konusu hekim yalnız uzmanları geçindirebilecek büyükçe bir kentte yerleşmeyi düşünüyorsa. Cerrahlığa heveslenen kimse birkaç yıl bir cerrahi klinikte çalışır, oftalmoloji, larengoloji vb. lerinde de durum başka türlü değildir; hattâ bir psikiyatrisi, belki hiç bir vakit bir devlet psikiyatri kliniğinden ya da bir şifa yurdundan uzak kalma olanağı bulamaz. Demek psikanalizde de durum aynıdır; kim bu yeni özel tıp dalının öğrenimini yapmaya kararlıysa, asıl tıp öğreniminin bitmesinden sonra iki yıl bir enstitüde psikanaliz öğrenimi görecektir, gerçekten dediğiniz gibi o kadar uzun sürüyorsa bu öğrenim, bu süre içerisinde psikanaliz tekniğini bilmeyi göze alacaktır. Sonra ayrıca bir şey daha farkedecek, yani bir psikanaliz derneğinde meslekdaşlarıyla ilişki içerisinde bulunmanın kendisi için yararlılığını anlayacak, böylece tıkr tıkr yürüyecektir herşey. Peki ama, bu durumda amatör psikanalizin yeri neresi, anlamadım doğrusu?"

Sizin kendi adına vadettiğiniz gibi davranan hekim, bizim hepimizin başına basacağı biridir. Benim öğrencilerim olarak saydığım kişilerin beşte dördünün zaten hekimliktir mesleği. İzin verirsiniz, hekimlerin psikanaliz karşısında nasıl bir tutum takındıklarını ve ilerde bu ilişkinin nasıl bir gelişimi izleyebileceği konusunda bazı açıklamalarda bulunayım. Psikanalize tek başlarına sahip çıkma konusunda tarihsel bir hakları bulunmuyor hekimlerin; tersine, bu bayların kısa zaman öncesine kadar bütün yaptıkları, en sığ alaylardan tutun da en ağır kara çalmalara dek psikanalize zarar vermek olmuştur. Bu tutumun geçmişte kaldığı geleceği ille de etkilemesi gerekmeyeceği cevabını vereceksiniz. Doğru, bu noktada sizinle aynı düşüncedeyim; ama korkarım gelecek sizin anlattığınızdan daha başka bir görünüm taşıyacaktır.

İzin verirsiniz, "şarlatan doktor" deyimine yasal anlam yerine hakettiği bir anlam yükleyeceğim. Yasal bakımdan

elinde hekimliğini tanıtlayacak bir diploma bulunmaksızın hasta tedavisine kalkan kimse şarlatandır. Oysa ben bir başka tanıma üstünlük vereceğim: Kim zorunlu bilgi ve yeteneklerle donanmaksızın hasta tedavisine yeltenir, şarlatan hekim odur. Bu tanımdan kalkarak, yalnız Avrupa'da değil, daha başka ülkelerde de psikanaliz uygulamalarında bulunan hekimlerden hatırı sayılır bir yüzdenin şarlatan sayılmak gerekeceği savını öne sürmeye cesaret edeceğim. Psikanalizin içyüzünü öğrenmeksizin ve anlamaksızın bu hekimlerin pek sık psikanalitik tedaviye başvurdukları görülmektedir.

Böyle bir savı öne sürmenin, hekimlerden böyle bir şey ummanın insaf ve vicdanla bağdaşmayacak bir davranış olacağı gibi bir itirazı bana yöneltmekle boşuna zahmet edeceksiniz. Bir hekim, hekimlik diplomasının bir yağmalama fermanı, hastaninsa afarozlanmış bir kişi olmadığını nihayet bilir; yanılığa düşse bile, hekimin iyi niyetle davrandığını her vakit kabul etmek gerekir diyeceksiniz.

Gerçekler ortada; inşallah sizin dediğiniz gibi bir sonuca varılmasını mümkün kılar. Ben şimdi bir hekimin başka bir yerde titizlikle sakındığı davranışlara psikanaliz alanında nasıl başvurabileceğini açıklamaya çalışacağım.

Burada ilk planda söz konusu edilebilecek durum, hekimin tıp fakültesinden psikanaliz uygulamasına hazırlık diye görülmesi gerekinin aşağı yukarı karşıtı bir öğrenim görerek çıkmasıdır. Gördüğü öğrenimle dikkati, hekimsel başarıların doğru dürüst kavranılıp gerektiği gibi etki altına alınmalarına bağlı bulunduğu nesnel saptanabilir, anatomik, fiziksel ve kimyasal durumlar üzerine yönelmiştir. Görüş alanı içerisine, şimdiye kadar anorganik doğa'da da tanıtlayabildiğimiz çeşitli güçlerin etkinliğinden oluşan yaşam sorunu girmiştir. Tıp, yaşamsal olayların ruhsal yönlerine ilişkini bir ilgiyi hekimde uyandırmış değildir; daha yüce düşünsel fonksiyonların incelenmesi tıbbı ilgi-

lendirmemekte, bir başka bilim dalının kapsamına sokulmaktadır. Ruhsal fonksiyon bozukluklarıyla uğraşmak sadece psikiyatriye bırakılmıştır, ancak psikiyatrinin de bu işi ne türlü ve ne gibi amaçlarla yaptığı bilinmektedir. Psikiyatri ruhsal bozuklukların bedensel (somatik) koşullarını arayıp bulmaya ve bu bozuklukları diğer hastalıklar gibi tedaviye çalışır.

Psikiyatri bunda haklıdır, tıp fakültelerindeki öğrenime ise besbelli diyecek yoktur. Bu öğrenime tekyanlılık gibi bir suçlama yöneltilmek istenirse önce böyle bir özelliğin suçlama konusu yapılmasına imkan verecek bakış açısını ele geçirmek gerekir. Çünkü her bilim tekyanlıdır gerçekte; sürdürdüğü çalışmaları belli muhtevalar, görüş açılan ve yöntemler sınırlandırdığı için, tekyanlı da kalacaktır ister istemez. Bir bilimi bir koz gibi bir diğeri karşısına çıkarma saçmalığına katılmak istemem hani. Sözgelisi fizik kimyayı değerden düşürmez, onun yerini alamaz, ama onun tarafından da yeri alınamaz. Elbet, psikanaliz ruhsal bilinçdışının bilimi olarak iyiden iyiye tekyanlıdır. Yani tekyanlılık hakkı tıp bilimlerinden esirgenemez. Aradığımız bakış açısını ise ancak bilimsel tıptan pratikteki tedavi bilimine yöneldiğimiz zaman bulgulayabiliriz. Hasta insan karmaşık bir yaratıktır, bu durumuyla pek güç kavranabilir ruhsal fenomenlerin de yaşam tablosundan silinip atılamayacağını bize hatırlatması gerekir. Hele bir nevroz karşılaşılmak istenmeyen bir vaka, bir nevrozlu ise hukuk ve askerlik şubelerini olduğu gibi tedavi bilimini de güç duruma sokan bir kişidir. Gelgelelim vardır nevrozlu ve tıbbi pek yakından ilgilendiren bir kimsedir. Ancak, tıp nevrozluğun ne incelemesi ne tedavisi bakımından hiç, ama hiç birşey yapmayarak duruma seyirci kalır. Bizim bedensel ve ruhsal diye ayırdığımız nesneler arasındaki içten ilişki karşısında bir öngörü eseri olarak günün birinde organların biyolojisinden ve kimyadan kalkılarak nevrozlar alanında

bilgi edinme ve inşallah bunları etkileme yollarının ele geçirileceğini söyleyebiliriz. Söz konusu amaç, henüz uzak görünmekte, bugün adı geçen hastalıkların yanına tıp yoluyla yaklaşamamaktadır.

Eğer tıp hekimlerden yalnız nevrozlar alanında kendilerine bir yönelti (oryantasyon) sağlamalarını esirgese yine katlanılabilirdi buna. Ancak o daha da ileri gitmekte, hekimleri nevrozlar karşısında yanlış ve zararlı bir tutumla donatmaktadır. Yaşamın ruhsal etkenlerine karşı içlerinde bir ilgi kıvılcımını tutuşturulamamış hekimlerse, bu etkenleri küçümsemeye ve bilim dışı görüp bunlarla alay etmeye eğilim göstermektedir. Dolayısıyla, bu etkenlerle ilişkili hiç bir şeyi doğru dürüst ciddiye almayıp, bu etkenlerin omuzlarına yüklediği yükümlüğü duymamakta, ruhsalbilimsel araştırmalara karşı işten anlamayan kimselerin saygısız tutumunu takınıp görevlerini kolaylaştırmaktadır. Değil mi ki nevrozlular da hastadır ve bir hekime başvurmaktadır, onları da tedaviye çalışmak ve bunun için yeni yollar denemek gerekir. Ama bu yolda uzun bir zaman isteyen hazırlık zahmetini ne diye üstlenmeli? Nasıl olsa böyle de yürüyor iş; hem psikanaliz enstitülerinde öğretilen bilgelerin kaç paralık değeri var, kimbilir. Ve psikanalizden ne kadar az anlarlarsa, o kadar atak davranır hekimler. Ancak gerçekten bilen kişidir ki, alçakgönüllüğe eğilim gösterir, çünkü bildiklerinin ne denli yetersiz olduğuna farkeder.

Psikanalize tıp alanına giren öbür dallar arasında sizin beni yatıştırmak için başvurduğunuz karşılaştırma diyeceğim isabetli değil. Cerrahide, gözde vb. lerinde fakülte, hekimin ilerde kendisini yetiştirmesi için gerekli olanağı sağlar. Psikanalitik öğrenim enstitülerinin sayıları azdır, fazla bir geçmişleri yoktur ve tıp tarafından tanınıp benimsenmeyen, tıbbın umursayıp aldırış etmediği bir bilim dalıdır psikanaliz. Hocalarının nesnel yargılar vermede pek işe yaramayan birçok sözlerine inanmış genç hekim, henüz değeri benimsenmiş bir otoritenin görülmediği bir alanda

pek tabii kendisi de bir yol eleřtirmen rolü oynayabilmek için eline geen fırsatlardan seve seve yararlanacaktır.

Böyle bir hekimin řarlatan psikanalist diye ortaya ıkıřını kolaylařtıran daha bařka durumlar da vardır. Söz konusu hekim diyelim yeteri kadar bir hazırlığı bulunmaksızın göz ameliyatlarına ve iridektomide uğrayacağı bařarısızlıklara, dolayısıyla hastalarını yitiriři ok gemeden onun bu atak davranıřlarına son verecektir. Oysa psikanaliz tedavisine yeltenmek bununla karřılařtırılırca hekim için daha az rizi-kolu bir durumdur; ünkü göz hastalıklarında hastalar ameliyatların saėladığı ortalama olumlu sonuçlarla řımartılmıştır, dolayısıyla cerrahıtan řıfa bekler. Ama bir "sinir hekimi" hastalarını řıfaya kavuřturamazsa, kimsenin buna řařmak aklına gelmez. Nevrozların tedavisinde basanlarla řımartılmış deėildir halk. Sinir hekimi hi deėilse "kendileriyle hayli meřgul olmuş", ne var ki elden birřey gelmemiř, anık iř doėa'nın yardımına ve zamana kalmıřtır. Söz geliři kadında ilkin adet görme, daha sonra izdiva, en sonunda âdetten kesilmeden beklenir bu yardım. Nihayet ölüm gelip atar ve gerekten hastaya yardım elini uzatır. Ayrıca hekim psikanalistin nevrozlu bir kimse üzerinde uyguladığı tedavide öyle dikkati eken bir taraf yoktur, dolayısıyla bir suçlama konusu yapılamaz. Öyle ya ne bir alte, ne bir ila kullanılmıřtır bu tedavide; sadece hastayla konuřulmuř, sözlerin aracılığıyla onu kafasındaki bir düşünceден kurtarmaya ya da bir düşüncenin kafasına yerleřtirilmesine alıřılmıřtır. Bu da nihayet zarar verecek bir řey deėildir hastaya, hele hekim tarafından onun için tatsız ve can sıkıcı konularla deėinilmekten kaınıldı mı. Psikanalizin sert kurallanna baėlı kalmıyan hekim psikanalist, psikanalitik tedavi yönteminde birtakım düzeltilmelere gitme, bu yöntemin zehirli gördüėü diřlerini söküp atma ve onu hasta için sempatik bir kılıėa sokmayı denemekten de kendini alamayacaktır. Sadece bunu denemekle kalsa gene

iyi; çünkü hastada karşıkoyumlar uyandırmayı göze alıp da bunlar önünde nasıl bir tutum takınacağını bilemedi mi, işte o zaman kaçınmak istediği tehlikeyle yüz yüze gelir, tam anlamıyla hastanın gözünden düşer.

Haksızlık etmeyerek, eğitilmemiş bir psikanalistin psikanalitik tedavi faaliyetinin hastaya beceriksiz bir cerrahın faaliyetinden daha az zararı dokunacağını teslim etmemiz gerekiyor, tşin ehli olmayanların psikanaliz tedavisinden hasta için doğabilecek bütün zarar, onun maddi ve manevi füzuli harcamalarda bulunmasına, iyileşme şansını ya büsbütün ya da kısmen yitirmesine yol açmaktan öteye geçmeyecektir. Bir başka sakınca da, psikanalitik tedavinin ününe bir gölgenin düşürülmesidir. Bütün bunlar tabii hiç istenilmeyen şeylerdir; ancak, acemi bir cerrahın neşterinde saklı tehlikelerle kıyaslanacak gibi değildir. Hastada uyandıracağı hoş gitmeyen tepkiler bir süre geçince yine kaybolur. Hastalığı doğuran yaşamsal travmalar yanında hekimin tedavisinde karşılaşacak biraz beceriksizliğin sözü edilmez pek. Nihayet gerektiği gibi yürütülemeyen tedavi hasta için olumlu bir sonuç doğurmadan kalır, hepsi o kadar.

"Psikanaliz uygulamasında şarlatan hekimlerle ilgili sözlerinizi dinledim, konuşmanızı kesmeden yaptım bunu; hekimlere karşı tarihten gelen nedenlerini bana kendinizin açıkladığı bir düşmanlık duygusu beslediğinize ilişkin bir izlenim uyandı üzerimde. Ama bir noktada size hak vermem gerekiyor: Eğer psikanalitik tedavi ille de gerekliyse, söz konusu tedavinin bu işi için adamakıllı yetişmiş kişiler tarafından sürdürülmesi yerinde olur. Peki siz, psikanalize yönelen hekimlerin kendilerini gerektiği gibi yetiştirmek için zamanla ellerinden geleni yapacaklarına inanmıyor musunuz?"

Korkarım, hayır. Üniversitedeki tıp öğreniminin psikanaliz öğretim enstitüsüne karşı tutumu değişmeden kaldığı

süre, hekimler psikanalizi basitleştirip kolaylaştırmak konusunda şüphesiz fazlasıyla büyük bir ayartı karşısında bulunacaklardır kendilerini.

"Ama amatör psikanalizi üzerinde dolaysız bir söz beklemekten titizlikle kaçınıyorsunuz bakıyorum. Bu durumda bana psikanaliz uygulamasına girişen hekimleri denetim imkanı bulunmadığı için, bir bakıma öç alma ve onları cezalandırma duygusuyla ellerinden psikanaliz tekeli almak ve bu hekimsel faaliyetini kapısını hekimlikten uzak amatörler de açmak gibi bir öneriyi ileri süreceğinizi tahmin yollu çıkarmaktan başka bir şey kalmıyor."

Benim bu konuda dayandığım nedenleri gerektiği gibi sezdimiz, kavradınız mı bilmem. Belki ilerde durumu daha tarafsız bir tutumla ele alıp size sunabilirim. Ancak özellikle üzerinde belirttiğim bir nokta varsa, **belli bir öğrenimle bu hakkı kazanmamış hiçkimsenin psikanaliz uygulamasına yanaşmaması gerektiğidir.** Söz konusu kimse hekimmiş ya da değilmiş, bu benim için ikinci derecede bir önem taşır.

"Peki kafanızda tasarladığınız öneriler nelerdir bu alanda, söyleyebilir misiniz?"

Henüz bu gibi önerilerde bulunacak duruma gelmedim, hani ilerde de gelip gelmeyeceğimi bilmiyorum. Sizinle başka bir sorunu ele almak, ama daha önce konuşmamıza giriş olarak belli bir noktaya da değinmek isterim. Haber verildiğine göre, yetkili resmi makamlar tabibler odasının ön ayak olmasıyla amatörlerin psikanaliz uygulamalarını düpedüz yasaklamayı planlıyormuş. Bu yasaktan psikanaliz deməğinin mükemmel öğrenim gören ve pratik çalışmalarda enikonu bir aşamayla yücelen, ama hekim payesini taşımayan üyeleri de etkilenecek. Böyle bir yasak çıkarılırsa, bu işi çok iyi becerebileceklerine güvenebilen hayli kişi psikanaliz uygulamasından alıkonulurken, benzer

bir güvenin söz konusu edilemeyeceğini kimseleri böyle bir faaliyette serbest bırakmak gibi bir durum ortaya çıkacaktır. Ama işte bununda başvuracak bir yasakla varılması amaçlanan bir sonuç olmaması gerekir. Oysa bu özel sorun ne pek önemlidir, ne de çözümlü bir çetinlik gösterir. Ortada çıkarılacak yasayla pek zarara uğramayacak bir avuç kişi söz konusudur. Kimbilir, belki bunlar, o zaman Almanya'ya göçecek, orada hiç bir yasak engelle karşılaşmaksızın pek kısa sürede psikanaliz alanındaki becerilerini herkese kabul ettirecek, takdirle karşılanacaklardır. Böyle bir yola başvurmaktan onları esirgemek ve yasal sertliği onlar hesabına yumuşatmak istediğiniz takdirde, belli emsallere dayanılarak kolaycacık gerçekleştirilebilir bu. Avusturya'nın mutlakîyetle yönetildiği dönemde, tanınmış şarlatan hekimlerin gerçekten işin üstesinden geleceklerine inandığı için belirli alanlarda hekimsel faaliyette bulunmalarına **ad personam*** müsaade edildiği kimseler çokluk taşrada hasta tedavi edenlerdi ve böyle bir müsaade için bir vakit sayılarından geçilmeyen o grandüklerden birinin tavsiyesi ve araya girmesi gerekiyordu. Nihayet aynı yola günümüzde kentten kimseler için de başvurulabilir ve bu konuda gerekli güvence grandüklerden değil, bilirkşi rolünü oynayabilecek daha başka kişilerden sağlanabilir. Söz konusu yasak çıkarılırsa, bunun Viyana Psikanaliz öğretim Entitüsüne etkisi, bu enstitünün bundan böyle psikanalist yetişmek isteyen tıp dışı çevrelerden adaylara kapılan kapaması olacaktır. Bu yola gidildi mi, başka ülkelerde serbestçe gelişebilen bir düşünsel faaliyet yurdu-muzda bir kez daha baskı altına alınacaktır. Hani yasa ve buyrultular konusunda en çok yargı veremeyecek bir kimse varsa o da benim. Ama şu kadannı sezmekteyim ki, bizim yasalarda şarlatan hekimler için öngörülen cezaların ağırlaştırılması, bugün besbelli bizim burada da

* isim zikredilecek (Ç.N.).

gerçekleştirmeye uğraşılan Almanya'daki bilimsel çalışmaların ruhuyla hiç bağdaşır bir şey değildir, sonra bu yasanın psikanalize uygulanmak istenmesi anakronik* bir durumdur; çünkü yasa çıkarıldığı zaman henüz psikanaliz diye bir şey yoktu ortada ve nevrotik hastalıkların kendilerinne özgü karakteri henüz bilinmemekteydi.

Şimdi üzerinde konuşulmasını benim daha önemli gördüğüm bir soruna geliyorum. Acaba psikanaliz uygulamasını resmi makamların müdahalesine açık tutmak yerinde midir? Acaba onu kendi doğal gelişimine bırakmak daha uygun olmaz mı? Elbet ben bu konuda bir yargı verecek değilim, ancak sorun üzerinde de düşünmenizi rica edeceğim sizden. Yurdumuzda öteden beri gerçek bir **furor prohibendi****, hepimizin bildiği gibi hiç de iyi yemişler vermemiş vasiliklere, müdahalelere ve yasaklamalara karşı bir eğilim sürdürür egemenliğini. Öyle görülüyor ki, yeni cumhuriyet Avusturyasında da durum pek değişmemiştir. Sanırım, bizi şimdi uğraştıran psikanaliz konusunda bir karara varılırken sizin de söyleyecek önemli bir sözünüz bulunacak. Bilmem, bürokratik eğilimlere karşı koymak isteğini duyacak mısınız içinde ya da bu konuda bir etkiniz olacak mı? Ama ben sorun üzerindeki tabii bir kıstas sayılamayacak düşüncelerimi herşeye rağmen açıklamadan duramayacağım. Bana kalırsa, buyrultu ve yasakların pek bolluğu yasaların otoritesi için zararlıdır. Ortada gözlemlenebilen bir gerçek varsa, az yasakların bulunduğu yerde bu yasaklara titizlikle uyulduğudur, ama nerede adım başına yasaklarla karşılaşırsa, orada insan düpedüz bu yasakları çiğnemek ayartısına kaptırır kendini. Öte yandan, yasa ve buyrultulara, çıkakları kaynak düşünülürse, bir kutsallık ve dokunulmazlık açısından bakılamayacağını, bun-

* İlgili döneme uygun düşmeyen (Ç.N.).

** Yasaklama çılgınlığı (Ç.N.)

lann çokluk muhtevalık yönünden yetersiz bir özellik taşıyacağını, adalet duygumuzu incitebileceğini ya da bir süre sonra böyle bir nitelik kazanabileceğini toplumu yönetenlerin hantal davranışlarından ötürü bu çeşit amaca elverişsiz yasaların düzeltimleri konusunda onları pervasızca çiğneyip geçmekten başka yapılacak bir şey kalmıyacağını savunmak için bir anarşist olmak gerekmez nihayet. Ayrıca yasa ve buyrultulara karşı vatandaşların saygılarını yitirmemesi isteniyorsa, kendilerine uyulup uyulmadıclanıyla da çiğnenip çiğnenmedikleri güç kontrol edilebilecek gibi yasa ve buyrultuların çıkarılmaması yerinde bir davranıştır. Bizim hekimler tarafından başvuru alan psikanaliz uygulamaları konusunda söylediklerimizden bazısını, ya-sayla önlemek istenen gerçek amatör analizi için de tekrarlayabiliriz. Psikanaliz tedavisinin seyri öyle gösterişli bir şey değildir, ne ilaçlara, ne aletlere yer verilir bu tedaviler, yalnız konuşulur, yalnız açıklamalar dinlenir, açıklamalar sunulur, o kadar. Bir amatör psikanalist bütün yaptığı işin telkinsel sözler söylemek, aydınlatmalarda bulunmak ve ruhsal bakımdan yardıma muhtaç kimseler üzerinde şifaya kavuşturucu insani bir etkilemeye başvurmak olduğunu ileri sürerse, onun ille de "psikanalitik tedaviyle" hasta iyi ettiğini tanıtlamak kolay değildir; çünkü sadece hekim de aynı şeyi yapıyor diye amatör psikanalistin bu yoldaki faaliyeti yasaklanamaz. İngilizce konuşan ülkelerde "Christian Science"* uygulamaları enikonu bir yaygınlık göstermektedir. Hristiyanlık, öğretilerine dayanarak yaşamsal tatsızlıkların diyalektik yoldan bir yadsınışıdır bu. Hani böyle bir davranışı, insan zekâsının esef verici bir yanlış yola sürüklenişinden başka gözle görmek gerektiğini ileri

* Sözcük anlamı: Hristiyanlık Bilimi; 1886'da İngiltere'de Boston kentinde Baker-Eddy Mary tarafından kurulmuş bir tarikat; Tanımın gerçek varlığının tanınmasıyla insanların hastalık ve günahlardan kurtulacağını öne sürer (Ç.N.).

sürecek değilim; ancak Amerika yada İngiltere'de böyle bir davranışı yasaklamak ve ceza kaydına bağlamak kimin aklına gelir? Acaba bizdeki yüce makamlar selâmete götüren yolu bu kadar kesinlikle mi biliyorlar ki, herkesin "kendi gönlünce" mutlu olmaya çalışmasını engellemeye yelteniyorlar? Diyelim, birçok kimseler kendi başlarına bırakılırsa birtakım tehlikelerde karşılanacak ve birtakım zararlar görecektir; bu durumda, baştakilerin, ayak atılmaması gereken bölgeleri titizlikle sınırlayıp, bunun dışında elden geldiği kadar insanoğullarını yaşantı ve etkileşim yoluyla kendi kendilerini eğitmeye bırakmaları daha yerinde bir davranış sayılmaz mı? Psikanaliz dünyada henüz o kadar yeni bir şey oluşturup, halkın çoğunluğu bu alanda henüz o kadar az bir oryantasyon sahibi bulunuyor ve resmi bilimlerin psikanalize karşı tutumları henüz o kadar kararsız bir durumu gösteriyor ki, daha şimdiden yasal tedbirlerle bu bilimin gelişimine müdahaleyi ben vaktinden önce atılmış bir adım sayıyorum. Ruhsal yardımı, bu yardım nasıl sağlayacaklarını bilemeyen kişilerden beklemenin zararlı bir davranış olacağını, bırakalım hastaların kendileri anlasın. Biz onları sadece bu konuda aydınlatalım, onları uyaralım, o zaman böyle bir yasaklamaya gitmek zorunluluğundan kurtuluruz. İtalya'nın yollarında elektrik iletim hatları üzerinde şu veciz etkili sözler okunur: Chi toca, muore*. Sarkan teller karşısında yolcuların davranışını düzenlemek için tamamen yeter bu da. Almanya'daki uyarmalar ise insanın duygularını inciten yersiz uzatmalarla doludur: Elektrik tellerine dokunmak can güvenliği bakımından tehlikeli olduğu için kesinlikle yasaklanmıştır. Ne gereği var şimdi bu yasak sözünün? Canını seven kendi önüne kendisi dikey söz konusu yasağı; bu yoldan canına kıymak isteyen kimse de her-halde gelip önce sizden izin istemez.

* Dokunmayın, ölüm tehlikesi (Ç.N.)

"Ama amatör psikanalizi sorunu için emsal gösterilecek daha önce konulmuş yasaklar var. Söz gelişi amatörlerin ipnotizma uygulamalarıyla gizbilimsel (okkultik) oturumlarda bulunmalarına ve bu yolda dernekler kurmalarına ilişkin yakınlarda çıkarılmış yasak."

Ben doğrusu bu tür tedbirlerin bir hayrankan olduğumu söyleyemeyeceğim. Son yasaklamanın düşünce özgürlüğüne darbe vuran bir polis vesayetinin yetki sınırını aşan bir müdahale niteliği taşıdığına hiç kuşku yok. Benim gizbilim olaylarına pek inanç beslediğim, hele bunların takdir ve kabulünü özlediğim gibi bir şüpheyi kapılmayınız hani; ancak şunu belirteyim ki, söz konusu yasaklamalarla insanların bu sözde gizli dünyaya karşı ilgi duymaları önlenemez. Hatta belki pek zararlı bir iş yapılarak, bu bunalıcı ihtimaller üzerinden atlayıp geçilir ve özgürlüğe kavuşturucu bir yargıya varılmasını sağlayacak tarafsız bilme tutkusunun yolu tıkanır. Ama bu da yine yalnız Avusturya'da görülen bir durumdur. Başka ülkelerde "parapsikolojik" araştırmaların karşısına bile hiç bir yasal engel çıkarılmaz. İpnotizmaya gelince, durum burada psikanalizdekinden biraz ayrıdır. İpnotizma normal dışı bir ruh durumunun denekte sağlanıp ortaya çıkarılmasıdır ve amatörler elinde bugün sadece bir gösterim aracı olarak kullanılmaktadır. Eğer başlangıçta pek umut bağlanan ipnotik tedavi zamana dayatabilseydi, o vakit psikanalizdekine benzer durumlar ortaya çıkabirdi. Kaldı ki ipnotizmanın tarihçesi, psikanalizin akıbeti bakımdan bir başka doğrultuda örneklik etmektedir. Ben henüz genç bir sinir patolojisi doçentiyken, hekimler heyecanla ipnotizmaya karşı çıkar, onu bir dolandırıcılık, şeytansal bir göz boyama ve son derece tehlikeli bir müdahale sayarlardı. Oysa bugün aynı ipnotizma uygulamaların kendi tekellerine almış, hiç çekinmeden bundan bir muayene yöntemi diye yararlanıyor ve bazı sinir hekimleri için ipnotizma izlenen tedavi yönteminin hâlâ temel aracını oluşturuyor.

Ama yasal düzenlemelerin mi, yoksa serbest faaliyetine izin verilmesinin mi psikanaliz uygulaması bakımından daha doğru bir davranış olacağına ilişkin önerilerde bulunmayı düşünmediğimi daha önce belirtmiştim. Bildiğim bir şey varsa, çözümünde kanıt ve tanıtlardan çok, kesin söz sahibi kişilerin belki de daha etkili rol oynayacağı köklü bir sorun bu. Bana bir *laissez faire** politikasının yerindeliğini gösteren noktalar daha önce özetlemiştim. Ama aktif bir müdahale politikasında karar kılınırsa, şüphesiz bu takdirde hekim olmayanların psikanaliz uygulamasına girişmeleri hiç bir şeye aldırmaksızın önlemeyi amaçlayan ölü doğmuş ve haksız bir tedbire başvurmakla yeterli bir iş yapılacağını sanmıyorum. Böyle bir yola gidildiğinde konu üzerine daha çok eğilme zorunluluğu belirecek, psikanalitik tedavi uygulamasına hangi koşullar altında izin verileceğini saptamak, psikanalizin içyüzü ve psikanaliz uygulamasının ne gibi hazırlıklara ihtiyaç gösterdiği konusunda bilgi alınacak bir otoriter merkezin kurulmasına ve psikanaliz öğretim olanaklarının zenginleştirilmesine çalışmak gerekecektir. Yani bu konuya ya ilişilmemeli ya da bir düzen ve açıklık getirecek gibi el atılmalı, yoksa mekanik bir yol izlenip eskimiş bir buyrultudan çıkarılacak ve bir tek yasayla işe müdahaleden sakınılmalıdır.

VII

"Ah, siz hekimler, siz hekimler! Konuşmamızın asıl temasına bir türlü girmenizi sağlayamıyorum. Hâlâ benim karşımda kaçamak davranıyorsunuz. Soru şu: Tatalım ki belirli koşullar yerine getirildi, psikanaliz uygulamasının tekeline hekimlere bırakmalı mı, bırakmamalı mı? Nihayet hekimler elbette çoğunluk bakımından sizin anlattığınız o şarlatan kimseler değildir. Öğrenci ve taraftarlarınızdan

• Bırak kendi haline (Ç.N.)

büyük kısmının hekim olduğunu siz kendiniz söylediniz. Kulağıma geldiğine göre, bu hekimler sizin amatör psikanalizi konusundaki düşüncenizi asla paylaşmıyormuş. Öğrencilerinizin, psikanaliz uygulamasına girişmeden hekimlerin yeteri kadar hazırlanmaları vb. gibi koşullara ilişkin düşüncenizi benimsiyeceklerini tabii tahmin ederim; ancak bu öğrenciler, psikanaliz uygulamasından amatörleri uzak tutmayı bu düşünceyle bağdaşmaz bir davranış saymayacaklardır. Böyle mi durum acaba ve eğer böyleyse, bunu nasıl açıklarsınız."

Bakıyorum, bu konuda gerektiği gibi bilgi edinmişsiniz; evet, böyledir durum. Hepsi değilse bile hekim meslektaşlarımdan büyük bir kısmı bu konuda benim tarafımı tutmuyor, nevrozluların psikanalitik yoldan tedavi hakkının yalnız hekimlere verilmesini istiyor. Nihayet bizim saflarda da görüş ayrılıklarının doğabileceğini buradan anlamaktasınız. Benim tutumum ortada; ancak, amatör analizi konusunda karşıt görüşleri savunmamız arkadaşlar arasındaki uzlaşma havasını ortadan kaldırmıyor. Öğrencilerimin bu davranışını size nasıl açıklayasam bilmem?

Kesinlikle söyleyemeyeceğim nedenini; ama öyle sanıyorum ki bir sınıf bilincinin gücünden ileri gelen bir şey bu. Onlar benden daha değişik bir gelişim yolunu geride bıraktı. Hekim meslektaşlarından tecrit edilmiş durumda kendilerini rahatsız hissediyor, tam hak sahibi kişiler olarak meslek'e kabul edilmek istiyorlar pek ve bu hoşgörü için hayati önemini bir türlü kavrayamadıkları bir noktada bir fedakârlığa üstlenmeye rıza gösteriyorlar. Belki de durum başka türdü; rekabet nedenleriyle davrandıklarını ileri sürmek, sadece onları bayağı bir zihniyetle damgalama anlamı taşımayacak, aynı zamanda tuhaf bir kısıgörüslülükle suçlamak olacaktır. Çünkü onlar başka hekimleri de psikanaliz çalışmaları içerisine almaya hazırdır, ellerindeki hastaları ister meslektaşlarıyla, ister amatör psikanalistlerle pay-

laşmak maddi durumları için pek farketmeyecektir. Ama belki bir başka neden de burada rol oynamaktadır. Bu öğrencilerim, psikanaliz uygulamalarında, hekime amatör psikanalistlerde rastlanmadık kesin bir üstünlüğü garantiler görünen bazı faktörlerin etkisi altında kalmış olabilirler.

"Üstünlük garantilemek mi? Anlaşıldı nihayet. Demek en sonunda böyle bir üstünlüğün varlığını itiraf ediyorsunuz? O zaman sorun kesin bir karara bağlamış demektir."

Böyle bir itirafta bulunmak zor değil benim için. Bu size, öyle sandığınız gibi gözlerimin gerçeği seçemeyecek kadar tutkunluktan kamaşmadığını gösterir. Bu durumlara değinmeyi daha sonradan bıraktımsa, ele alınmaları yine kurumsal konuşmaları gerektireceği içindi.

"Bu sözlerinizle ne demek istediğinizi anlayamadım."

İlkin bir teşhis sorunu var ortada. Nevrotik bozukluklardan rahatsız hasta psikanalitik tedaviden geçirilmek istenirse, hastanın böyle bir tedavi yöntemine elverişli olup olmadığı, yani kendisine bu yoldan yardım edilip edilemeyeceği konusunda elden geldiğince bir kesinlik sağlanmaya çalışılır. Ancak, böyle bir durum, hastanın gerçekten bir nevroza tutulmasında söz konusudur.

"Sanırım bu, hastanın yakındığı belirtilerden, arazlardan anlaşılacaktır."

İşte size yeni bir güçlük. Buna her vakit tam bir kesinlikle bilemeyiz. Hasta bir nevrozun dış tablosunu göstermesine rağmen, bakarsınız rahatsızlığı ayrıdır; onmaz bir akıl hastalığının başlangıç evresinde bulunmakta ya da beynindeki tahrip edici bir hastalık sürecinin hazırlık evresini yaşamaktadır. Ayırım - ayıncı teşhis her vakit kolay değildir ve rahatsızlığın her evresinde hemen konulamaz. Böyle bir teşhisin sorumluluğunu tabii yalnız hekim yüklenebilir. Daha önce söylediğimiz gibi, böyle bir teşhise

de her vakit kolay varamaz hekim. Sonunda habis karakteri kendini açığa vuruncaya kadar hastalık uzun süre zararsız bir görünüm taşıyabilir. Nihayet bir akıl hastalığında soluğu alıp almayacakları nevrozluların sürekli endişe konusudur. Ama hekimin böyle bir vakayı epey bir süre teşhis edememesi ya da bu konuda bir açıklığa kavuşamaması pek o kadar büyük bir önem taşımaz; çünkü bunun sonucu bir zarar ortaya çıkmış, fuzulî bir iş yapılmış değildir. Gerçi hastanın psikanalitik tedavisi de hastaya bir zarar vermez, ancak bunun boşuna harcanmış bir çaba olduğu anlaşılacak, üstelik bazı kişiler uğranılan başarısızlıktan psikanalizi sorumlu tutacaktır. Gerçi haksızlık edeceklerdir böyle davranmakla, ama herşeye rağmen bu gibi vesilelere yol açmaktan sakınmak doğru bir yoldur.

"Ama hazin bir hava esiyor bu sözlerinizde; bir nevrozun karakter ve doğuşuna ilişkin bana şimdiye dek bütün söylediklerinizi yine kökünden söküp atıyor."

Hiç de değil. Yalnız nevrozların, gerek nevrozlular, gerek psikanalisüer için işin içinden çıkılması güç ve tatsız durumlar olduğu görüşünü tekrar pekiştiriyor. Yeni açıklamaları daha derli toplu bir kılığa sokup sunmam, belki biraz giderir şaşkınlığınızı. Şimdi üzerine eğildiğimiz vakalarla ilgili olarak, bu vakalarda gerçekten bir nevrozun geliştiğini, ama bunun ruhsal değil, somatik bir karakter taşıdığını, ruhsal değil, somatik nedenlere dayandığını söylemek belki daha yerinde bir davranıştır. Bilmem anlatabiliyor muyum?

"Anlamaya anlıyorum ama, bunları ruhbilimsel gerçeklerle bağdaştıramıyorum doğrusu."

Başdaşunrsınız, bağdaştırırsınız; yeter ki, canlı nesnenin insanın karşısına çıkarabileceği güçlükleri göz önünde tutasınız. Bir nevrozun özünü nasıl saptamıştık? Ben'in, dış dünya etkisiyle gelişip ortaya çıkan ruhsal aygıttaki bu yüce mekanizmanın Es'le realite arasında aracılık işlevini yerine getirecek gücü, gösteremeyişi, bu güçsüzlükten ötürü Es'in

yönelttiği içgüdüsel isteklere kapılarını kapayışı, ama bunun karşılığını birtakım sınırlamalar, arazlar ve başarısız tepkisel ürünleri sineye çekerek ödemesi diye, öyle değil mi.

Hemen hepimizin çocukluğunda Ben her vakit böyle bir güçsüzlük durumunu yaşar; bu yüzden, ilk çocukluk yıllarında geçen olayların ilerisi için önemi pek büyüktür. Bu çocukluk yıllarının olağanüstü yükü altında çünkü birkaç yıl içinde taş devriyle günümüz uygarlığı arasındaki o muazzam gelişimsel uzaklığı geride bırakmamız, bu arada özellikle cinsel erken dönemin içgüdüsel isteklerine karşı kendimizi savunmamız gerekmektedir Ben'imiz geriye kimlere kaçıp sığınır ve bir çocuksal nevrozlu karşı karşıya bırakır kendini, bunun çökeltisini de ilerde başgösterecek nevrotik hastalanmalara bir yatkınlık olarak erginlik yıllarından içeri taşıyıp götürür. Bu durumda herşey, bu yetişip gelişen yaratığın alınyazısı tarafından belirlenir. Birey çetin bir yaşamla yüz yüze gelir de içgüdüsel isteklerle realitinin diretişleri arasındaki uçurum fazla büyük düşerse, Ben bu her ikisini birbiriyle uzlaştırma çabalarında başarısızlığa uğrayabilir; doğuştan o çocuksal yatkınlığın engellenmesi ne denli güçlüyse, bu başarısızlık o denli büyüktür. Bu durumda geriye itim olayı tekrarlanır, içgüdüler ben'in egemenliğinden kendilerini koparıp alarak geriye dönüş yoluna sapar ve kendilerine yerdeş ürünler sağlar, bunun sonucu olarak da zavallı Ben çaresizlik içinde nevroza sürüklenir, şimdi şu noktayı saptayalım: Bütün durumun düğüm noktası ve ekseni bensel örgütün nisbeten güçlülüğüdür. Bu durumda etiyolojik toplu bakışımı kolaylıkla bütünleyebiliriz. Çocuksal Ben'deki güçsüzlüğün, erken dönemdeki cinsel isteklerle başa çıkamayışın ve daha çok tesadüfi çocukluk yaşantılarının nevrozlara yol açabileceğini gördük. Ancak nevrozların doğuşunda çocukluk yaşamından öncelerine ilişkin kimi nedenler de rol oynayamaz mı acaba? Söz gelişi doğuştan bireydeki bir güçsüzlüğün ve Ben'in karşısına daha işin başından beri al-

abildiğine çetin ödevler çıkaran Es'teki içgüdüsel yaşamın dizginlenmez aşırılığının da bundan payı yok mudur? Veya bensel gelişimde bilinmedik etkenlerin ortaya çıkardığı özel bir güçsüzlük böyle bir neden oluşturamaz mı? Pek tabii bu etkenler etiyolojik bir önem taşıyabilir ve kimi vakalarda bu önem alabildiğine büyüktür. Es'teki içtepilerin gücünü her vakit düşünmemiz gerekir. Bu içtepiler aşın güçlenmiş bir durumdaysa, tedaviden pek başarılı sonuçlar elde edebilme umudu yoktur. Ben'in gelişimdeki bir engellemeyi doğurabilen nedenler konusunda henüz pek az bilgimiz vardır. Demek oluyor ki, bunlar başlıca bünyesel bir temel üzerinde gelişmiş nevroz vakalardır. Böyle doğuştan elverişli bir zemin bulunmaksızın galiba bir nevroz pek ortaya çıkmamaktadır.

Ama Ben'in nisbeten güçsüzlüğü bir nevrozun doğuşu için kesin faktör niteliği taşıyorsa, ilerde bireyin geçireceği organik bir rahatsızlığın da, Ben'de bir güçsüzlenmeye yol açtığı takdirde, bir nevrozu doğurabilmesi gerekmektedir. Ve bu da geniş ölçüde rastlanan bir durumdur. Böylesine bedensel bir bozukluk Es'teki içgüdüsel yaşamı etkileyebilir ve içgüdülere Ben'in başedebileceği sınırın ötesinde bir güç kazandırabilir. Sözgelisi kadındaki âdet görme bozukluklarıyla âdetten kesilmenin yol açtığı değişikliklere, bu tür olaylar için normal bir model olarak bakılabilir. Ya da organizmadaki genel bir hastalanma, hattâ merkezi sinir sistemindeki organik bir rahatsızlık ruhsal aygıtın beslenme koşulları üzerine çullanarak, onu fonksiyonunu sınırlandırmaya ve bensel örgütün ayakta tutulmasıyla görülen daha yüce işleri tatile zorlar. Bütün bu durumlarda aşağı yukarı aynı nevroz tablosuyla karşılaşır, nevrozlarda ise her vakit aynı psikolojik mekanizmaya, ama çokluk pek bileşik karakter taşıyan alabildiğine çeşitli bir etiyolojiye rastlarız.

"Şimdi bakın, hoşlanmaya başladım sizden. Hele şükür bir hekim gibi konuştunuz. Eh bu durumda, nevroz gibi o

kadar aprařık hekimsel bir konunun da ancak bir hekim tarafından ele alınabileceđini itiraf edersiniz sanırım."

Korkarım, bu szlerinizle konu dıřına ıkıyorsunuz. Bizim zerinde durduđumuz, patolojiyi ilgilendiren biraz bir řeylerdi; oysa psikanalizde tedavsel bir yntem sz konusudur. Hekimin psikanaliz iin her vakada ilkin bir teřhis koymasının geređini teslim ediyor, daha dođrusu istiyorum bunu. Biz psikanalistlerin zerine eđildiđi nevrozlardan pek ođu Allaha řkr psikojen bir karakter tařıyıp, patolojik bir kuřku uyandırmayan vakalardır. Hekim bunu bir kez saptadı mı, hastanın tedavisini rahatlıkla bir amatr psikanaliste bırakabilir. Psikanaliz derneklerimizde hep byle yapılagelmiř, Hekim ve hekim olmayan yeler arasındaki sıkı iliřki sayesinde, tehlikeli birtakım yanılđılara dřlmekten hemen btnyle sakınılmıřtır. Ancak amatr psikanalistin hekimi yardıma ađırması gereken bir ikinci durum daha vardır: Psikanalitik tedavi srecinde bazan en ok bedensel olmak zere yle arazlar ortaya ıkabilir ki, bunları bir nevroz erevesi ierisen almak ya da bunlara nevrozdan bađımsız bir bozukluk kılıđında kendini aıđa vuran organik bir hastalık gzyle bakmak konusunda tereddtler dođabilir. Bu konudaki kesin yargıya da yine hekime bırakmak gerekmektedir.

"Anlařıldıđına gre, amatr psikanalist, psikanalitik tedaviyi yrtrken de hekimsiz yapamamaktadır. Bu da onun iře yararlıđı aleyhinde yeni tanıttan bařka bir řey deđil."

Hayır, byle bir durumdan amatr psikanalist aleyhinde bir tanıt ıkarılamaz^; nk tedaviyi hekim de yrtse, aynı durumda bařka trl davranmazdı.

"Burasını anlamadım."

Yani teknik bir kural geređi, psikanalist, psikanalitik tedavi srecinde bu eřit iki anlama gelen arazlarla karřılařtı mı, kendisi bir yargı vererek iři kestirip atmaz, psikanalizin uzađındaki bir hekime, diyelim bir dahiliyeciye bařvurur,

kendisi hekim olsa ve tıb bilgilerine hâlâ güvenini sürdürse bile yine ondan bir rapor almaya bakar.

"iyi ama bana fuzuli görünen bir davranış bu, ne diye kural diye konmuş bilmem?"

Fuzuli değildir, hattâ böyle bir davranışın birçok nedenleri vardır. Birincisi: Organik ve ruhsal tedavi tek elden istenildiği gibi yürütülemez, ikincisi: Psikanalitik tedavi sürecinde başgösterecek aktanmsal ilişkiden ötürü hastayı fizik bakımdan muayene etmeyi hekim uygun bulmayabilir. Üçüncüsü: Psikanalist, ilgisini alabildiğine bir yoğunlukla ruhsal faktörler üzerine yönettiği için, kendi tarafsızlığından kuşkulananmakta yerden göğe haklıdır.

"Amatör psikanalize karşı tutumunuz şimdi bir açıklık kazandı benim için: Amatör psikanalistlerin olması gerektiği üzerinde diretiyorsunuz; ancak, bunların üslenecekleri ödevi yerine getirmekteki yetersizliklerini de yadsıymayacağınız için, varoluşlarını bağışlatmaya ve kolaylaştırmaya yarayacak nice söz varsa bulup söylüyorsunuz. Oysa ben, ikinci sınıf terapist rolü oynayacak amatör psikanalistlerin ne gereği var, bir türlü anlamıyorum. Haydi psikanalist yetiştirilmiş birkaç amatör psikanalisti bırakalım; ama hiç değilse yenileri yetiştirilmemeli, öğretim enstitüleri hekimliğe uzak kişileri psikanalist yetiştirmek için kabul etmemeye kendilerini yükümlü kılmalıdır."

Böyle bir sınırlamayla bütün tarafların çıkarlarının gözetileceği anlaşılrsa, ben de sizinle beraberim. Adı geçen çıkarların da hastanın çıkan, hekimlerin çıkan ve last not least bütün gelecekteki hastaların çıkarlarını içeren bilimsel çıkar olmak üzere üçe ayrıldığını teslim edersiniz herhalde. İsterseniz, buyrun bu üç çıkan sizinle ayrı ayrı ele alıp inceleyelim.

Pisikanalist hekimmiş, ya da değilmiş, hasta için farketmez nihayet; yeter ki, tedaviye başlamadan ya da tedavi yürütülürken ortaya çıkacak kimi olaylarda bir hekim raporuna başvurulsun ve durumun yanlış teşhis tehlikesi

önlensin. Hasta için eşsiz önemde bir şey varsa, psikanalistin güven duygusu verecek kişisel özellikler taşıması ve yüklendiği ödevi yerine getirebilecek gibi bilgi, görüş ve tecrübelerle donanmasıdır. Sanılabilir ki, hasta kendisini tedavi edenin hekim olmadığını ve onun bazı durumlarda bir hekimin yardımına başvurmaksızın yapamayacağını bilirse, psikanalistin otoritesine gölge düşürür bu. Pek tabii hastalarımıza, kendileri tedavi eden psikanalistin durumu konusunda bilgi vermekten asla kaçınmış değiliz ve bu arada edindiğimiz bir kanıya göre, sınıfsal önyargılar hastalarda hiç bir yankı uyandırmamaktadır ve hastalar hangi taraftan gelirse gelsin kendilerine sunulan şifayı kabule hazırdır. Hekimler de bunu çoktan öğrenmiş, dolayısıyla enikonu bir kırılıp incinme duygusuna kapılmıştır. Hem bugün psikanaliz uygulamasında bulunan amatör psikanalistler sağdan soldan koşup bir araya gelmiş rasgele kişiler değil, akademik bir formasyon sahibi kimseler, felsefe doktorları, pedagoglar, büyük bir yaşam tecrübesi ve üstün bir kişiliği bulunan bazı hanımlardır. Bir psikanaliz öğretim enstitüsünün bütün adaylarının kendilerini psikanalizden geçirme zorluğu bunların o çetin psikanalitik tedavi uygulamasına elverişliliği konusunda ilgilileri aydınlatıcı en iyi yoldur aynı zamanda.

Şimdi de hekimlerin çıkarına gelelim. Bu çıkarın, psikanalizi tıp kapsamına almak ve tıbbı maletmekle gözetileceğini sanmıyorum. Tıp öğrenimi şu anda beş yıl sürüp, son sınavların verilmesi altıncı yılın bir hayli içerlerine kadar uzanıyor. Her birkaç yılda bir öğrencilere yeni yeni yükümlülükler yükleniyor, yerine getirilmemesi öğrencinin gelecek için hazırlığına yetersiz gözle bakılmasını zorunlu kılan istekler yöneltiliyor. Hekimlik mesleğini elde etmek pek çetin bir iştir; uygulaması ise ne pek doyurucu, ne pek avantajlıdır. Haklılığı su götürmeyen bir kanıyla, hekimin hastalığın ruhsal yönüne de aşına olması gerektiği benimsenir ve tıp öğrenimi biraz da psikanal-

liz öğrenimiyle genişletilirse, bu, öğrencilerin öğrenicekleri bilgilerde bir artış, dolayısıyla öğrenim yıllarında bir uzama anlamı taşıyacaktır. Bilmem psikanaliz üzerinde hak iddia etmenin ortaya çıkaracağı böyle bir sonuç hekimleri memnun bırakacak mı? Ancak bu sonuç pek kaçınılacak gibi değildir. Öte yandan, böyle bir sonucun, hekimlerin geldiği toplumsal sınıfların maddi koşullarının genç kuşağı elden geldiği kadar kısa sürede geçimlerini sağlamak zorunda bırakacak denli kötüleştiği bir dönemde çırarılacağını düşünün!

Ama belki siz tıp öğreniminin yükünü psikanalitik uygulama hazırlıklanıyla çoğaltmayı ve geleceğin psikanalistlerinin ancak tıp öğrenimlerini bitirdikten sonra zorunlu psikanaliz öğreniminden geçmelerini daha yerinde bir davranış sayacaksınız. Bunun yol açacağı zaman kaybının pratikte önem taşımayacağını, çünkü otuz yaşın altındaki genç bir adama asla hastaların güven duygusu beslemeyeceğini, oysa hastalara ruhsal yardımda bulunabilmesinin bu güven koşuluna dayandığını söyleyebilirsiniz. Gerçi buna, toy bir hekimin organik rahatsızlıklar konusunda da hastalarından pek fazla bir güven duygusu bekleyemeyeceği ve genç bir psikanalistin bir psikanaliz polikliniğinde tecrübeli pratisyen psikanalistlerin denetimi altında çalışarak vaktini pekala değerlendirebileceği cevabı verilebilir.

Ancak bana daha önemli görünen bir şey varsa, önerinizde bu zor dönemlerde gerçekten ekonomik hiç bir tutar yanı bulunmayan bir güç israfını salık vermiş oluyorsunuz. Gerçi psikanalitik öğrenim hekimsel hazırlık çemberiyle bir noktada kesişir, ama ne bu çemberi kapsamına alır, ne de onnu kapsamına girer. Diyelim bugün için hayalî görünebilecek bir iş gerçekleştirilip bir psikanaliz yüksek okulu kurulsa, bu okulda tıp fakültelerinin programlarındaki birçok derslerin öğreniminin yapılması gerekirdi: Her vakit için öğrenim çekirdeğini oluşturacak, elden geldiği kadar geniş çapta cinsel yaşam bilgisi verile-

cek, psikiyatri kapsamındaki hastalık tablolarıyla bir tanışıklık sağlanacaktır. Öte yandan, psikanalitik öğretim, uygarlık tarihi, mitoloji, din psikolojisi ve edebiyat bilimi gibi hekimin uzağında bulunup, onun hekimlik faaliyetinde karşı karşıya gelmediği dallan da içerecektir. Yukarıda adı gever alanlarda gerektiği gibi bir yönelti (oryantasyon) sağlayamayan bir psikanalist, eli altındaki malzemenin büyük bir bölümünü anlamaktan yoksun kalacaktır. Kendi amaçları uğrunda tıp fakültesinde öğrendiklerinin büyük parçasından yararlanamayacaktır bir türlü. Gerek ayak kemiklerini (Tarsus), gerek hidrokarbonun yapısını, ayrıca beyin sinir liflerinin izlediği yolları tanımak, tıbbın hastalandırın naziller ve bunlara savaşılması, serom çıkardığı gerçekleri, hepsi doğrusu takdire değer bütün bu bilgileri öğrenmek bir psikanalist için hiç önem taşımayacak, onu hiç bir şekilde ilgilendirmeyecek, ne bir nevrozu dolaysız anlayarak şifaya kavuşturmasına yardım edecek, ne de çalışmalarında en çok gereksindiği düşünsel yeteneklerinin güçlünmesine bir katkıda bulunacaktır. Hekim tıbbın bir başka dalına, sözgelişi dış tedavisine yönelse de yine benzer bir durumun söz konusu olacağı gibi bir itirazda bulunmayınız! Çünkü o zaman hekim sınavdan geçtiği birçok derslere ilişkin bilgileri kullanamayacak, beri yandan okluda öğretilmeyen birçok bilgileri daha önceki bildiklerine ek olarak öğrenmek zorunda kalacak tır. Her iki durum arasında bir özdeşlik kurulamaz sanıyorum. Nihayet dış tedavi biliminde de sayn bilimin (patoloji) büyük görüş açılan, iltihaplanmaya, cerahatlenmeye, nekroza ve vücuttaki organların etkileşimine ilişkin öğretiler önemini korur; oysa edindiği tecrübeler psikanalisti başka olguların yer alıp, başka yasaların egemenliğini sürdürdüğü bir başka dünyaya çekip götürür. Felsefe Bedensel ile Ruhsal arasındaki uçurumu ne kadar kapamaya çalışırsa çalışsın, bizim tecrübelerimiz hee pratiğe yönelik çabalarının için böyle bir uçurum varlığını sürdürmektedir.

Diyeelim bir fobili ya da saplantı nevrozluyu ıstırabından kurtarmaya uğraşan kimseyi tıp öğrenimi üzerinden geçen dolambaçlı bir eğitime zorlamak haksız ve yersiz bir davranıştır. Psikanilizi büsbütün baskılamanın üstesinden gelinemedi mi, bir basan da sağlayamayacaktır bu. Bir ülke canlandırın hayalinizde; öyle bir ülke ki, belli bir yerinde karşınıza iki yol çıkıyor, yollardan biri kısa ve düz, ötekisi uzun dönemeçli ve dolambaçlıdır. Kısa yolun başına bir yasak levhası koyuyorsunuz ve o yola sapılmasını önleyorsunuz; hani belki birkaç çiçek tarhının önünden geçiyor da yol, siz tarhlara bir şey olsun istemiyorsunuz, onun için. Bu durumda koyduğunuz yasağın yararını ve çiçek tarhlarınızın başına gelecekleri kolaycacık kestirebilirsiniz. Ben nasıl hekimleri bir psikanaliz öğrenimine razı etmenin üstesinden gelemeyeceksem, siz de amatörleri zorlayıp onlara tıp öğrenimi yaptıramayacaksınız korkarım. Nihayet insan nasıl bir yaratıktır, biliyorsunuz.

"Psikanaliz tedavisinde özel bir eğitim görmeden girişilemeyeceğinde, tıp öğretiminin ise psikanalize hazırlama gibi bir ek yükü çekecek gibi olmadığında bir psikanalist için tıp bilgileriniden çoğunun fuzulî bir nitelik taşıdığında haklıysanız, peki o zaman mesleğinin omuzlarına yüklediği bütün ödevlerin altından kalkabilecek kişilikteki hekim yetiştirme ülküsünü ne yapacağız?"

Bu gibi güçlüklerden bizi kurtaracak ne gibi bir çıkış yolunun bulunduğunu önceden söyleyecek durumda değilim; ayrıca, böyle bir çıkış yolunun bulgulamak da benim işim değil. Benim gördüğüm yalnız iki şey var. Birincisi: Psikanalizin sizin için en iyisi varolmaması gereken çetin bir ceviz niteliği taşıdığı elbet nevrozlu da yine sizin için çetin bir ceviz oluşturmakta ikincisi ise, hekimlerin alabildiğine sık görülen psikojen (ruhsal kökenli) nevrozların zahmetli tedavisini üzerlerinden alacak ve bu hastaların yararına onlarla sürekli bağlantı içerisinde kalacak bir kısım psikoterapistin

varlığını hoşgörüyle karşılamasının şimdilik bütün tarafların çıkarlarına uygun düşeceğidir.

"Sorun üzerinde söyleyeceğiniz son söz mü bu, yoksa daha başka diyecekleriniz var mı?"

Var tabii nihayet bir üçüncü çıkan, bilimsel çıkan da söz konusu etmek istiyordum biliyorsunuz. Bu konuda söyleyeceklerim sizi pek ilgilendirmeyecek gerçi ama benim için o derece önemli. Psikanalizin tıp tarafından yutulup, en son soluğu psikiyatrinin ders kitaplarında, tedavi bölümünde ve bilgisizliğimizin yaratılan olup kısa ömürlü etkilerini insan kitlelerinin hantallığına ve korkaklığına borçlu ipnotik telkin, öztelkin, persuasyon gibi yöntemlerin yanı başında yer almasını hiç özlenir bir durum görmemekteyiz. Psikanaliz daha iyi bir sona lâyık bulunuyor ve inşallah bu sona da kavuşacaktır. "Derinlik psikolojisi" ve ruhsal bilinçsiz'in öğretici olarak psikanaliz, insan uygarlığını konun edinen ve onun sanat, din ve toplum düzeni gibi, kurumlanılın doğuş tarihiyle uğraşan bütün bilimlerin başvurmadan yapamayacağı bir aşamaya erişecektir.

Öyle sanıyorum ki zaten şimdiye kadar bu bilimlere ilişkin sorunların çözümünde psikanaliz yabana atılmayacak önemli katkılarda bulunmuştur. Ancak uygarlık tarihçiler din psikoloğları, dilbilimciler vb. kendi buyruklarına vakit ele geçirilecek basanlar yanında bunlar, küçük çapta katkılar gibi kalacaktır. Nevrozların tedavisinde kullanılması psikanalizin uygulama alanlarından yalnızca biridir, belki gelecek bunun en önemli bir alan olmadığı gösterecektir. Hani sırf hekimsel çıkarlar çemberiyle kesiştiği için bu uygulama alanına bütün diğer uygulama olanaklarını feda etmenin yerinde bir davranış sayılamayacağı muhakkak bir kez. Çünkü burada bir zarara yol açmaksızın müdahale edilemeyecek geniş bir ilişkiler örgüsü kendini açığa vurmak-

tadır. Yöntem ve bakış açılarını kendi konulan üzerinde uygulamak için çeşitli manevi bilim temsilcilerinin psikanalizi öğrenmeleri gerekiyorsa, psikanaliz literatürüne geçen sonuçlara tutunmaları elvermez bunun için. Onların bunun üstesinden gelebilmesini sağlayacak bir tek yol vardır: Biz-zat kendilerini bir psikanalizden geçirmek. Böylece psikanalize gereksinme duyan nevrozluların yanında psikanalize düşünsel nedenlerden başvuran, ama bunun kendilerine sağlayacağı basan ve yeteneklerindeki güçlenmeyi elbette memnunlukla karşılayan bir grup kimse daha çıkmaktadır karşımıza. Bu analizlerin yapılabilmesi de kendileri için tıp bilgilerinin hiç de pek büyük bir önem taşımayacağı bir miktar psikanalistin varlığını zorunlu kılmakur.

Ancak bunlar isterseniz öğrenci psikanalistler diyelim kendilerine gayet titiz bir öğrenim göreceklidir. Kırık dökük bir öğrenimle yetinmek zorunda bırakılmaları istenmiyorsa, kendilerine öğretici ve tanıdayıcı vakalar üzerinde tecrübeler edinme fırsatını vermek gerekir, bilme tutkusu gibi bir dürtüyü içlerinde duymayan sağlıklı kimseler kendilerini psikanalizden geçilmeyecekleri için, bu öğrenci psikanalistlerini hekimsel olmayan ilerki faaliyetleri için yetiştirmede yine sadece nevrozlular üzerinde titiz bir kontrol altında sürdürecekleri çalışmalarla gerektiği gibi eğitilecektir. Ama bütün bu iş belli bir ölçüde hareket özgürlüğünü gerektirir ve cimrice sınırlamaları kaldırmaz pek.

Belki psikanalizin bu salt kurumsal çıkarlarına inanmıyor ya da bunların o pratik amatör psikanalizi sorunu üzerinde bir etkisi olabileceğini teslim etmek istemiyorsunuzdur. O zaman size şunu haurlatmak isterim ki, psikanalizin şarlatan hekimlikten uzak olup, hekimlerin pek hak ileri süremeyecekleri bir başka uygulama alanı daha bulunmaktadır, bu da eğitbilimdir. Bir çocuk hoş gitmeyen bir gelişimin belirtilerini açığa vurmaya başlar da neşesiz, inatçı

dalgın bir durum alınır, çocuk doktoru, hattâ okul doktoru bu belirtileri yoketmek için hiç bir şey yaşamayacak, çocuk ürkeklik, iştahsızlık, kusma ve iyi uyumama gibi apaçık sinirsel arazlar gösterse bile, bunları tedavi için yine ellerinden bir şey gelmeyecektir. Oysa psikanalitik etkilemeyi eğitbilimsel tedbirlerle birleştiren bir tedavi, çocuğun yaşadığı çevre koşullarıyla ilgilenmeyi küçümsemeyen ve çocuğun ruhsal yaşamından içeri bir kapı açıp girebilen kişilerce sürdürüldü mü, bir çırpıda hem sinirsel arazlar ortadan kaldırılacak, hem başlangıç evresindeki karakter değişikliği geriletip yok edilecektir. İlerki yaşamda kendini açığa vuracak ağır hastalanmalara karşı bir yatkınlık olarak çokluk hafifçocuksal nevrozların önemini kavramamız, koruyucu tedbir bakımından çocuk psikanalizlerinin mükemmel bir yol olduğunu bize göstermektedir. Henüz psikanalizin düşmanları bulunduğu yadsınamaz; bunların eğitbilimsel psikanalistlerin ya da psikanalitik eğitbilimcilerin çalışmalarını ellerindeki ne gibi çarelere başvurarak köstekleyebileceklerini doğrusu bilmiyorum; ayrıca, bunun öyle kolaycacık üstesinden gelebileceklerini de sanmıyorum. Ama doğru, hiç fazla güvenmeye gelmez.

Şunu da belirtiyim ki, yetişkin nevrozlulann psikanalitik tedavisi konusunda henüz bütün görüş açılarını ele geçirmiş değiliz. Uygarlık nerdeyse katlanılmaz bir baskı yapıyor üzerimizde bizden bir yaşamsal düzeltme gitmemizi istiyor, içinde bulunduğu güçlüklerle rağmen psikanalizin insanları böyle bir düzeltme hazırlayabileceğini ummak bilmem pek hayali bir şey midir? Belki günün birinde bir Amerikalı'nın aklına eser de biraz para harcar ve ülkesindeki social vwork-er'lerin* psikanalitik bir eğitimden geçirilmelerini ve uygarlık nevrozlarıyla savaşıacak bir yardımcı ekip olarak yetiştirmelerini sağlar.

* Hastayla ailesi ya da çalıştığı yer arasındaki ilişkileri düzenlemeyi amaçlayan Sosyal Hizmet Görevlileri (Ç.N.)

"Ha ha, desenize yeni bir selâmet ordusu*"

Neden olmasın? Diyelim ki hayalimiz her vakit geçmişteki modellere göre çalışır. Böyle bir şey gerçekleştiği zaman öğrenme tutkusuyla dolu kimselerin Avrupa'ya akan seli Viyana'ya uğramadan geçip gidecek, çünkü buradaki psikanaliz çalışmaları vaktinden önce konulmuş bir yasak travmasının kurbanı olacaktır. Bakıyorum gülünmüyorsunuz? Sizin vereceğiniz karar etkilemek için söylüyor değilim bunları, gerçekten böyle bir amaç için söylüyor değilim. Nihayet bana inanmadığınızı biliyorum; beri yandan, ilerde bunun böyle olacağı konusunda size güvence de veremem. Ancak, bildiğim bir şey var ki, o da şu: Sizin amatör psikanaliz sorununda vereceğiniz karar hiç de pek önemli değil. Nihayet yerel bir etki gösterebilir bu karar. Ama psikanalizin iç gelişim olanakları kararname ve yasaklarla etkilenecek gibi değildir ve işin önemli yanı da budur.

* Ing. Salvation Army; 1865'de NVilliam Booth tarafından temeli atılmış Hristiyanlık örgütü; örgütün merkezi Londra'da olup, yoksullara, evsiz barksız kimselere, tutukevlerinden salı verilenlere, alkoliklere yardım amacı güder, kendi hastaneleri ve çocuk bakımevleri vardır; bir de dergi çıkaran örgütün askerî bir yapısı vardır (Ç.N.)

Şimdi buradaki tartışmalara kaynaklık eden küçük yazımın kaleme alınmasına doğrudan doğruya yol açan neden, hekim olmayan bir meslekdaşımız Dr. Reik'in şarlatan hekimlik suçlamasıyla Viyana makamlarınca mahkemeye verilişiydi. Bütün koğuşurmalar yapıldıktan ve çeşitli bilirkişi raporlarına başvurulduktan sonra bir dava açılmasına gerek görülmediği sanırım hepinizce bilinmektedir. Ancak bunun benim kitabın bir başarısı olduğunu sanmıyorum; durum bir dava açılması için pek elverişli değildi anlaşılan, ayrıca tedaviden zarar gördüğü gerekçesiyle Dr. Reik'i yetkili makamlara şikâyet edene öyle pek sözüne güvenilir biri diye bakılamayacağı anlaşılmıştı. Dr. Reik'a karşı sürdürülen soruşturmanın durdurulması, ihtimal Viyana mahkemesinin amatör psikanalistler sorununda ilkesel bir karar anlamına gelmektedir. Ben Amatör Psikanalistler adındaki yazımda "tarafsız dinleyici" kahramanını yarattığım zaman, hayalimde bizim yüksek görevlilerden birinin, kendisiyle Causa Reik üzerinde bir konuşma yaptığım ve isteğine uyarak bu konuda özel bir rapor sunduğum iyi niyet sahibi ve pek olgun bir adam vardı. Konuşmamızda bu adama görüşümü benimsetmeyi başaramadığımı biliyordum, dolayısıyla kitabımda kendisine yer verdiğim tarafsız kişiyle ikili konuşmamızı da bir anlaşmayla sonuçlandırmaktan kaçındım.

Ayrıca amatör psikanalizi konusunda psikanalistlerin bir birlik içerisinde ortak bir tutum takınmalarını sağla-

* Amatör Psikanalizi ilk kez kitap halinde 1926'da, Ek bölüm ise ilk kez 1927'de The International Journal of Psycho-Analysis dergisinde yayınlandı.

yabileceğini ummuş değilim. Dergideki Macaristan Psikanaliz Derneği'nin bu konudaki görüşüyle New York Psikanaliz Derneği'nin görüşü dikkate alınır, belki benim yazımın hiç bir sonuç vermediği, herkesin daha önce savunduğu bakış açısını elden çıkarmak istemediği gibi bir izlenime kapılınacaktır. Ancak ben bunun da doğruluğuna inanmıyorum. Bana göre, birçok meslekdaş aşın tekyanlılıklarında biraz yumuşamaya gitmiş, çokları da amatör psikanalizi sorunun geleneksel kurallara göre çözümlenemeyeceği, bu sorunun yeni bir durumdan doğduğu, dolayısıyla yeni bir usa vurmayı gerektirdiği konusundaki görüşümü benimsemişlerdir.

Ayrıca, bütün sorunu yeni bir ışık altında ortaya koyuşum da takdir görmüşe benziyor. Hani ben işin önemli yanının psikanalistin elinde bir hekim diploması bulunup bulunmadığı değil, psikanaliz uygulaması için gerekli bir öğrenim ve eğitimden geçip geçmediği olduğuna baş köşede yer vermiştim. Meslekdaşlar tarafından hararetle tartışılan en uygun psikanaliz öğreniminin hangisi sayılmak gerektiği sorunu da benim için bu saptamadan aldığı kaynağını. Benim görüşüm, üniversitenin geleceğin hekimlerini yükümlü kıldığı öğrenime en uygun öğrenim diye bakılamayacağı yolunda idi ve şimdi de hâlâ bu tezi savunmaktayım. Mademki amatör psikanalizler faaliyetten alıkonamayıp, kendilerine karşı açılan savaşla kamudan destek görülemiyor, bu durumda onlara öğrenim ve eğitim fırsatının sağlanması, üzerlerinde bir etki olanağının ele geçirilmesi, faaliyetlerine hekim derneği tarafından izin verilmesi, psikanaliz çalışmalarında onların da katkılarına başvurularak uğraşlarında teşvik edilmeleri, dolayısıyla ahlaksal ve ussal düzeylerini yukarı bir aşamaya ulaştırma konusunda içlerinde tutkular uyandırılması ve böylelikle onların da varolduğu gerçeğinin dikkate alınması daha yerinde bir davranış sayılmak gerekmez mi?